

VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03.2025
VALIDADE: 24 MESES

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR/ GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - GRO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS



DIREITOS RESERVADOS

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA POR QUALQUER
MEIO SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA E REGISTRADA DO AUTOR CONFORME LEI
9610/1998.

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

   @seconcigoias

SUMÁRIO

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR	5
2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO	5
3. DADOS CRONOLÓGICOS E ATUALIZAÇÃO	6
4. MEMORIAL DESCRITIVO	6
4.1. DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS	7
4.1.1. SUBSOLO	7
4.1.2. TÉRREO	7
4.1.3. 1º PAVIMENTO	7
4.1.4. 2º PAVIMENTO	7
5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / LOCALIZAÇÃO	8
5.1. LOCALIZAÇÃO	8
6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR / (ORGANOGRAMA)	9
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO	9
7.1. INTRODUÇÃO	9
7.2. BASE LEGAL:	10
7.3. A ORGANIZAÇÃO DEVE, ATRAVÉS DO PGR:	11
7.4. A ORGANIZAÇÃO DEVE ADOTAR MECANISMOS PARA:	11
7.4.1. Fluxograma do mecanismo – Seconci Goiás	12
7.4.2. Conteúdo a ser utilizado no formulário para o mecanismo de pesquisa:	12
7.4.3. Meios recomendados para veiculação das informações:	13
7.5. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.	14
8. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	14
8.1. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	14
8.2. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	15
8.3. <i>Metodologia de classificação e matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE</i>	16
8.3.1. Grupo homogêneo de Exposição (GHE)	16
8.3.2. Processo de análise e avaliação de riscos	16

8.3.3.	Controle dos riscos.....	16
8.4.	INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA	17
8.4.1.	Variáveis consideradas na análise matricial de riscos.....	17
8.4.2.	Avaliação de riscos.....	17
8.4.3.	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - MATRIZ:	22
8.4.4.	AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	22
9.	AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)	23
10.	PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25
11.	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS.....	25
12.	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – NR 32	26
12.1.	Importantes medidas de proteção.....	27
12.2.	Vestimentas:	28
12.3.	Capacitação:	28
12.4.	Vacinação dos Trabalhadores:	28
12.5.	Radiações ionizantes	28
12.6.	Resíduos:	32
12.7.	Refeitório:	33
12.8.	Limpeza e conservação	33
12.9.	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	33
13.	CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	34
13.1.	Procedimento a ser executado quando do início da tercerizada	34
13.1.1.	Documentos Obrigatórios Antes do Início das Atividades	34
13.2.	Os trabalhadores que irão executar atividades de risco	36
13.2.1.	Definição de Atividades de Risco	36
13.2.2.	Documentação Adicional Exigida	36
13.3.	Procedimento a ser executado mensalmente.....	36
13.3.1.	Atualização de Movimentação de Pessoal.....	37
13.3.2.	Documentos de SST Atualizados.....	37
13.3.3.	Prazo e Forma de Entrega.....	37

13.4.	Auditoria dos documentos	37
13.4.1.	CrITÉRIOS de Auditoria.....	37
13.4.2.	Atualização de Programas e Laudos	38
13.5.	Registros	38
13.5.1.	Relatório de Auditoria Inicial	38
13.5.2.	Relatório Mensal de Acompanhamento	38
13.5.3.	Controle de Documentos.....	38
13.6.	GESTÃO CONTINUA E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO	39
13.6.1.	Estratégia de Gerenciamento de Riscos de Terceiros.....	39
13.6.2.	Procedimento de Auditoria Periódica e Atualização	39
13.6.3.	Integração de Segurança	41
14.	INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES	41
15.	ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES	42
16.	SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS	42
17.	AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.....	42
18.	CUMPRIMENTO DAS DEMAIS NORMAS.....	43
19.	PROFISSIONAL HABILITADO.....	43
20.	DOCUMENTOS INTEGRADOS	43
20.1.	INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS	43
20.2.	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS	43
20.3.	INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS	43
20.4.	PLANO DE AÇÃO	43
20.5.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EPIS.....	43
20.6.	CRONOGRAMA DE PALESTRAS	43
20.7.	FORMULÁRIOS PARA CONTROLE DE TERCEIRIZADOS	43
21.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Nome:	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Título:	Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Cargo:	Coordenador de Segurança do Trabalho – SECONCI GOIÁS
Registro:	CREA – GO n.º 1016723644D-GO
ART nº	1020250266371
Contato	62 9 9430-0089
Contato	62 3250-7544
E-mail	coord.seguranca@seconcigoias.com.br

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Com a finalidade de desvincular toda e qualquer previsibilidade total e não criar documentos “genéricos” o documento foi focado no cumprimento das Normas Regulamentadoras, em específico nas metodologias e contemplações citadas na 01 quanto ao Programa de Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Quanto ao processo construtivo, em relação aos perigos, riscos, inventários e agregados, este documento foi realizado e continuará a ser atualizado, **revisado sempre que necessário ou renovado após 2 anos** para que sejam observadas todas as características reais, bem como, otimização de todas as ações (metodologia PDCA, 5W2H e demais ferramentas também utilizadas na gestão da qualidade, voltadas totalmente para a prevenção de acidentes, doenças e assédios originados no trabalho.

3. DADOS CRONOLÓGICOS E ATUALIZAÇÃO

TABELA DE REVISÕES		
Mês/Ano: 03/2025		Paginação 1 de 1
Número Revisão	Capítulo Revisão	Histórico de Revisão
Rev. 00 – Elaboração	19.03.2025	00
Rev. 01	27.08.2025	Atualização do responsável técnico
Rev. 02	08.09.2025	Atualização do responsável técnico
Rev. 03	01.04.2026	Atualização texto base e inventario

GESTÃO DE VERSÃO DOCUMENTAL	
Mês/Ano	Descrição
27.08.2025	Substituição do responsável técnico Juliano Lacerda Siqueira p/ Drª Patricia Montalvo Moraes
08.09.2025	Substituição do responsável técnico Drª Patricia Montalvo Moraes p/ Engº Adriano Augusto
01.04.2026	Inclusão de funções ausentes no inventário (Coord. Desenvolvimento Humano Social, Subcoordenadora Odontológica, Fonoaudiólogo; Analista Administrativo de Patrimônio); Realocação do Estagiário de Fisioterapia do GHE 17 para GHE 11; Revisão dos EPLs do GHE 17; Identificação do tipo de vínculo dos trabalhadores (CLT/Terceirizado); Inclusão dos inventários de riscos dos prestadores de serviço (Laboratório, Limpeza, Segurança Patrimonial e Radiologia); Reformulação integral da Seção 12.5 — Radiações Ionizantes (inclusão de equipamento extraoral) — Conforme NR-01, NR-32, RDC 611/2022 e demandas de adequação identificadas. Inclusão da Seção 13.6 — Situação documental dos PGRs vencidos das terceirizadas com cronograma de regularização; Inclusão da Seção 9A — AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT) conforme NR-01 Portaria MTE nº 1.419/2024, com referência ao PGR modelo SECONCI GOIÁS; atualização do inventário de riscos para contemplar riscos psicossociais em todos os GHEs

4. MEMORIAL DESCRITIVO

O SECONCI GOIÁS é composto por 01 (um) edifício, com 04 (quatro) pavimentos, sendo subsolo, térreo, 1º e 2º andar além da casa de máquinas dos elevadores, barrilete, reservatórios superior, inferior e reserva técnica.

4.1. DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS

4.1.1. SUBSOLO

Na área do subsolo estão os seguintes itens detalhadamente:

Vagas para veículos: 13 (treze) vagas de garagem privativas para veículos de passeio, das quais 07 (sete) são vagas individuais e 06 (seis) são vagas duplas de gaveta. Todas as vagas são cobertas. Não há vagas para visitantes.

Escaninho/Depósito: para guarda e depósito de materiais.

Acesso de veículos: a instituição possui 01 (um) portão de entrada e saída de veículo.

Reservatório inferior com bomba: barrilete inferior.

4.1.2. TÉRREO

Na área do térreo estão os seguintes itens detalhadamente:

Acesso de pedestres: dá-se através de um portão pela calçada da instituição.

Características: nesse pavimento estão localizados:

- **Área de projeção da instituição do térreo:** 02 (duas) salas de espera/ 01 (uma) recepção/ 01 (um) guichê de atendimento da recepção/ 01 (um) sanitário feminino/ 01 (um) sanitário masculino/ 01 (um) sanitário para portador de necessidades especiais (PNE)/ 01 (uma) circulação recepção/ 02 (duas) salas da audiometria/ 01 (um) arquivo/ 01 (uma) circulação interna para consultórios médicos/ 01 (um) DML/ 08 (oito) consultórios médicos, sendo 02 (dois) com banheiros/ 01 (uma) sala de serviço social com banheiro/ 01 (um) banheiro feminino / 01 (um) banheiro masculino/ 01 (um) laboratório com área de espera e banheiro/ 01 (uma) circulação hall de elevador/ 01 (um) elevador/ 01 (um) vestiário banheiro feminino/ 01 (um) vestiário banheiro masculino / 01 (uma) sala de descanso de funcionários/ 01 (uma) copa e refeitório/ 01 (uma) escada de acesso interno dos funcionários.

4.1.3. 1º PAVIMENTO

Na área do 1º pavimento estão os seguintes itens detalhadamente:

Características: nesse pavimento estão localizados:

- **Área de projeção da instituição do 1º pavimento:** 01 (uma) sala da coordenação da odontologia/ 01 (uma) recepção odontologia/ 01 (uma) sala de espera/ 01 (um) sanitário feminino / 01 (um) sanitário masculino/ 01 (um) centro de processamento de dados (CPD)/ 01 (um) consultório cardiologia / 01 (um) sala para exame de holter e mapa/ 01 (uma) circulação/ 01 (uma) sala de espirometria/ 01 (uma) sala de raio x / 01 (uma) sala de fisioterapia/ 01 (uma) sala de telefonia – PABX/ 01 (uma) sala de escovação/ 01 DML / 01 circulação consultórios odontologia/ 06 (seis) consultórios odontologia/ 01 (uma) esterilização / 01 (um) expurgo/ 01 (um) sanitário feminino/ 01 (um) sanitário masculino/ 01 (uma) área de segurança do trabalho com banheiro/ 01 (um) almoxarifado/ 01 (uma) circulação hall elevador/ 01 (uma) administração com copa e sanitário/ 01 (um) sanitário gerente administrativo.

4.1.4. 2º PAVIMENTO

Na área do 2º pavimento estão os seguintes itens detalhadamente:

Características: nesse pavimento estão localizados:

- Área de projeção da instituição do 2º pavimento: 01 (uma) sala da diretoria/ 01 (uma) circulação hall elevador/ 01 (um) auditório/ 01 (um) espaço de convivência eventos/ 01 (um) sanitário feminino / 01 (um) sanitário masculino.

Existe ainda um reservatório superior /barilete/reserva técnica.

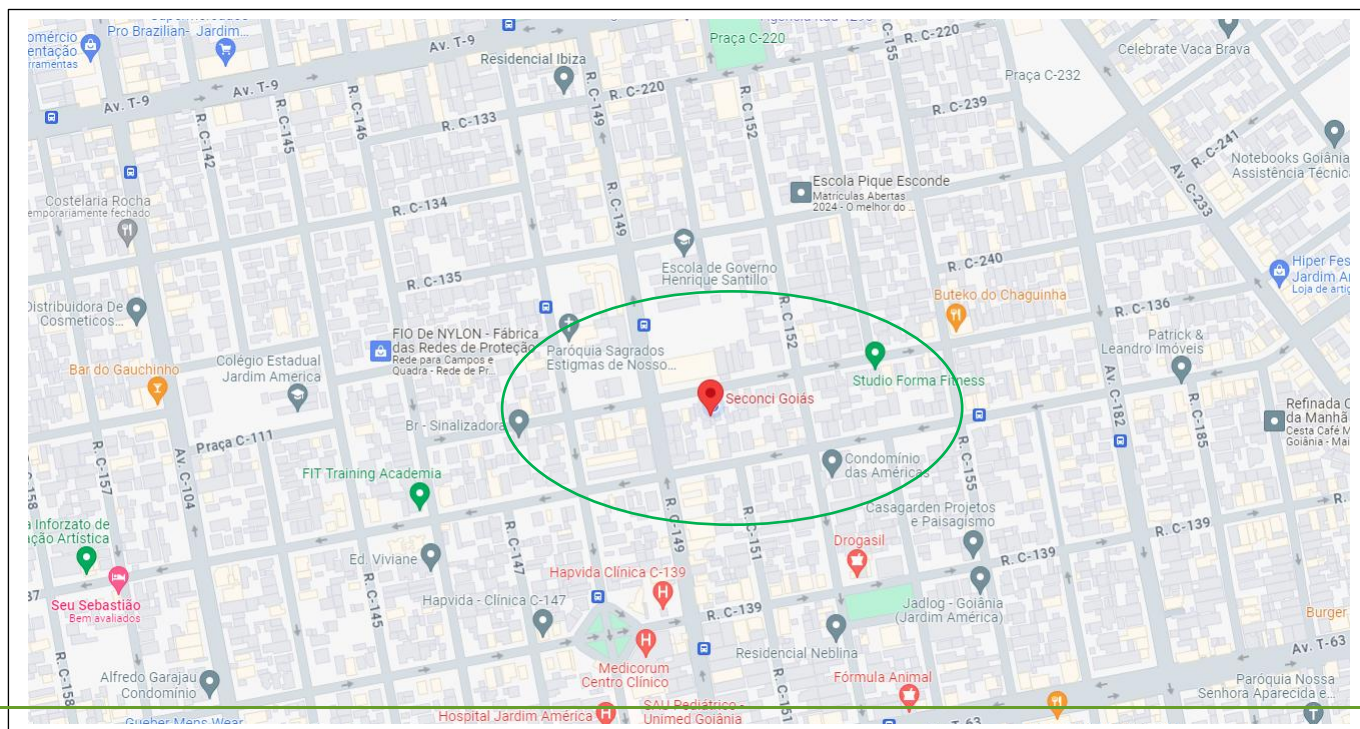
Cada um dos pavimentos tipo possui 01 (um) hall que dá acesso ao elevador com acesso lateral à escada.

No subsolo também está instalado o QDG (quadro de distribuição geral) e o quadro da rede fotovoltaica.

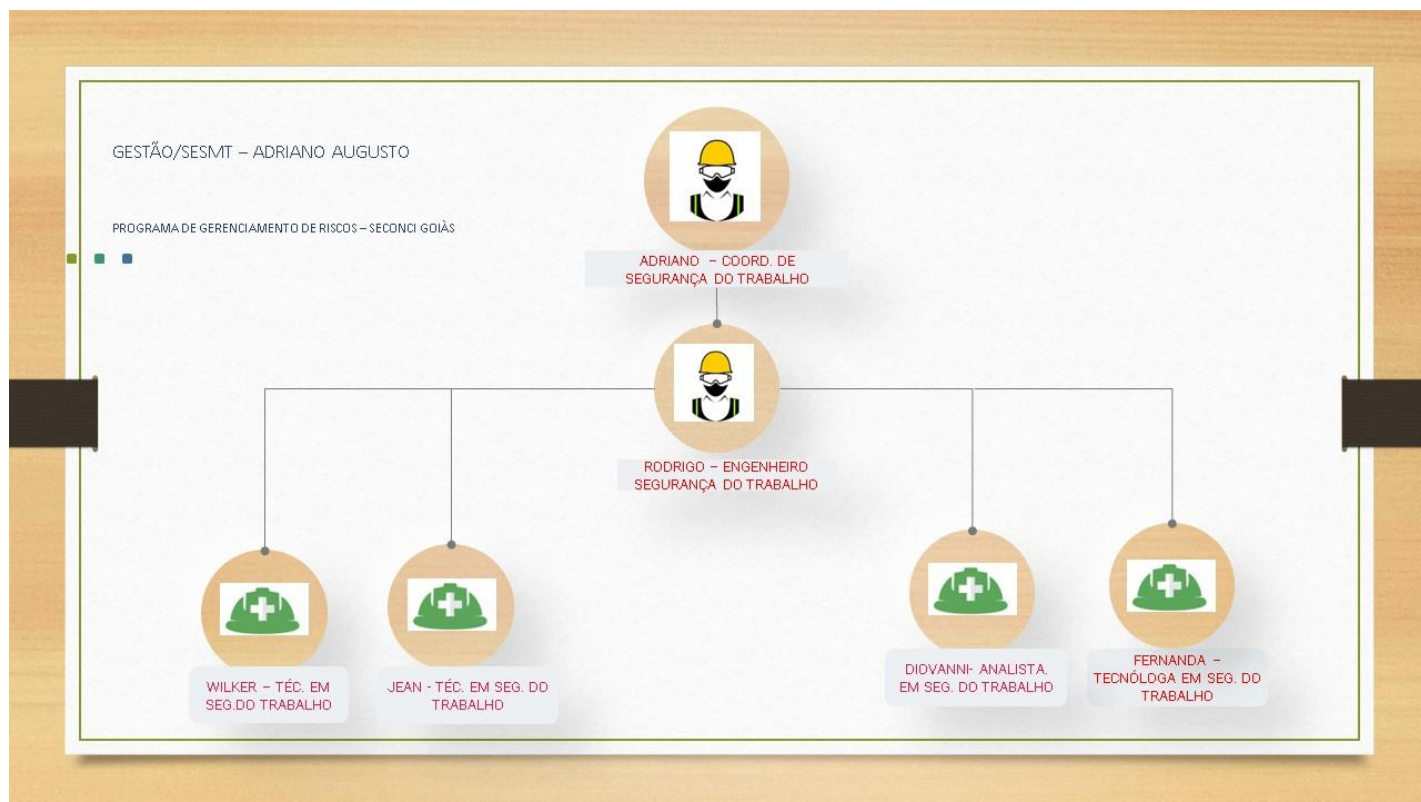
5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / LOCALIZAÇÃO

Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás
CNPJ:	36.863.637/0001-59
Atividade Principal/CNAE :	86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Grau de Risco:	3
Endereço:	Rua C-136, nº681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América Goiânia- GO CEP: 74275-050 Goiânia-GO
Horário de Trabalho:	Segunda a sexta-feira das 06:30 às 19:00 horas
Representante da empresa:	Bruno Alvarenga de Menezes
Responsável pelo acompanhamento e informações para elaboração do PGR	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Responsável pela implementação das ações, monitoramento e acionamento em caso de atualizações, dúvidas e afins:	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

5.1. LOCALIZAÇÃO



6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR / (ORGANOGRAMA)



7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO

7.1. INTRODUÇÃO

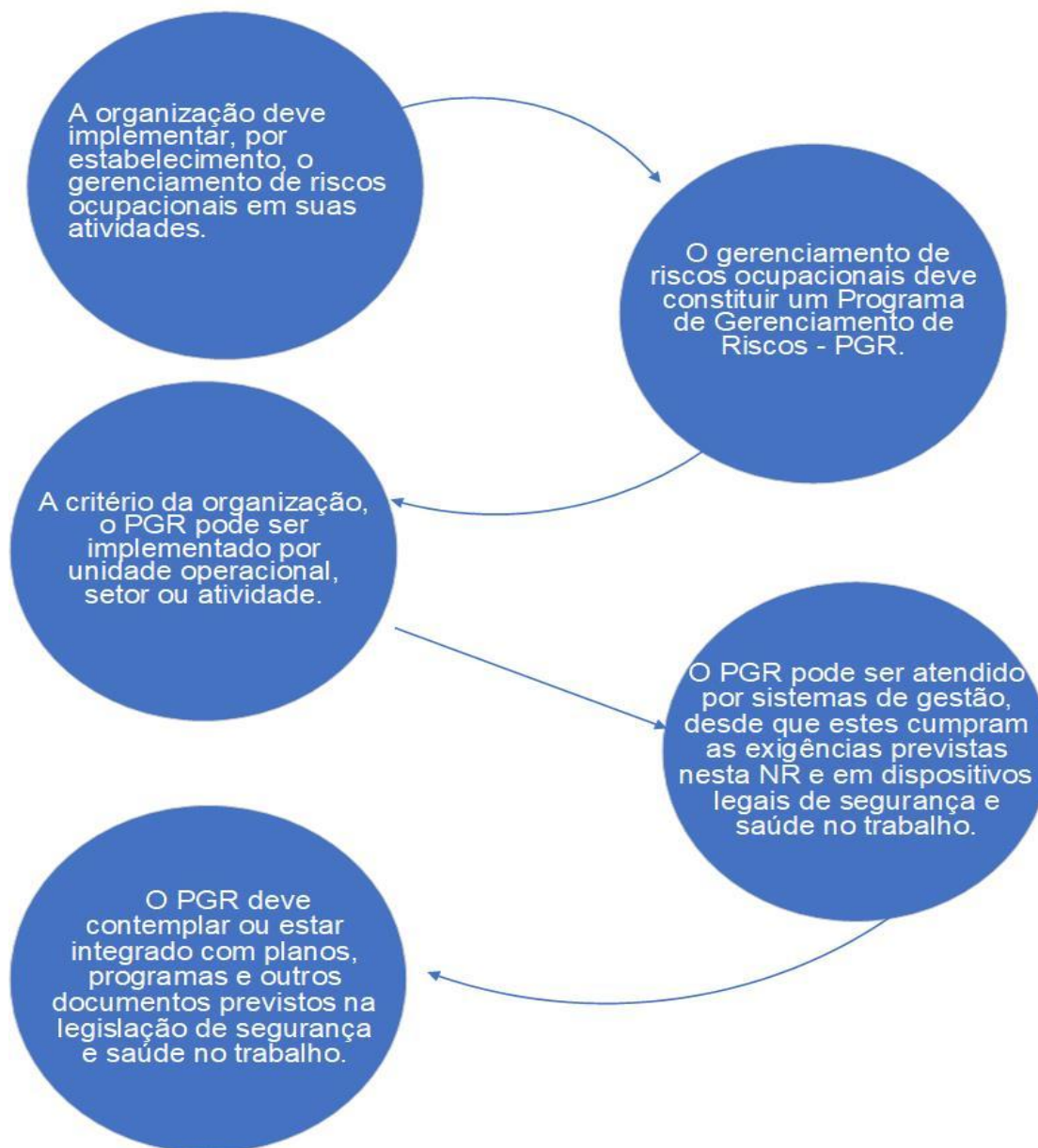
Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os requisitos da Norma Regulamentadora (NR) I, com redação dada pela Portaria SEPRT n' 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2020.

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

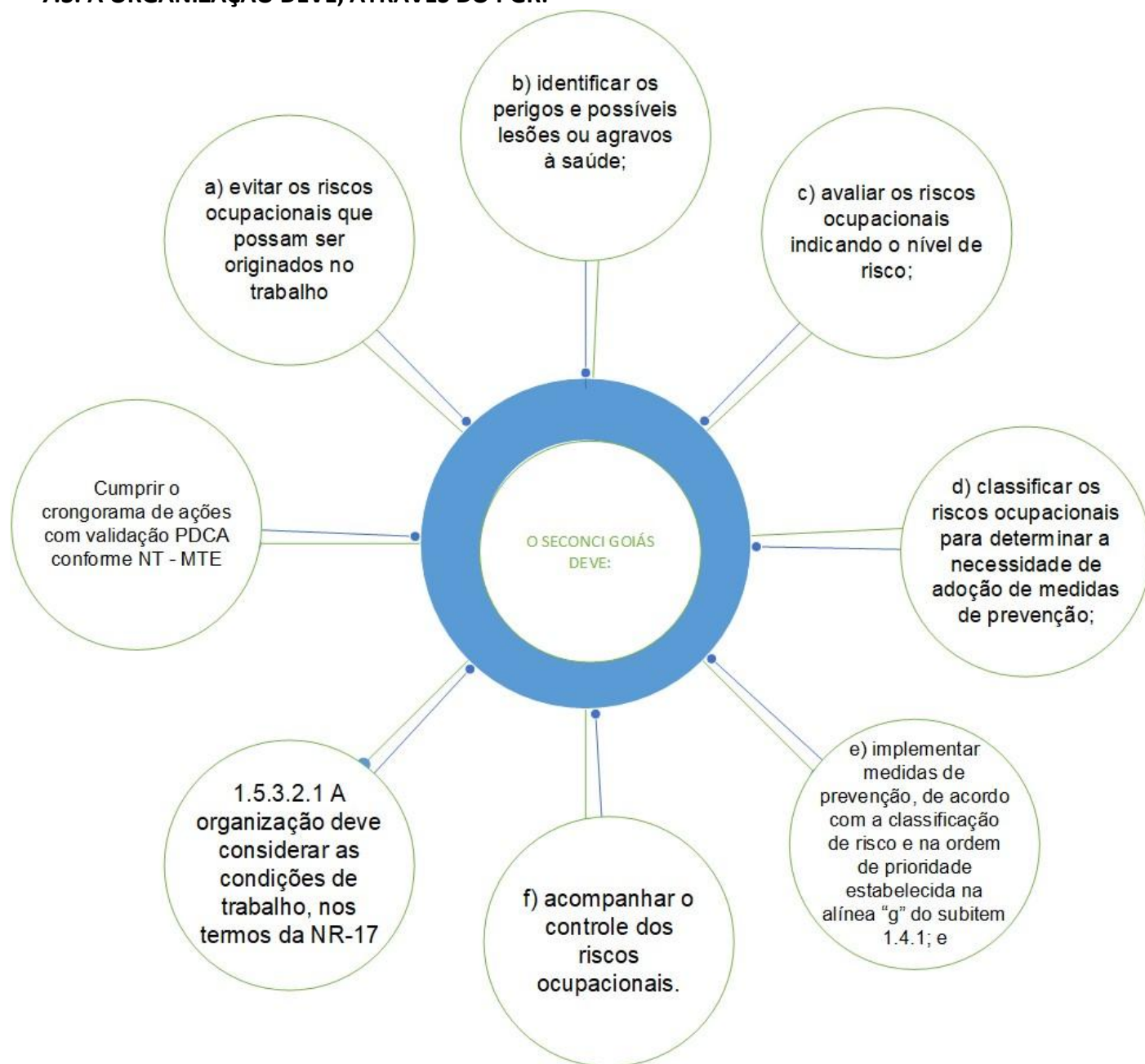
7.2. BASE LEGAL:

Todos os requisitos da NR 01 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos, as responsabilidades de âmbito geral:

Responsabilidades de âmbito geral (NR 01)



7.3. A ORGANIZAÇÃO DEVE, ATRAVÉS DO PGR:



7.4. A ORGANIZAÇÃO DEVE ADOTAR MECANISMOS PARA:

consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA,

quando houver;

7.4.1. Fluxograma do mecanismo – Seconci Goiás

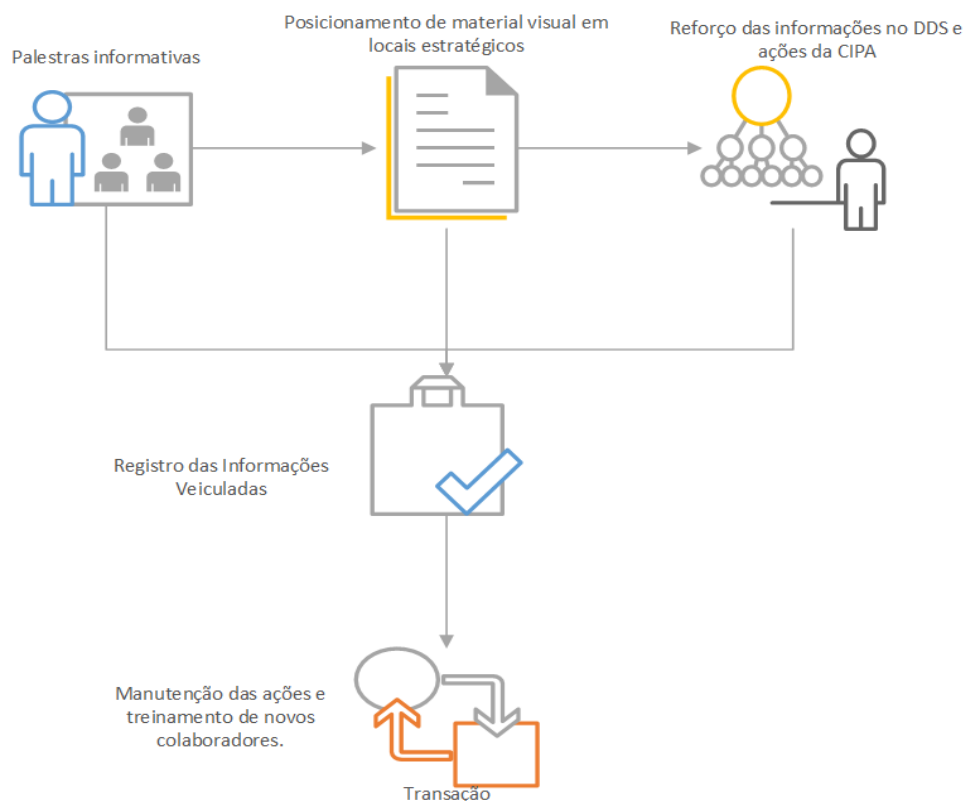
7.4.2. Conteúdo a ser utilizado no formulário para o mecanismo de pesquisa:



- ✓ *Você tem conhecimento sobre os riscos aos quais está exposto no ambiente de trabalho? Comente sobre eles.*
- ✓ *Você sabe o que são medidas de proteção coletiva e individuais? Cite 2 proteções de cada.*
- ✓ *Cite quais são os Equipamentos de Proteção Individuais que precisa usar no dia-a-dia.*
- ✓ *Você recebeu treinamento na empresa para as atividades? Sabe quais são os procedimentos?*
- ✓ *Cite dois treinamentos que tenha recebido (caso a resposta seja positiva)*
- ✓ *Você sabe o que é uma condição impeditiva de trabalho? Explique (se possível) com suas palavras ao menos uma da sua atividade.*
- ✓ *Na sua visão, quais poderiam ser as melhorias para a proteção e trabalho seguro?*
- ✓ *Na sua visão, quais equipamentos de trabalho poderiam trazer mais segurança?*

comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

7.4.3. Meios recomendados para veiculação das informações:

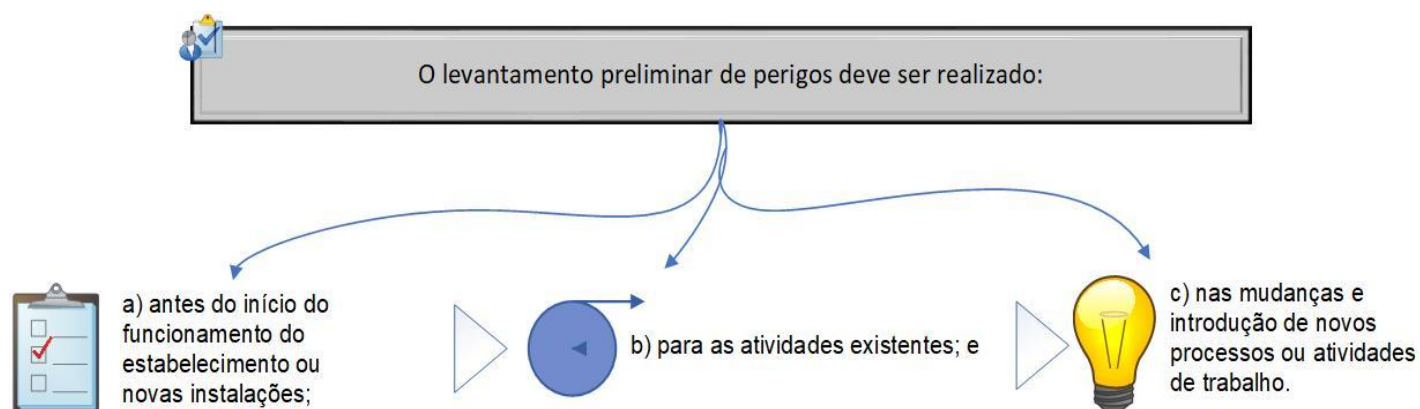


7.5. A ORGANIZAÇÃO DEVE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO EM SST.

Adotar indicadores de saúde e segurança e a partir dos resultados medidos elaborar planos de ação utilizando a ferramenta da gestão 5W2H:

8. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

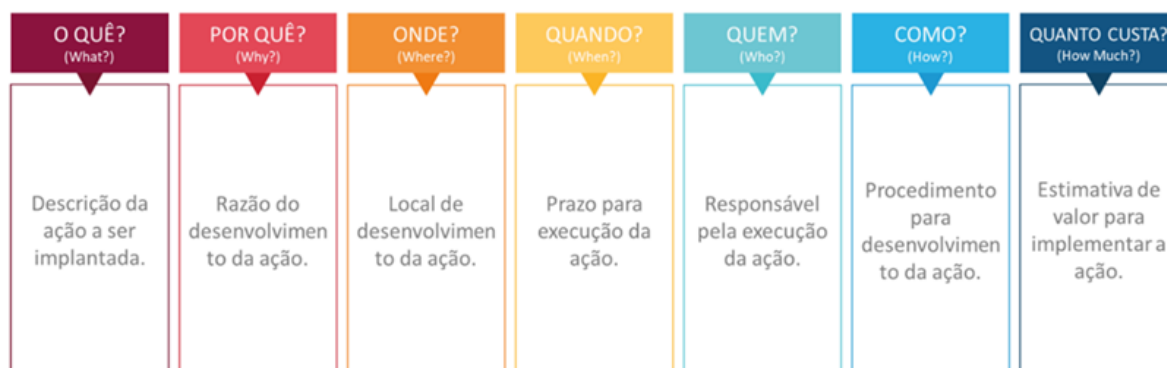
O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.



Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

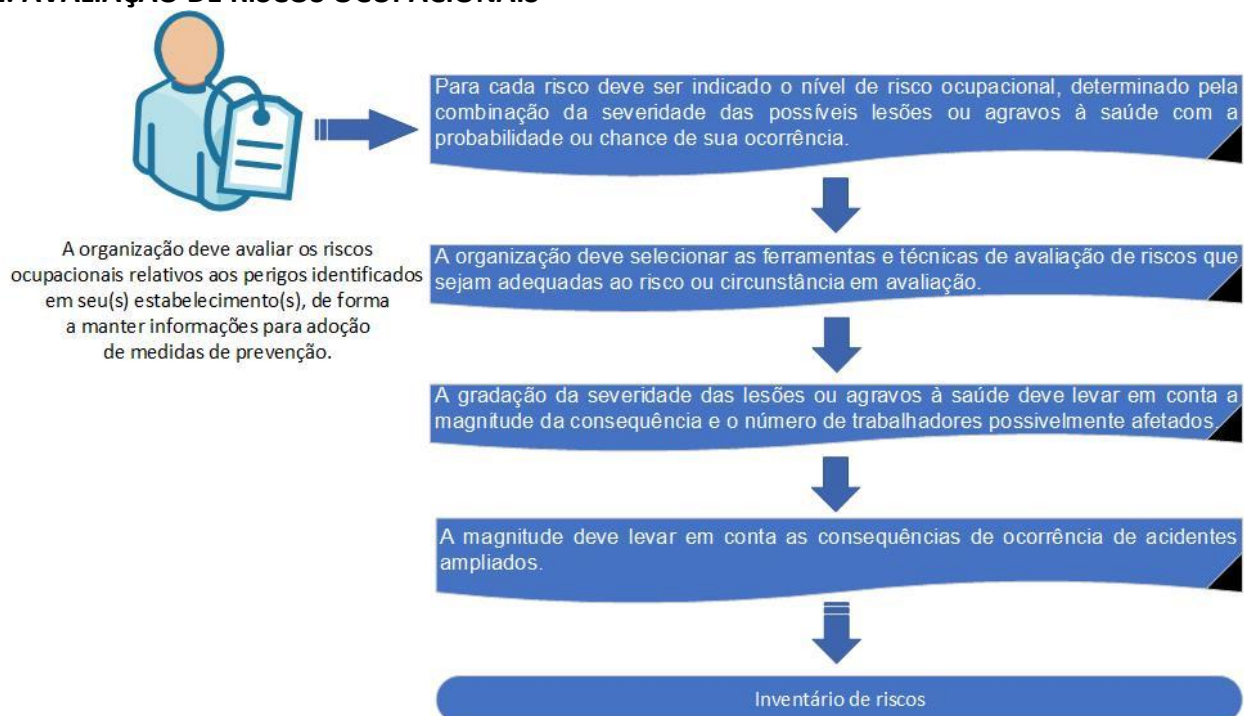
A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos

8.1. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS





8.2. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS



8.3. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO E MATRIZ/INVENTÁRIO DE RISCOS POR GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – GHE

8.3.1. Grupo homogêneo de Exposição (GHE)

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto é corresponde ao um grupo de trabalhadores engajados em atividades semelhantes. Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco (EMR) e generalizar para todo o grupo.

Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco EMR quando aplicável e generalizar para todo o grupo.

8.3.2. Processo de análise e avaliação de riscos

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e, excepcionalmente, ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

8.3.3. Controle dos riscos

Medidas de prevenção

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem citado;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

8.4. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA

8.4.1. Variáveis consideradas na análise matricial de riscos

Termos, nomenclaturas e definições utilizadas; Condições de Operação (O):

Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente.

Classificação:

Normal (N) – Atividade de rotina;

Eventual (E) – Atividade não rotineira;

Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência

Temporalidade (T):

Situação da atividade analisada de forma temporal.

Classificação:

Corrente (C) – Atividade já existente;

Planejada (P) – Não iniciada;

8.4.2. Avaliação de riscos

A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos. A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontece um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.

Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

$$R = P \times S$$

Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade. O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

Definição dos critérios de avaliação qualitativa da probabilidade Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.

Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP):

Avalia o tempo ou exposição a determinado perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC):

Avalia a extensão das proteções ou tipologia de prevenções adotadas pela empresa.

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP):

Mede a compreensão com que as pessoas são capazes de identificar o perigo.

Número de Pessoas Expostas (PE):

Avalia a extensão em relação a quantidade de operários expostos ao perigo.

P = EP + EC + CP + PE [Cálculo da Probabilidade (P)]

As categorias de classificação e os critérios de avaliação são:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP)		
Eventual	Intermitente	Contínuo
✓ Baixa exposição ou frequência. Classificação conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição inferior a 15% da jornada de trabalho com adoção de medidas de controle; ✓ Baixa exposição ao Limite de Exposição Ocupacional LEO. (< a 10%).	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica, mas não continuada, com intervalos regulados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição entre 16% a 65% da jornada de trabalho com uso proteção individual ou coletiva. ✓ Exposição próxima ao Limite de Exposição Ocupacional - LEO ou Nível de Ação NA.	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica e contínua com poucos intervalos apontados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição acima de 65% da jornada de trabalho sem comprovação técnica da eficácia das medidas de controle. ✓ Exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional – LEO.

Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03
Eficácia das medidas de controle (EC)		
Eficaz	Variável	Precário
Medidas de controle capazes de atuar mesmo com distração ou desvio comportamental com ato inseguro do trabalhador.	Medidas de controle que possam evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude, posicionamento ou implantação de quem executa.	Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP)		
Simple	Moderado	Complexo
✓ Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência ou conhecimento da atividade é capaz de identificar o perigo existente na atividade. ✓ Quando, no GHE, a equipe possuir nível de interpretação e leitura compatível com a sinalização e que essa esteja de forma visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo.	✓ Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência, nível de escolaridade básico (leitura e interpretação).	✓ Se o perigo deverá ser analisado por meio sistêmico, equipe técnica específica, uso de documentos de suporte como: análise de risco, permissão de trabalho ou instrumentos de medição apropriados.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Número de Pessoas Expostas (PE)		
Pequeno	Médio	Grande
✓ Número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a menos que 20% do efetivo do grupo (GHE).	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for superior a 20% do efetivo e inferior a 80% do efetivo.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo excede a 80% do efetivo.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Na definição dos critérios qualitativos da Severidade, as variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caso ele ocorra e a abrangência deste acidente em termos de impacto nas pessoas.

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da severidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.

A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV):

Avalia a possível consequência no indivíduo.

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

S = GV + EA [Cálculo da Severidade(S)]

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV)			
Baixa	Média	Alta	Extrema

✓ Se a lesão, doença ou dano for inexistente ou sem necessidade de atendimento específico, tais como (exemplo): Lesões superficiais, arranhões, irritação simples nos olhos, desconforto rápido ou temporário, infecções passageiras, irritações e incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros ou sem necessidade de atendimento.	✓ Se a lesão resultar em desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho, tais como (exemplo): Corte ou queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como polpa de dedo ou unha. Dermatitis, doenças de pele ou agregados de simples tratamento. Lesões a médio e longo prazo incapacitantes como surdez, cegueira, LER/DORT, doenças agudas provocadas por exposição ao agente. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cujas medidas de controles são efetivas.	✓ Se houver potencial para danos severos, tais como (exemplo): Amputações, esmagamentos, fraturas múltiplas, queimaduras de segundo ou terceiro grau e/ou generalizadas. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, mas cuja medidas de controles não possuem efetividade comprovada.	✓ Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas, incapacitantes ou morte por curta exposição ou alto risco. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cuja medidas de controle não foram identificadas.
Graduação para cálculo (peso)			
01	03	06	09

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA)

Isolada	Limitada	Ampla
✓ Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades ou Grupo Homogêneo de Exposição GHE, e/ ou; ✓ Em caso apenas de perda material na atividade	✓ Se a lesão ou doença pode ou não abranger mais de um Grupo Homogêneo de Exposição, mas se limita aos trabalhadores da empresa; ✓ Em caso de perda material que possa afetar a área onde	✓ Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pedestres que circulam próximo ou no raio que possa ser atingido, e/ou; ✓ Em caso de perdas materiais

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

relacionada.	ocorreu, sem prejuízo a terceiros (pedestres, veículos, vizinhos a empresa, edificações ou instituições diversas)	quando elas podem afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros (veículos, vizinhos a empresa, edificações ou instituições diversas).
Graduação para cálculo (peso)		
01	03	05

8.4.3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - MATRIZ:

SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168
Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco								
Até 36 = Tolerável									
Até 56 = Moderado									
Até 98 = Substancial									
> 98 = Intolerável									

8.4.4. AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário.
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.

Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido.

9. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

9A.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A NR-01, atualizada pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (vigência em 26/05/2026, conforme Portaria MTE nº 765/2025), passou a exigir expressamente que o gerenciamento de riscos ocupacionais abranja, além dos riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes, os **riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho** (item 1.5.3.1.4).

Adicionalmente, a NR-01 atualizada prevê que:

- "A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17, **incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho**" (item 1.5.3.2.1);
- A avaliação de risco para fatores ergonômicos e psicossociais "deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas" (item 1.5.4.4.5.3);
- A NR-17, item 17.3.1.2, permite que a Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) seja "contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da NR-01".

9A.2. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 Art. 17.3.1.2

O inventário de riscos do Seconci Goiás contempla a Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) para todos os GHEs, abrangendo os seguintes aspectos:

Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia

Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar

Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador

Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia

Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho - obrigatório a partir de 26/05/2026

9A.3. FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT) — IDENTIFICAÇÃO PARA O SECONCI GOIÁS

Em avaliação - ***obrigatório a partir de 26/05/2026***

9A.4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS FRPRT

A avaliação dos fatores de risco psicossociais seguirá a seguinte abordagem:

Etapa 1 — Levantamento Preliminar (AEP):

Identificação dos FRPRT potenciais por GHE, conforme quadro acima, integrada ao Inventário de Riscos (Seção 20.1). Classificação preliminar do nível de risco na Matriz (Seção 8.4.3), considerando a Probabilidade de ocorrência de agravo à saúde mental e a Severidade das possíveis consequências (transtornos de ansiedade, depressão, Burnout, DORT associada a estresse, etc.).

Etapa 2 — Aplicação de Instrumento Validado:

A organização adotará, preferencialmente, o **COPSOQ III** (Copenhagen Psychosocial Questionnaire — versão brasileira validada) ou instrumento equivalente reconhecido pela comunidade científica, conforme recomendação do Guia de Riscos Psicossociais do MTE. A aplicação será realizada de forma anônima, garantindo a confidencialidade das respostas. Periodicidade mínima: **anual**.

Etapa 3 — Análise e Classificação:

Os resultados serão consolidados e classificados na Matriz de Risco deste PGR (Seção 8.4.3). Fatores classificados como **Moderado ou superior** exigirão elaboração de Plano de Ação específico (Seção 20.4) e, quando aplicável, contratação de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado (NR-17 item 17.3.1.3).

Etapa 4 — Medidas de Prevenção:

As medidas de prevenção para os FRPRT seguem a hierarquia da NR-01 item 1.4.1, alínea "g", e podem incluir:

- Eliminação/Substituição: reorganização de processos que eliminem fontes de sobrecarga ou ambiguidade;
- Controles organizacionais: rodízio de funções, pausas regulamentadas, flexibilização de jornada, canais de comunicação eficazes, programas de acolhimento;

- Controles administrativos: capacitação de lideranças em gestão de pessoas, política antiassédio (NR-05, Portaria MTP nº 4.219/2022), DDS sobre saúde mental;
- Suporte individual: Programa de Apoio ao Trabalhador (PAT), encaminhamento para atendimento psicológico, articulação com o PCMSO para monitoramento da saúde mental.

Etapas 5 — Monitoramento e Retroalimentação:

Os indicadores de FRPRT serão acompanhados conforme Seção 7.5 deste PGR (Indicadores de SST), incluindo:

- Taxa de absenteísmo por causas psicossociais (CID's F00-F99);
- Resultado consolidado do COPSOQ III (ou instrumento equivalente) — tendência anual;
- Número de denúncias de assédio registradas no período;
- Número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho.

9A.5. INTEGRAÇÃO COM O PCMSO

Conforme este PGR (Integração com o PCMSO — NR-07), os FRPRT identificados nesta seção devem ser considerados pelo Médico Coordenador do PCMSO na definição dos exames e avaliações complementares, incluindo:

- Triagem de saúde mental (questionários validados);
- Avaliação psicológica quando indicada;
- Monitoramento de indicadores de estresse ocupacional.

A periodicidade das avaliações deve ser no mínimo **anual**, conforme NR-01 item 1.5.3.1.4, com retroalimentação bidirecional entre PGR e PCMSO.

10. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Necessário o desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12 e anexada a este ou em pasta específica.

Todo o material contido deverá estar em língua portuguesa, bem como, as informações nas máquinas, manuais e afins.

11. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono;
- b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

A empresa deve elaborar o Plano de Ações Emergenciais/ Resposta e treinar equipe com efetivo compatível

levando em consideração as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás – CMBGO e considerar a quantidade necessária de pessoas treinadas para as possíveis eventualidades.

12. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – NR 32

É de responsabilidade da empresa verificar a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, de acordo com a norma regulamentadora (NR) 32, onde a classificação dos agentes biológicos estão contidos no anexo I da NR.

O PGR contempla a identificação dos agentes biológicos mais prováveis, assim como a avaliação do local de trabalho e do trabalhador, devendo ser reavaliado sempre que houver mudanças nas condições de trabalho que implique em mudança de risco e quando a análise de acidentes e incidentes determinar.

Deve-se prever: Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), adoção de medidas de proteção coletiva, adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), capacitação dos profissionais em cada área, adoção de normas e procedimentos de conforto e higiene, informar a ocorrência de incidentes e acidentes, cuidados na operação de raio-x e resíduos.

O PGR, além do previsto na NR-01, na etapa de identificação de perigos, deve conter:

I. Identificação dos agentes biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando:

- a) fontes de exposição e reservatórios;
- b) vias de transmissão e de entrada;
- c) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente;
- d) persistência do agente biológico no ambiente;
- e) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos;
- f) outras informações científicas.

II. Avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando:

- a) a finalidade e descrição do local de trabalho;
- b) a organização e procedimentos de trabalho;
- c) a possibilidade de exposição;
- d) a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho;
- e) as medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento.

O PGR deve ser reavaliado:

- a) sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos;
- b) quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar.

Classificação dos agentes biológicos de acordo com a NR 32 – Veja tabela completa dos agentes biológicos mais prevalentes nos documentos integrados

Os agentes biológicos são classificados em:

Classe de risco 1: baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.

Classe de risco 2: risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

Classe de risco 3: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

Classe de risco 4: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

12.1. IMPORTANTES MEDIDAS DE PROTEÇÃO

*Fornecimento de instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos.

*Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual (item 32.2.4.3 da NR);

* O empregador deve **vedar**:

- a) a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
- b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;**
- c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
- d) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim;
- e) o uso de calçados abertos.

*Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte e o empregador deve providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos, além de assegurar a capacitação para os trabalhadores dos serviços de saúde quanto ao uso, descarte destes objetos. Para tal tem o PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde).

*O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

12.2. VESTIMENTAS:

- Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas.

12.3. CAPACITAÇÃO:

- deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:
- os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde;
- medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;
- normas e procedimentos de higiene;
- utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho;
- medidas para a prevenção de acidentes e incidentes;
- medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e acidentes.

12.4. VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES:

- A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. E, sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente, juntamente com o reforço se necessário, devendo-se observar as recomendações do Ministério da Saúde e devendo ser registradas as imunizações no prontuário clínico individual do trabalhador.

12.5. RADIAÇÕES IONIZANTES

De acordo com a NR-32, item 32.4.1, o atendimento das exigências desta norma com relação às radiações ionizantes não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do Ministério da Saúde.

12.5.1. Equipamentos de Raios X do Seconci Goiás

O Seconci Goiás dispõe dos seguintes equipamentos emissores de radiação ionizante:

a) Equipamentos de Raios X Intraoral (Odontológico)

- Localizados nos consultórios odontológicos do 1º Pavimento

- Utilizados para radiografias periapicais e interproximais
- Características: baixa potência, feixes colimados e de curta duração

b) Equipamento de Raios X (novo — incluído nesta revisão)

- Localizado na sala de Raio X do 1º Pavimento (conforme Seção 4.1.3 deste PGR)
- Tipo: radiografia Geral
- Fabricante/Modelo: IMX Medical
- Características técnicas: 150kV e focos de $\phi 0.6/1.2\text{mm}$

12.5.2. Requisitos Específicos por Tipo de Equipamento

12.5.2.1. Para equipamentos intraorais

Conforme a RDC 611/2022 (ANVISA) e a NR-32 item 32.4.16, os equipamentos intraorais possuem as seguintes **dispensas**, desde que atendidos os requisitos:

- **Dispensa de projeto de blindagem** (RDC 611/2022, Art. 8º, parágrafo único) — aplicável apenas a consultórios isolados de odontologia com apenas equipamento intraoral;
- **Dispensa de sinalização luminosa** (RDC 611/2022, Art. 52, parágrafo único) — aplicável apenas ao consultório odontológico isolado com apenas equipamento intraoral;
- **Dispensa de cabine de comando** (RDC 611/2022, Art. 54, parágrafo único) — desde que o operador fique a no mínimo 2 (dois) metros do cabeçote e do paciente quando do seu acionamento;
- **Dispensa de dosímetro individual** (RDC 611/2022, Art. 65, parágrafo único) — aplicável apenas ao consultório odontológico isolado que possua apenas 1 (um) equipamento de raios X intraoral, com carga de trabalho máxima estimada em até 4 mA.min/semana.

Importante: Conforme NR-32, item 32.4.16.1, na radiologia intraoral, todos os trabalhadores devem manter-se afastados do cabeçote e do paciente a uma distância mínima de 2 metros, e nenhum trabalhador deve segurar o filme durante a exposição.

12.5.2.2. Para equipamentos Raio-X de diagnóstico médico hospitalar

Conforme NR-32, item 32.4.16.2, "para os procedimentos com equipamentos de radiografia extra-oral deverão ser seguidos os mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico" (NR-32, item 32.4.15). Portanto, as dispensas citadas no item 12.5.2.1 **NÃO SE APLICAM** aos equipamentos extraorais. São obrigatórios:

a) Projeto de Blindagem

- Obrigatório conforme RDC 611/2022, Art. 7º e Art. 8º

- Deve ser elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado (físico médico ou especialista em proteção radiológica)
- Deve ser aprovado pela Vigilância Sanitária antes da efetivação de qualquer modificação (RDC 611/2022, Art. 10)

b) Sinalização

- Obrigatória sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acionada durante os procedimentos, conforme RDC 611/2022, Art. 52, incisos I e II
- Obrigatórias inscrições na porta: "Raios X, entrada restrita" e "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida"
- Quadro de orientações de proteção radiológica conforme RDC 611/2022, Art. 53

c) Cabine de Comando

- Obrigatória cabine ou sala de comando com visor ou sistema de observação eletrônico, conforme RDC 611/2022, Art. 54, incisos I a III

d) Dosímetro Individual

- **Obrigatório** para todos os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos — IOE, conforme NR-32, item 32.4.5 e RDC 611/2022, Art. 65
- Periodicidade de troca: mensal (RDC 611/2022, Art. 66, inciso II)
- Dosímetros devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela CNEN (NR-32, item 32.4.5.1)
- Cada dosímetro deve ser utilizado por um único usuário (RDC 611/2022, Art. 66, inciso III)

e) Plano de Proteção Radiológica — PPR

- Obrigatório conforme NR-32, item 32.4.2
- Deve estar dentro do prazo de vigência (item 32.4.2.1, alínea "a")
- Deve fazer parte integrante deste PGR (item 32.4.2.1, alínea "c")
- Deve ser considerado na elaboração e implementação do PCMSO (item 32.4.2.1, alínea "d")
- Deve ser apresentado à CIPA, quando existente (item 32.4.2.1, alínea "e")

f) Levantamento Radiométrico

- Obrigatório conforme RDC 611/2022, Art. 62 a 64
- Deve ser feito sempre que houver modificações na infraestrutura, equipamentos ou processos de trabalho, ou a cada 4 anos (Art. 64)
- Níveis de restrição de dose: 0,5 mSv/ano para áreas livres e 5 mSv/ano para áreas controladas (Art. 49)

g) Programa de Garantia da Qualidade

- Obrigatório conforme RDC 611/2022, Art. 5º, inciso I, e Art. 24

- Deve contemplar gerenciamento de tecnologias, processos e riscos

h) Programa de Educação Permanente

- Obrigatório conforme RDC 611/2022, Art. 5º, inciso II, e Art. 15
- Capacitação inicial e periódica anual para toda a equipe

i) Testes de Aceitação e Constância

- Obrigatórios conforme RDC 611/2022, Arts. 28 a 31
- Devem ser executados conforme protocolos nacionais ou internacionais

12.5.3. Proibições e Restrições (RDC 611/2022, Art. 47 e 79)

- Menores de 18 (dezoito) anos **não podem** trabalhar com raios X diagnósticos (RDC 611/2022, Art. 47)
- Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes (NR-32, item 32.4.4; RDC 611/2022, Art. 46)
- É proibida a exposição deliberada de seres humanos sem justificativa clínica (RDC 611/2022, Art. 79)

12.5.4. Registro Individual dos Trabalhadores Expostos

Conforme NR-32, item 32.4.7, cada trabalhador da instalação radiativa deve ter registro individual atualizado, conservado por 30 (trinta) anos após o término de sua ocupação, contendo, no mínimo: identificação, datas de admissão/saída, funções associadas às fontes de radiação, tipos de dosímetros utilizados, registro de doses mensais e anuais, capacitações realizadas, estimativas de incorporações e relatórios sobre exposições de emergência e acidente.

12.5.5. EPIs para Radiação Ionizante

EPI	Especificação Mínima	Fundamentação
Avental plumbífero	≥ 0,5 mmPb (corpo inteiro)	RDC 611, Art. 59 (I)
Protetor de tireoide	≥ 0,5 mmPb	RDC 611, Art. 61
Óculos plumbíferos	≥ 0,5 mmPb (quando aplicável)	RDC 611, Art. 61
Dosímetro individual	Acreditado CNEN	NR-32, 32.4.5; RDC 611, Art. 65
Luvas plumbíferas	Para procedimentos intervencionistas	RDC 611, Art. 59

Fundamentação geral desta Seção: NR-32 itens 32.4.1 a 32.4.16; RDC 611/2022 (ANVISA), Arts. 1º a 86; IN 95/2021 (ANVISA); Normas CNEN NE 3.01 e NE 6.05.

12.6. RESÍDUOS:

-A capacitação deve contemplar:

- a) segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos;
- b) definições, classificação e potencial de risco dos resíduos;
- c) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
- d) formas de reduzir a geração de resíduos;
- e) conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
- f) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
- g) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
- h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

-Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 9191 e ainda ser:

- a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade;
- b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com a abertura para baixo;
- c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento;
- d) mantidos íntegros até o tratamento ou a disposição final do resíduo.

-A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados, devendo ser observado que:

- a) sejam utilizados recipientes que atendam as normas da ABNT, em número suficiente para o armazenamento;
- b) os recipientes estejam localizados próximos da fonte geradora;
- c) os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e que sejam resistentes ao tombamento;
- d) os recipientes sejam identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT.

Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

Seguindo conforme anexo III da NR32, existe o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, com as diretrizes visando a proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.

Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal e o recipiente deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte.

-O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de forma que não exista o contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo vedado o arrasto, a fim de preservar a saúde e integridade física do trabalhador responsável.

-Sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve ser mantida limpa e com controle de vetores; conter somente os recipientes de coleta, armazenamento ou transporte;.ser utilizada apenas para os fins a que se destina e estar devidamente sinalizada e identificada.

-Os rejeitos radioativos devem ser tratados conforme disposto na Resolução CNEN NE6.05.

12.7. REFEITÓRIO:

Segue o disposto na NR-24, tendo área compatível com o número de trabalhadores atendidos e mesas com tampos lisos e cadeiras, água potável e copos descartáveis, ambiente consta com geladeira para conservação dos alimentos, equipamentos de aquecimento. Refeitório tem local próprio, contando com lavatórios para higiene das mãos providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa, de acionamento por pedal. Tanto a cozinha quanto o refeitório possuem ventilação natural e iluminação natural e artificial.

12.8. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Serviço terceirizado.

Mas faz valer que há controle de animais sinantrópicos (ratos, baratas,etc). Serviço de dedetização terceirizado.

12.9. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tanto os trabalhadores que realizam a manutenção quanto as empresas que prestam assistência técnica e manutenção nos serviços de saúde, além do treinamento específico para sua atividade, devem também ser submetidos a capacitação inicial e de forma continuada, com o objetivo de mantê-los familiarizados com os princípios de higiene pessoal; riscos biológico (precauções universais), físico e químico; sinalização; rotulagem preventiva; tipos de EPC e EPI, acessibilidade e seu uso correto.

Realizar descontaminação do equipamento antes de realizar a manutenção.

As máquinas, equipamentos e ferramentas, inclusive aquelas utilizadas pelas equipes de manutenção, devem ser submetidos à inspeção prévia e às manutenções preventivas de acordo com as instruções dos fabricantes, com a norma técnica oficial e legislação vigentes.

Antes da utilização de qualquer equipamento, os operadores devem ser capacitados quanto ao modo de operação e seus riscos.

13. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Para efeito deste item se entende que funções e processos terceirizados devem ser controlados, assegurando que os arranjos de terceirização sejam coerentes com os requisitos legais e requisitos internos e com o alcance dos resultados pretendidos do sistema de gestão da SST. Isto se estende a todos os terceirizados que prestam serviço dentro do Seconci, independentemente do tipo ou duração do contrato.

Fundamentação Legal: NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), itens 1.5.8.1 a 1.5.8.4; NR-32, itens 32.2.2.1, 32.2.4.9, 32.2.4.17, 32.3.4.1 e 32.8.3.

13.1. PROCEDIMENTO A SER EXECUTADO QUANDO DO INÍCIO DA TERCERIZADA

O Seconci Goiás entende que funções e processos terceirizados devem ser controlados, assegurando que seus arranjos de terceirização sejam coerentes com os requisitos legais e requisitos internos e com o alcance dos resultados pretendidos do sistema de gestão de SST. Isto se estende a todos os terceirizados que prestam serviço dentro do Seconci, independentemente do tipo ou duração do contrato.

Responsabilidades:

- Setor de Segurança do Trabalho: Responsável pela confecção do PGR e pelo inventário de riscos.
- Gestor do Contrato: Responsável pela interface com a empresa terceirizada e garantia de apresentação dos documentos de SST.
- Medicina do Trabalho: Responsável pela auditoria de documentos médicos (PCMSO, ASO).

13.1.1. Documentos Obrigatórios Antes do Início das Atividades

Todas as organizações contratadas pelo Seconci devem apresentar os seguintes documentos antes do início de suas atividades:

A) Informações de Pessoal:

Lista dos funcionários que prestarão os serviços, contendo:

Nome do funcionário;

Função;

CPF;

Liderança imediata responsável pelo trabalho no Seconci Goiás (com forma de contato).

B) Programas e Laudos de SST:

PGR vigente, considerando os riscos a que os trabalhadores estarão expostos nas atividades executadas no Seconci Goiás, conforme NR-01 item 1.5.8.1.1;

Inventário de Riscos Ocupacionais referente às atividades objeto da contratação;

Plano de Ação com medidas de prevenção, prazos e responsáveis;

PCMSO vigente, considerando os riscos discriminados no PGR;

LTCAT, considerando as atividades executadas no Seconci Goiás;

LIP, considerando as atividades executadas no Seconci Goiás;

Procedimentos operacionais, se existirem, das atividades a serem executadas no Seconci Goiás.

C) Documentos Individuais dos Trabalhadores:

ASOs válidos de todos os funcionários que constam da lista apresentada;

Cartão de vacina de todos os funcionários listados (obrigatório para serviços de saúde — NR-32 item 32.2.4.17);

Ficha de EPI atualizada de acordo com os riscos aos quais estarão expostos no Seconci Goiás.

D) Capacitações Obrigatórias:

Capacitação em Riscos Biológicos (NR-32, item 32.2.4.9):

Certificados com data, carga horária, conteúdo programático, nome do instrutor e lista de presença;

Capacitação em Riscos Químicos, incluindo quimioterápicos quando aplicável (NR-32, item 32.3.6.1):

Registros de treinamentos iniciais e continuados;

Acesso às FIS PQ dos produtos;

Procedimentos de emergência;

Comprovação de Capacitação no PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde):

Cópia do plano atualizado da contratada, contendo responsáveis e periodicidade de revisão.

13.2. OS TRABALHADORES QUE IRÃO EXECUTAR ATIVIDADES DE RISCO

Todos os trabalhadores terceirizados que forem executar atividades de risco têm de apresentar documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização e dos treinamentos realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis a cada atividade, bem como ASO atestando especificamente aptidão para o trabalho que irá realizar.

13.2.1. Definição de Atividades de Risco

Para efeito deste documento, são consideradas atividades de risco:

- Trabalho em altura (NR-35);
- Trabalho com eletricidade (NR-10);
- Trabalho em espaço confinado (NR-33);
- Outras atividades definidas como perigosas ou insalubres aplicáveis ao contexto.

13.2.2. Documentação Adicional Exigida

- Certificados de capacitação específica (NR-10, NR-33, NR-35);
- ASO com aptidão específica para a atividade de risco;
- Autorização formal emitida pela empresa contratada;
- Procedimentos de trabalho seguro para a atividade.

13.3. PROCEDIMENTO A SER EXECUTADO MENSALMENTE

Para garantir o controle dos terceirizados no que se refere à gestão de SST, as empresas terceirizadas devem entregar mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, os seguintes documentos:

13.3.1. Atualização de Movimentação de Pessoal

- Nome do funcionário;
- Função;
- Tipo de movimentação (admissão, desligamento, transferência, mudança de função);
- Liderança imediata responsável pelo trabalho no Seconci Goiás (com forma de contato).

13.3.2. Documentos de SST Atualizados

- ASOs válidos (admissionais, periódicos, mudança de risco, retorno ao trabalho e demissionais) dos funcionários que prestam serviço no Seconci;
- Ficha de EPIs atualizada de todos os funcionários (novos e antigos);
- Cópias dos registros de acidentes de trabalho (CAT) dos funcionários que prestam serviço no Seconci, quando ocorrerem.

13.3.3. Prazo e Forma de Entrega

- Prazo: Até o 5º dia útil do mês subsequente;
- Destinatário: Gestor do Contrato, com cópia para Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional;
- Formato: Preferencialmente digital, com protocolo de recebimento.

13.4. AUDITORIA DOS DOCUMENTOS

O Setor de Medicina Ocupacional e o Setor de Segurança do Trabalho procederão auditoria dos programas e laudos apresentados, de modo a garantir que os requisitos legais e técnicos estejam adequados.

13.4.1. Critérios de Auditoria

A auditoria verificará:

- Vigência dos documentos apresentados;
- Adequação técnica dos riscos identificados às atividades reais executadas no Seconci;
- Compatibilidade com o Inventário de Riscos do Seconci (Seção 20.1.1);
- Efetividade das medidas de prevenção propostas;

- Conformidade com as NRs aplicáveis (especialmente NR-01, NR-07 e NR-32);
- Validade dos ASOs e compatibilidade com os riscos do PGR;
- Comprovação de treinamentos obrigatórios.

13.4.2. Atualização de Programas e Laudos

- PGR e PCMSO: Antes do final de sua vigência, a empresa terceirizada deve apresentar os novos programas para manter a documentação válida;
- LTCAT e LIP: Sempre que forem revisados, os novos documentos devem ser encaminhados à gestão de SST para nova análise;
- Treinamentos periódicos: Para os funcionários que executam atividades de risco, é responsabilidade da empresa terceirizada apresentar os registros dos treinamentos periódicos conforme previsto nas respectivas normas regulamentadoras.

13.5. REGISTROS

13.5.1. Relatório de Auditoria Inicial

Quando do início do contrato, o Setor de Medicina Ocupacional e o Setor de Segurança do Trabalho, após auditoria em todos os documentos apresentados pelas empresas terceirizadas, irão apontar as não conformidades encontradas em um Relatório de Auditoria Documental que será apresentado à empresa.

Procedimento:

- Prazo concedido para ações corretivas: 15 (quinze) dias corridos;
- Ao final do prazo, será realizada auditoria de acompanhamento;
- Persistindo não conformidades, será emitido relatório ao Gestor de Contratos para medidas contratuais cabíveis.

13.5.2. Relatório Mensal de Acompanhamento

Todos os meses será emitida uma atualização do relatório, analisando a documentação que deve ser apresentada mensalmente pela empresa terceirizada, seguindo o mesmo procedimento para possíveis não conformidades encontradas.

13.5.3. Controle de Documentos

Todos os documentos entregues serão:

- Recebidos formalmente (com protocolo);

- Inseridos no controle de documentos externos do Seconci;
- Arquivados pelo prazo mínimo de 20 anos (Súmula 73 TST e NR-01);
- Disponibilizados para fiscalização quando solicitado.

13.6. GESTÃO CONTINUA E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO

13.6.1. Estratégia de Gerenciamento de Riscos de Terceiros

Conforme NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), item 1.5.8.1:

"O PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou utilizar os programas das contratadas."

E item 1.5.8.1.1:

"No caso de utilização dos programas das organizações contratadas, estas devem fornecer à organização contratante o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação referente às atividades objeto de sua contratação."

Adicionalmente, a NR-32, item 32.2.2.1, exige que o PGR do serviço de saúde contenha a identificação dos riscos biológicos de todos os setores, incluindo os operados por terceiros.

O Seconci Goiás adota estratégia combinada:

a) Preferencial: Utilização dos programas das contratadas (NR-01, 1.5.8.1.1), mediante apresentação regular de:

- Inventário de Riscos Ocupacionais;
- Plano de Ação;
- PGR e PCMSO vigentes.

b) Supletiva: Inclusão de medidas de prevenção no PGR do Seconci quando os programas das contratadas não estiverem disponíveis, vencidos ou necessitarem complementação (conforme Inventário de Riscos na Seção 20.1.1).

13.6.2. Procedimento de Auditoria Periódica e Atualização

O Setor de Segurança do Trabalho realizará auditoria documental periódica (mínimo semestral) da documentação de SST de todas as empresas contratadas, verificando vigência, adequação técnica e conformidade legal.

Fluxo operacional:

ETAPA 1: Solicitação Programada

- Envio de comunicação formal às empresas contratadas solicitando apresentação/atualização dos documentos relacionados na Seção 13.1;
- Prazo para apresentação: 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da notificação;
- Protocolo de envio e recebimento.

ETAPA 2: Análise Técnica

A documentação recebida será submetida à auditoria técnica conforme Seção 13.4 (Auditoria dos Documentos), verificando:

- Adequação dos programas aos riscos reais identificados no Inventário de Riscos do Seconci Goiás;
- Validade e vigência dos documentos;
- Conformidade com NR-01 e NR-32.

ETAPA 3: Tratamento de Não Conformidades

Documentos conformes:

- Registro em controle interno;
- Arquivamento;
- Inclusão no sistema de gestão integrada.
- Documentos com pendências:

Notificação à contratada com apontamentos específicos;

- Prazo para correção: 15 (quinze) dias corridos;
- Nova auditoria ao final do prazo.

Não apresentação ou persistência de inadequações:

- Emissão de Relatório de Não Conformidade ao Gestor de Contratos;
- Adoção das medidas contratuais cabíveis, podendo incluir:
- Aplicação de sanções contratuais previstas;
- Suspensão temporária das atividades da contratada até regularização documental;
- Notificação formal de descumprimento contratual.

ETAPA 4: Medidas Supletivas de Prevenção

Enquanto os programas das contratadas não estiverem plenamente adequados ou vigentes, o Seconci Goiás, na condição de contratante, adotará medidas supletivas:

a) Aplicação do Inventário de Riscos próprio:

- Utilização dos inventários de riscos elaborados na Seção 20.1.1 deste PGR como referência para o gerenciamento de riscos desses trabalhadores, conforme NR-01 item 1.5.8.1 (primeira parte: "incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas");

b) Coordenação unilateral de medidas de prevenção:

- Conforme NR-01 item 1.5.8.4, nos casos em que os riscos resultem da interação das atividades das organizações, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob a coordenação do Seconci Goiás como organização contratante;
- Enquanto a regularização não ocorrer, o Seconci coordenará unilateralmente as medidas de prevenção aplicáveis;

c) Ações operacionais provisórias:

- Inclusão dos trabalhadores terceirizados em DDS (Diálogo Diário de Segurança) conduzido pelo Seconci;
- Reforço de orientações sobre uso de EPIs e procedimentos de biossegurança;
- Monitoramento reforçado das atividades;
- Aplicação de medidas de controle coletivas adicionais quando necessário.

ETAPA 5: Gestão de Riscos Decorrentes de Interação

Conforme NR-01 item 1.5.8.4, quando os riscos ocupacionais resultarem da interação das atividades do Seconci e das empresas contratadas, as medidas de prevenção serão definidas em conjunto, sob coordenação do Seconci Goiás.

Procedimento:

- Reunião técnica entre SST do Seconci e representante técnico da contratada;
- Análise conjunta dos riscos de interface;
- Definição compartilhada de medidas de controle;
- Formalização em Plano de Ação conjunto;
- Revisão semestral ou quando houver alterações nas atividades.

13.6.3. Integração de Segurança

Todos os trabalhadores de empresas contratadas, independentemente do tipo ou duração do contrato, passarão por Integração de Segurança, conduzida pelo Seconci Goiás, abordando:

- Riscos específicos do ambiente hospitalar;
- Procedimentos de emergência e rotas de fuga;
- Uso correto de EPIs;
- Riscos biológicos e medidas de biossegurança (NR-32);
- Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS);
- Canais de comunicação e reporte de incidentes;
- Direitos e deveres em SST.

Registro: Lista de presença arquivada no setor de Segurança do Trabalho pelo prazo mínimo de 20 anos.

Fundamentação Legal:

NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), itens 1.5.7.3.3, 1.5.8.1, 1.5.8.1.1, 1.5.8.2, 1.5.8.3, 1.5.8.4;

NR-32, itens 32.2.2.1, 32.2.4.9, 32.2.4.17, 32.3.4.1, 32.8.3.

14. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES

Toda e qualquer introdução de nova tecnologia ou mudança das existentes deverá ser antecedida de criteriosa análise de risco, conforme padrões gerenciais da empresa. Ao implementar nova (s) tecnologia (s) ou mudanças nas existentes, o departamento técnico do SECONCI deverá ser notificado via e-mail.

Este Programa permanecerá válido por 24 meses ou enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

15. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

A empresa deverá criar procedimentos para os registros de acidentes e incidentes do trabalho.

Recomendamos as seguintes etapas:

- ✓ Método adequado
- ✓ Coleta os dados
- ✓ Contextualização do cenário
- ✓ Registro de depoimentos fazendo perguntas à vítima, preposto e testemunhas.
- ✓ Análise específica de circunstâncias anormais
- ✓ Detalhamento do evento.
- ✓ Emissão de Relatório
- ✓ Implementação de soluções

16. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS

É de responsabilidade da empresa manter atualizada, e arquivada no PGR ou eletronicamente a relação dos produtos químicos utilizados em seus processos de trabalho (poderão ser anexados a este) de acordo com a NR 26 e dados constantes na FDS (Ficha com Dados de Segurança), devem ser ainda seguidos os requisitos constantes na NR 32, a saber:

- Inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos;
- Ficha descritiva contendo:
 - a. As características e as formas de utilização do produto;
 - b. Os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;
 - c. As medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;
 - d. Condições e local de estocagem;
 - e. Procedimentos em situações de emergência;
- Manter cópia desta ficha onde o produto é utilizado;
- Capacitação de profissionais para o uso de produtos químicos e ainda em caso de acidentes/incidentes;
- Sistema de descarte adequado.

17. AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

*As avaliações quantitativas são fundamentais para o desenvolvimento do programa. Após as contratações, deverão ser iniciadas imediatamente para complementar o plano de ação, definir estratégias de proteção, manutenção, controle e e-SOCIAL.

*Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP): Obrigatório para cumprimento das Normas Regulamentadoras 15 e 16 (também presente na 01) e e-SOCIAL.

*Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT: Laudo obrigatório para fins previdenciário e e-SOCIAL.

18. CUMPRIMENTO DAS DEMAIS NORMAS

Ressaltamos a importância das demais exigências normativas a serem cumpridas pela empresa, com o intuito de atender dinamicamente, ficarão arquivados no documento físico em modelo de fichário para anexar a documentação física.

19. PROFISSIONAL HABILITADO

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA – GO n.º 1016723644D-GO

20. DOCUMENTOS INTEGRADOS

- 20.1. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS**
- 20.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS**
- 20.3. INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS**
- 20.4. PLANO DE AÇÃO**
- 20.5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EPIS**
- 20.6. CRONOGRAMA DE PALESTRAS**
- 20.7. FORMULÁRIOS PARA CONTROLE DE TERCEIRIZADOS**

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Normas Regulamentadoras - NRs**. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs>. Acesso em 31/03/2025.

BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm . Acesso em: 31/03/2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT**. Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, Disponível em <https://www.abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=VStYeVBtY0Y1dDNKMysvSXpNdk9FNmFIYIV1N0d6RGVZaGRsd3dKcFVLW0=> Acesso em: 31/03/2025.

AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION. **AIHA**. Disponível em: <https://www.aiha.org/> . Acesso em 24/03/2025.

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. **ACGIH**. Disponível em: <https://www.acgih.org/>. Acesso em: 15/03/2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 45001: Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional — Requisitos com orientação para uso**. Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde. **Classificação de risco dos agentes biológicos**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 48 p.

Nota: A confirmação dos dados do coordenador de desenvolvimento humano foi solicitada em 26/03/2026, conforme orientação recebida, e será atualizada neste inventário tão logo obtida a informação.

20.1-INVENTARIO DE RISCO OCUPACIONAIS

Em atendimento ao disposto na NR-01, item 1.5.7.3.2, alíneas "b" e "e" (Portaria MTE nº 1.419/2024), que determina que o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar a "caracterização das atividades" e a "indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos", foram incluídas as seguintes funções anteriormente não contempladas:

a) Coordenador(a) de Desenvolvimento Humano Social

- **CBO:** [inserir CBO após confirmação com o RH]
- **Vínculo:** PJ — Seconci Goiás
- **Local de trabalho:** 1 Pavimento sala ADM
- **Descrição das atividades:** Coordenação de ações sociais, planejamento de projetos de desenvolvimento humano, articulação com equipes multidisciplinares, participação em reuniões internas e externas, elaboração de relatórios e acompanhamento de indicadores sociais. [aguardando confirmação do RH]
- **GHE de enquadramento:** 1 — Atividades Administrativas com eventual circulação em áreas assistenciais
- **Perigos identificados:** Ergonômico, Acidente.

Fundamentação: NR-01 item 1.5.3.2, alíneas "b" a "f"; NR-01 item 1.5.7.3.2, alíneas "a" a "i" (Portaria MTE nº 1.419/2024); NR-32 item 32.2.2.1, inciso II, alínea "d".

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE VÍNCULO

Em atendimento à NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), itens 1.5.8.1 a 1.5.8.4, que tratam do gerenciamento de riscos ocupacionais nas relações de prestação de serviços a terceiros, e considerando que "o PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências" (item 1.5.8.1), todas as funções constantes no inventário de riscos ocupacionais passam a conter, obrigatoriamente, a identificação do tipo de vínculo do trabalhador com o Seconci Goiás, conforme modelo abaixo:

Campo	Descrição
Função	[Nome da função]
Tipo de Vínculo	☐ CLT Seconci Goiás ☐ Estagiário ☐ Prestador de Serviço (Terceirizado)
Empresa Contratada	[Nome da empresa, se terceirizado]
Descrição das Atividades	[Descrição]
GHE	[Nº do GHE]

Para os trabalhadores de empresas contratadas (terceirizados), aplica-se adicionalmente o disposto na Seção 13 deste PGR (Contratação de Prestadores de Serviços), devendo as contratadas fornecerem ao Seconci Goiás "o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação referente às atividades objeto de sua contratação" (NR-01 item 1.5.8.1.1).

Fundamentação: NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024) itens 1.5.8.1, 1.5.8.1.1, 1.5.8.2, 1.5.8.3, 1.5.8.4.

20.1.1 INVENTÁRIO DE RISCOS — PRESTADORES DE SERVIÇO

Em cumprimento à NR-01 (Portaria MTE nº 1.419/2024), item 1.5.8.1, que determina que "o PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou utilizar os programas das contratadas", e à NR-32, item 32.2.2.1, que exige a identificação dos riscos biológicos considerando as atividades e funções de cada local de trabalho (inciso II, alíneas "a" a "e"), os inventários de riscos das empresas prestadoras de serviço que atuam nas dependências do Seconci Goiás são apresentados a seguir. Conforme NR-01 item 1.5.8.1.1, as empresas contratadas forneceram (ou deverão fornecer em prazo de 30 dias) seus inventários de riscos ocupacionais e planos de ação referentes às atividades objeto de sua contratação. Na ausência destes documentos, o Seconci Goiás elaborou inventários próprios com base na avaliação in loco dos postos de trabalho, em conformidade com o item 1.5.8.4 da NR-01.

A) LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS — Prestador de Serviço

- **Empresa:** Bio Cell Laboratório de Análises Clínicas Ltda
- **Local de atuação:** Térreo — Laboratório com área de espera e banheiro
- **Nº de trabalhadores:** 9
- **Atividades desenvolvidas:** Coleta e armazena as amostras laboratoriais e orientação dos pacientes durante a coleta.
- **Perigos identificados:**
 - Biológico: Biológicos -
 - Trabalhos e operações em contato com pacientes em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
 - Acidentes: Perfurocortantes (agulhas, lancetas, lâminas) — NR-32 item 32.2.4.14 e Anexo III
- **Medidas de controle:** Conforme Seção 12 (NR-32), Seção 13 (Prestadores de Serviço) e PGRSS
- **EPIs exigidos:** Luvas de procedimento não cirúrgicos

B) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO — Prestador de Serviço

- **Empresa:** EXCELSO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- **Local de atuação:** Todos os pavimentos (Subsolo, Térreo, 1º e 2º Pavimento)
- **Nº de trabalhadores:** 4
- **Atividades desenvolvidas:** Limpeza e desinfecção de pisos, paredes, mobiliários e equipamentos; coleta e transporte interno de resíduos de serviços de saúde; higienização de sanitários; reposição de

materiais de higiene.

- **Perigos identificados:**
 - Biológico: Higienização dos Ambientes— classe 2 (NR-32, Anexo I; NR-32, item 32.8.1)
 - Químico: Produtos saneantes (limpeza comum (Domissanitários)) — NR-32 item 32.3.4.1
 - Ergonômico: Exigência de Posturas Incômodas por Longos Períodos
 - Acidentes: Piso molhado (escorregamento/queda).
- **Medidas de controle:** Capacitação conforme NR-32 item 32.8.1 (higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC), PGRSS, sinalização de piso molhado
- **EPIs exigidos:** Luvas de borracha/nitrilo, máscara cirúrgica, óculos de proteção, calçado de segurança impermeável
- **Observação:** Conforme NR-32 item 32.8.3, a empresa de limpeza e conservação que atua no Seconci Goiás deve cumprir os itens 32.8.1 e 32.8.2 da NR-32.

C) SEGURANÇA PATRIMONIAL — Prestador de Serviço

- **Empresa:** ESCUDO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL
- **Local de atuação:** Subsolo (portaria de veículos), Térreo (recepção/portaria de pedestres) e áreas externas
- **Nº de trabalhadores:** 5
- **Atividades desenvolvidas:** Controle de acesso de pessoas e veículos, rondas internas e externas, monitoramento por CFTV, atendimento ao público, registro de ocorrências.
- **Perigos identificados:**
 - Ergonômico: Postura em pé prolongada ou sentada por longos períodos,
 - Psicossocial: Estresse ocupacional, vigilância contínua, contato com público em situações de conflito (NR-01 item 1.5.3.1.4 — Portaria MTE nº 1.419/2024 — fatores de risco psicossociais)
- **Medidas de controle:** Treinamento em precauções universais (NR-32 item 32.9.1), procedimentos de segurança patrimonial, capacitação em emergências
- **EPIs exigidos:** Calçado de segurança, vestimenta adequada

D) RADIOLOGIA — Prestador de Serviço

- **Empresa:** F&R IMAGEM E SERVICOS
- **Local de atuação:** 1º Pavimento — Sala de Raio X
- **Nº de trabalhadores:** 1
- **Atividades desenvolvidas:** Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia.
- **Perigos identificados:**
 - Físico — Radiação Ionizante: Exposição a radiação durante operação dos equipamentos — NR-32 item 32.4, RDC 611/2022 Art. 42 a 69, Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
 - Biológico: Agentes biológicos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) — classe 2 (NR-32, Anexo I)
 - Ergonômico: Alternância de postura em pé e/ou sentado durante a execução de atividades.

- Acidente: Diferença de nível menor ou igual a dois metros
- **Medidas de controle:** Conforme item 12.5 deste PGR (Radiações Ionizantes), PPR, RDC 611/2022
- **EPIs exigidos:** Avental plumbífero ($\geq 0,5$ mmPb — RDC 611/2022 Art. 59, inciso I), protetor de tireoide, dosímetro individual (NR-32 item 32.4.5; RDC 611/2022 Art. 65), óculos plumbíferos (quando aplicável), luvas de procedimento

Fundamentação geral: NR-01 itens 1.5.3.5, 1.5.8.1 a 1.5.8.4; NR-32 itens 32.2.2.1, 32.8.1, 32.8.3, 32.9.1, 32.4; RDC 611/2022 Arts. 42 a 69.

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 01 - ADMINISTRAÇÃO	
SETOR: ADMINISTRAÇÃO	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 03	Descrição do Ambiente: Ambiente típico administrativo com salas compartilhadas, exceto a sala do superintendente, todas com ventilação artificial (condicionamento de ar) e iluminação artificial a base de luz fria
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Direção Geral do Seconci Goiás	1231-05 - Dirige o fluxo financeiro da empresa; implementa o orçamento empresarial e administra recursos humanos. Controla patrimônio, suprimentos e logística e supervisiona serviços técnicos e complementares. Coordena serviços de contabilidade e controladoria e elabora o planejamento da empresa.	Superintendente
Garantir a eficiência das operações administrativas, coordenando áreas estratégicas, otimizando recursos e promovendo a melhoria contínua para atingir resultados e satisfazer as partes interessadas.	4101-05. Garantir a eficiência, integração e qualidade das operações administrativas da organização, coordenando áreas estratégicas como Tecnologia da Informação, Suporte ao SOC, Recursos Humanos, Qualidade, Suprimentos, Jurídico, Comunicação, Contabilidade, Portaria, Serviços Gerais, Relações com o Mercado, Recepção, Telefonia, Financeiro, Patrimônio, Manutenção e Atendimento Geral. Promover a otimização de recursos, a conformidade com legislações e a aplicação de boas práticas de gestão, assegurando suporte aos processos organizacionais e atendimento às demandas de clientes internos e externos. Liderar equipes com foco em resultados, melhoria contínua e alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa, mantendo um ambiente colaborativo, inovador e comprometido com a excelência operacional e a satisfação de todas as partes interessadas.	Coordenador Administrativo

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir a eficiência das operações administrativas, coordenando áreas estratégicas, otimizando recursos e promovendo a melhoria contínua para atingir resultados e satisfazer as partes interessadas.	2524-05. Coordenar e otimizar os processos de atração, seleção e integração de novos colaboradores, assegurando uma experiência positiva em todas as etapas, desde a triagem até o Onboarding e Offboarding. Promover o desenvolvimento contínuo da equipe por meio de programas de capacitação alinhados ao Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) e ao plano de endomarketing, fortalecendo a cultura organizacional e o engajamento dos colaboradores. Também é responsável pela administração de benefícios, controle de jornada, conformidade com a legislação trabalhista, e pelo apoio à resolução de conflitos internos, sempre em conformidade com as políticas da empresa e normas de segurança.	Analista de Recursos Humanos
Auxiliar nas operações dos departamentos Financeiro, RH, DP e Comercial, organizando documentos, controlando notas fiscais e uniformes, e apoiando na gestão de benefícios e iniciativas de endomarketing.	901. Auxiliando no operacional dos departamentos Financeiro, Recursos Humanos, Departamento Pessoal e Comercial. Com responsabilidade principal é garantir a eficiente organização de documentos, tanto físicos quanto digitais, além de manter planilhas atualizadas, lançamento de notas fiscais no sistema e e garantindo o controle da distribuição de uniformes. Além disso, prestar apoio na gestão de benefícios e colaboração ativa em iniciativas de endomarketing, contribuindo para o sucesso geral da empresa.	Estagiário(a) Administrativo

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
Biológico	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Acidente de trânsito	Atividades externas, com deslocamento em via pública	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de Direção defensiva	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	3	3	6	48	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 02 - ADMINISTRAÇÃO 02	
SETOR: ADMINISTRAÇÃO 02	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: Ambiente típico administrativo com salas compartilhadas, exceto a sala do superintendente, todas com ventilação artificial (condicionamento de ar) e iluminação artificial a base de luz fria
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Responsável pelo suporte, aprimoramento e treinamento do sistema SOC no Seconci Goiás, implantando melhorias, gerenciando eventos de SST, e oferecendo suporte administrativo e atendimento aos clientes internos e externos.	2521-05. Responsável pelo suporte e aprimoramento do sistema SOC no Seconci Goiás, desempenha um papel fundamental na condução de treinamentos tanto internos quanto externos. Além disso, está envolvido na implantação de melhorias e novos módulos, bem como na realização das parametrizações necessárias para garantir o funcionamento ideal do sistema. Gerencia também o envio de eventos de SST para o SOC e o e-Social, elaborando relatórios, planejando ações e acompanhando chamados. Responsável pelas atividades administrativas relacionadas ao e-Social, oferecendo suporte aos demais departamentos e clientes que utilizam o Sistema SOC. Fornecer treinamentos, orientações e acompanhar os processos dentro do sistema, além de prestar atendimento aos clientes (internos e externos) para garantir o acompanhamento adequado dos processos.	Analista Administrativo Do SOC

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir a integridade das informações do E-Social, oferecendo suporte e treinamento no sistema SOC, corrigindo inconsistências, parametrizando o sistema e assegurando conformidade com as normas legais.	4110-10. Garantir a integridade e consistência das informações relacionadas ao E-Social, colaborando com a verificação e correção de cadastros, identificação e resolução de inconsistências, e a geração de relatórios de dados administrativos. O cargo envolve o suporte contínuo aos usuários internos e externos do sistema SOC, oferecendo treinamentos, solucionando dúvidas e implementando melhorias no sistema. Além disso, o Assistente será responsável pela parametrização do SOC, pelo envio de eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), e pelo acompanhamento de chamados técnicos. Assegura a conformidade das informações com as normas legais, especialmente na emissão de ASOs e PPPs, e apoia nas atividades administrativas do sistema, contribuindo para o bom funcionamento do ambiente de trabalho e o cumprimento das obrigações legais.	Assistente Administrativo Do SOC
---	---	---

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

INVENTÁRIO DE RISCOS

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 03 - QUALIDADE	
SETOR: QUALIDADE	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: Ambiente típico administrativo com salas compartilhadas, exceto a sala do superintendente, todas com ventilação artificial (condicionamento de ar) e iluminação artificial a base de luz fria
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
ETAPA	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir a excelência do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), analisando, padronizando e melhorando processos, monitorando indicadores, capacitando equipes e assegurando conformidade com normas e auditorias.	3912-05. Garantir a excelência do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) por meio da análise detalhada, padronização e melhoria contínua dos processos organizacionais, assegurando a conformidade com normas regulamentadoras e padrões de mercado. Identificar oportunidades de melhoria, mapear e documentar processos críticos e complementares, promovendo a integração entre as áreas e a eficiência operacional. Desenvolver indicadores de desempenho para monitorar a eficácia dos processos e implementar ações corretivas e preventivas que impulsionem a qualidade e a sustentabilidade das operações. Atuar como facilitador na capacitação das equipes, promovendo a cultura da qualidade e garantindo alinhamento estratégico com os objetivos organizacionais. Acompanhar auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de requisitos normativos, e elaborar planos de ação para tratar não conformidades, sempre buscando inovação e excelência na gestão da qualidade.	Assessoria De Qualidade

INVENTÁRIO DE RISCOS

Auxiliar na implementação e aprimoramento dos sistemas de Gestão da Qualidade conforme a ISO 9001, garantindo conformidade, controle de documentos, correção de não conformidades e a promoção da cultura da qualidade.	4110-10. Contribuir para a excelência organizacional, auxiliando na implementação, manutenção e aprimoramento dos sistemas de Gestão da Qualidade, conforme as normas ISO 9001. Garantir a elaboração, revisão e controle de documentos e procedimentos, promovendo a conformidade com padrões estabelecidos. Apoiar na identificação e correção de não conformidades, bem como na execução de planos de ação preventiva e corretiva. Monitorar indicadores de desempenho e propor melhorias contínuas, disseminando a cultura da qualidade em todos os níveis. Facilitar auditorias internas e externas, organizar treinamentos e promover boas práticas entre colaboradores, assegurando o alinhamento às diretrizes normativas e à visão estratégica da organização.	Assistente De Qualidade
--	--	--------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ										
SEVERIDADE	PROBABILIDADE									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96	
10	40	50	60	70	80	90	100	###	120	
12	48	60	72	84	96	108	120	###	144	
14	56	70	84	98	112	126	140	###	168	

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 04 - MANUTENÇÃO	
SETOR: MANUTENÇÃO	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial, também realiza manutenção em altura superior a 2 metros e em áreas externas
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir o funcionamento e conservação da infraestrutura da empresa, realizando manutenções, controlando patrimônio, insumos e serviços, e apoiando atividades operacionais e eventos.	5143-10. Garantir o perfeito funcionamento e conservação da infraestrutura física da empresa, executando manutenções preventivas e corretivas em instalações e equipamentos, como sistemas hidráulicos, elétricos e de climatização. Gestão de patrimônio, controle de insumos e equipamentos, e pelo acompanhamento de prestadores de serviços, assegurando a qualidade e pontualidade dos serviços. Realizar atividades operacionais de jardinagem, controle de pragas e manutenção de áreas externas. Apoiar a organização de espaços físicos para eventos e mudanças. Realizar a inspeção e monitoramento de sistemas de energia solar.	Assistente de Manutenção e Patrimonio

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	OK	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Conceituação	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite e tolerância												
FÍSICO	Ruido	Quando em atividade com máquinas e equipamentos cortador de grama, furadeira, etc...)	Perda auditiva permanente	Será avaliado na elaboração do LTCAT	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Anexo 1 da NR 15, dosimetria de ruído com fator de dobra 5 dB (q = 5)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Eventual	Corrente	1	1	1	3	6	1	3	4	24	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

FISICO	Vibraçãoes localiza das (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Será avaliada na elaboração do LTCAT	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Anexo 8 da NR 15	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	5m/s²	Eventual	Corrente	1	2	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postura I	Assumir posições incômodas durante suas atividades	Lesões musculares, ósseas, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões musculares, ósseas, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	3	8	3	3	6	48	Moderado
	Acidente de trânsito	Atividades externas, com deslocamento em via pública	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	****	Eventual	Corrente	2	2	1	3	8	3	3	6	48	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar instalações em atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Queda de materiais	Ao carregar peças para realização da manutenção na instituição	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a proteções coletivas)	Treinamentos e orientações	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras.	****	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Eletricidade	Atividades com máquinas e equipamentos elétricos	Risco de choque	****	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações	****	Eventual	Corrente	2	2	3	3	10	3	1	4	40	Moderado
	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	###	120
12	48	60	72	84	96	108	120	###	144
14	56	70	84	98	112	126	140	###	168

EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Protetor auditivo tipo concha ou tipo pl	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas em processos de obra	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso quando em ações externas	A critério da empresa
Cinto de segurança tipo paraquedista	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Trava queda	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Avental de PVC	Uso para trabalhos com produtos químicos	A critério da empresa
Luva isolante de baixa tensão (500 V)	Uso quando em contato com eletricidade	A critério da empresa
Luva de cobertura	Uso quando em contato com eletricidade	A critério da empresa
Botina isolante para eletricista	Uso quando em contato com eletricidade	A critério da empresa
Máscara descartável PFF2/vapores orgânicos	Uso quando exposto a poeiras/gases ou vapores gerados em processos de obra	A critério da empresa
Luva Nitrílica	Uso para trabalhos com produtos químicos	A critério da empresa
Capacete de Segurança com jugular	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa
Botina de Segurança	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa

O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atividades realizadas em dias chuvosos que não estão listados acima não é permitido, uma vez que as atividades envolvem eletricidade e a execução das mesmas com a rede energizada não é autorizada."

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento para uso de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento formal como eletricista	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de Segurança do Trabalho em máquinas e equipamentos	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento em altura NR 35	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
SETOR: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Prestar suporte à equipe de TI, auxiliando na manutenção e operação dos sistemas e infraestrutura, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.	901. Prestar suporte ao time de Tecnologia da Informação, auxiliando na manutenção e operação dos sistemas e infraestrutura de TI da organização, desenvolvendo habilidades técnicas e contribuindo para a melhoria contínua dos processos.	Estagiário de Tecnologia da Informação

INVENTÁRIO DE RISCOS

Gerenciar e otimizar sistemas ERP e infraestrutura de TI, garantindo segurança, eficiência e alinhamento com as diretrizes da empresa. Treinar usuários, coordenar suporte técnico e projetos, além de acompanhar indicadores e elaborar relatórios estratégicos.	2124-05.Gerenciar e aprimorar sistemas ERP, focando em eficiência. Treinar usuários e otimizar o uso de recursos tecnológicos. Implementar planos de TI conforme diretrizes da empresa. Coordenar desenvolvimento e manutenção de infraestrutura e sistemas de TI. Desenvolver aplicações para otimização de processos. Contribuir com o planejamento e desempenho da TI. Prestar suporte e manutenção de TI, incluindo visitas em obras. Administrar chamados com a empresa terceirizada de TI. Oferecer consultoria para aquisição de equipamentos de TI. Acompanhar a terceirizada de TI, planejando projetos e soluções. Monitorar indicadores de sistemas e propor melhorias de interação. Implementar estratégias de segurança (dados, acessos, auditorias) e prevenção para continuidade de serviços. Elaborar relatórios gerenciais de sistemas para apoio à decisão. Utilizar veículo corporativo, se necessário. Cumprir normas de SST, usando EPIs. Executar atividades correlatas.	Analista da Tecnologia da Informação (TI)
--	--	--

INVENTÁRIO DE RISCOS

Prestar suporte técnico, garantindo o bom funcionamento dos sistemas e equipamentos de TI, realizando manutenção, acompanhando chamados e colaborando na segurança e otimização dos recursos tecnológicos.	2124-05. Prestar suporte técnico essencial aos usuários, assegurando o bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e infraestrutura de TI, por meio da execução de atividades operacionais e rotinas de manutenção preventiva e corretiva. Realizar o acompanhamento de chamados, promovendo a resolução de problemas técnicos de forma eficiente e ágil, garantindo a continuidade das operações. Auxiliar na instalação, configuração e atualização de softwares e equipamentos, sempre em conformidade com as diretrizes da empresa e com foco na otimização dos recursos tecnológicos. Apoiar o planejamento e execução de projetos de TI, oferecendo suporte às equipes internas e à empresa terceirizada responsável pela gestão dos sistemas. Colaborar com a segurança das informações, adotando medidas para assegurar a integridade de dados e acessos. Atuar na organização e controle de inventário de equipamentos e prestar consultoria interna para aquisição de novos materiais tecnológicos, promovendo melhorias no ambiente de TI.	Assistente da Tecnologia Da Informação (TI)
---	--	--

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO																			Tolerável	
Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares , além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28		
ACIDENTE	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorragadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
E	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
-----	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 06 - SUPRIMENTOS	
SETOR: SUPRIMENTOS	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da sala de suprimentos, onde o pé direito é de aproximadamente 3m, Iluminação e ventilação natural e artificial, paredes em alvenaria, com armários e prateleiras para guarda e armazenamento de materiais armazenados.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir a eficiência na gestão de suprimentos, controlando estoques, qualificando fornecedores e otimizando processos para reduzir custos e garantir qualidade, alinhado aos objetivos organizacionais.	2527-25. Garantir a eficiência na gestão de suprimentos, assegurando o recebimento, conferência, armazenamento e distribuição de materiais, produtos e equipamentos de acordo com as demandas internas do Seconci-Goiás. Atuar na qualificação de fornecedores, planejamento de compras e controle de estoques, promovendo soluções inovadoras que otimizem processos, reduzam custos e garantam a qualidade dos insumos. Contribuir para a sustentabilidade da operação, respeitando normas interna, segurança e alinhamento estratégico com os objetivos organizacionais.	Analista De Suprimentos
Garantir a eficiência na gestão de materiais e equipamentos, assegurando entregas pontuais e qualidade no apoio aos departamentos internos do Seconci-Goiás.	901. Garantir a eficiência na gestão de materiais e equipamentos, assegurando a qualidade e pontualidade nas entregas, e apoiando os departamentos internos com recursos necessários para o bom funcionamento das atividades do Seconci - Goiás.	Estagiário(a) de Suprimentos

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
				Perfil de exposição																	
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade/Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle/medidas preventivas(demais verificar pdca	Nível de ação/Limit e tolerância													
FÍSICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													NA
QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													NA
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	2	1	7	1	3	4	28	Tolerável	

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Transporte manual de materiais (Queda de objeto)	Recebimento e guarda dos materiais nas prateleiras do almoxarifado	Ser atingido por material em queda	****	Lesões diversas	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do almoxarifado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos e orientações	****	Eventual	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
ACIDENTE	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como:	****	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	1	4	28	Tolerável
ACIDENTE	Perfuro cortante	Durante abertura de embalagem e manuseio de Suprimentos	Corte e perfuração	****	Risco de infecções, cortes profundos e superficiais	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Orientação quanto ao manuseio	****	Eventual	Corrente	1	2	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

INVENTÁRIO DE RISCOS

NA -não aplicável

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
-----	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 07 - FINANCEIRO	
SETOR: FINANCEIRO	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir a saúde financeira da empresa, supervisionando atividades contábeis, gerenciando contas, processos financeiros e contratos, e oferecendo suporte estratégico para tomadas de decisões e auditorias.	2525-45. Garantir a saúde financeira e o alinhamento estratégico da empresa, participando do planejamento econômico-financeiro e orçamentário, supervisionando atividades contábeis e assegurando a conformidade com normas vigentes. Atuar na gestão de contas a pagar e a receber, processando pagamentos, emitindo cobranças, monitorando recebimentos e realizando conciliações bancárias. Manter dados cadastrais e relatórios financeiros atualizados, gerando análises para suporte à tomada de decisões estratégicas. Promover eficiência nos processos financeiros, gerenciando contratos com terceiros, negociando prazos e condições de pagamento, e propondo melhorias contínuas. Apoiar auditorias internas e externas, garantindo a organização documental e a aderência às legislações aplicáveis. Contribuir para a comunicação eficaz com instituições financeiras, sempre alinhado às diretrizes da Segurança e Medicina do Trabalho, e demais responsabilidades atribuídas pelo superior imediato.	Analista Financeiro

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde..	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Eventual	Corrente	2	1	2	1	6	1	3	4	24	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Acidente de trânsito	Atividades externas, com deslocamento em via pública	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de Direção defensiva	****	Eventual	Corrente	2	1	2	1	6	1	3	4	24	Tolerável
----------	----------------------	--	----------------------	------	---	--	----------------------------------	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE E	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	###
12	48	60	72	84	96	108	120	132	###
14	56	70	84	98	112	126	140	154	###

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

NA -não aplicável

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
-----	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 08 - PABX	
SETOR: PABX	Data: 01/01/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 04	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro do escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir um atendimento telefônico eficiente, agendando consultas e serviços, fornecendo informações claras, organizando o sistema de PABX e apoiando as equipes administrativas e médicas para otimizar o atendimento e a satisfação dos pacientes.	4222-05. Garantir um atendimento telefônico eficiente e cordial, encaminhando chamadas e mensagens de forma precisa, de acordo com as necessidades dos pacientes e da clínica. Deve realizar o agendamento de consultas, exames médicos, odontológicos, fisioterápicos e demais serviços, respeitando as agendas dos profissionais e proporcionando uma experiência fluida aos pacientes. Além disso, a telefonista é responsável por fornecer informações claras sobre os serviços da clínica, horários de atendimento e orientações gerais. Também organiza e mantém o sistema de PABX, direcionando as ligações corretamente e garantindo o fluxo adequado de chamadas. Presta suporte às equipes administrativas e médicas, controlando relatórios de atendimentos e registrando recados de maneira ágil. Seu compromisso é assegurar a satisfação dos pacientes, colaborando com todos os setores para otimizar o atendimento e cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho.	Telefonista

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio quando molhado	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 09 - ATENDIMENTO	
SETOR: ATENDIMENTO	Data: 20/03/2026
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 06	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da recepção, onde o pé direito é de aproximadamente 3m divisória, de blindex, com balcão feito de concreto, cadeiras ajustáveis. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificia
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir a eficiência no atendimento, supervisionando processos, gerenciando agendas e documentos, e liderando a equipe para melhorias contínuas e organização do ambiente	4201-25. Garantir a eficiência e qualidade no atendimento aos pacientes e empresas associadas, supervisionando e otimizando os processos operacionais, incluindo o gerenciamento de agendas, consultórios e documentos do SGQ. Promover a organização do ambiente, assegurar a comunicação eficaz com equipes e clientes, analisar indicadores de desempenho e elaborar relatórios estratégicos. Participar do planejamento de melhorias no setor, liderar o treinamento e desenvolvimento da equipe e assegurar a continuidade das operações por meio da gestão de materiais e suporte administrativo.	Lider de Atendimento

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir atendimento eficiente e acolhedor aos pacientes, realizando agendamentos, cadastro, organização de prontuários e coordenando a manutenção das recepções.	4221-05. Garantir o atendimento acolhedor e eficiente aos pacientes, realizando o direcionamento adequado para consultas, exames ou procedimentos nas recepções médica, odontológica e de laboratório, conforme a necessidade. A recepcionista deve realizar o cadastro completo de novos pacientes no sistema SOC, garantindo a coleta precisa de informações, além de conferir e digitalizar a documentação necessária para o atendimento. Também é responsável pela organização das agendas, agendamento de consultas, bem como o acompanhamento e comunicação das pendências de atendimento. Além disso, deve gerenciar os prontuários, coordenar a organização dos consultórios e atender às solicitações de manutenção e limpeza. Ao migrar entre as recepções, a recepcionista assegura que todos os protocolos sejam seguidos, buscando sempre a eficiência no atendimento e a satisfação dos pacientes.	Recepcionista
Recepcionar pacientes, organizar prontuários, garantir a integridade das informações e apoiar a coordenação odontológica conforme normas de segurança e qualidade.	4221-10. Recepcionar e cadastrar pacientes com eficiência e cordialidade, garantindo a abertura e organização das fichas e prontuários. Manter a integridade das informações no sistema, auxiliar em demandas administrativas e apoiar a coordenação odontológica, sempre em conformidade com as normas de segurança e qualidade de atendimento.	Recepcionista (Foco em Odontologia)

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir atendimento eficiente nas unidades odontológicas, gerenciando prontuários, supervisionando equipes, mantendo equipamentos e materiais, e assegurando a qualidade e conformidade do serviço.	4201-25. Garantir um atendimento acolhedor e eficiente nas diversas unidades de atendimento odontológico, incluindo consultórios, Unidades Móveis Odontológicas (UMOs), além de canais como telefone, WhatsApp e e-mail. O objetivo é gerenciar os prontuários odontológicos, assegurar a correta manutenção dos equipamentos e materiais, e coordenar as atividades das UMOs, com foco na qualidade do serviço prestado. Além disso, será responsável por supervisionar e orientar a equipe odontológica, conduzir treinamentos, estabelecer e monitorar normas e procedimentos, e garantir a integridade das informações no sistema. Atuará também na resolução de reclamações de pacientes, garantindo a excelência do atendimento e o cumprimento das normas operacionais e regulamentares.	Recepcionista Líder
Garantir atendimento eficiente e humanizado aos usuários dos serviços sociais, apoiando as atividades administrativas e promovendo a colaboração para a qualidade e melhoria dos serviços prestados.	4110-10. Garantir um atendimento eficiente e humanizado aos usuários dos serviços sociais, suportar as atividades administrativas e operacionais do departamento de Assistência Social. Facilitar a comunicação e a gestão de informações, promover a colaboração entre parceiros e assegurar a qualidade dos serviços prestados, especialmente aqueles voltados para a assistência social. Contribuir para a melhoria contínua dos processos, apoiar as Assistentes Sociais em campanhas e ações sociais que visem o bem-estar e a saúde dos beneficiários, fortalecer as iniciativas sociais e oferecer suporte integral às demandas dos usuários, parceiros e entidades ligadas ao Seconci.	Auxiliar Administrativo Do Serviço Social

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

BIOLOGICO	Microorganismos Patógenos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Atendimento de pacientes que necessitam de realizar o procedimento de instilação de colírio	Contato com microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	NA	Infecções em geral, risco de acometimento por doenças infecto contagiosas	Qualitativa	Treinamento NR 32, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo) e álcool em gel	****	Eventual	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito (liso)	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	2	2	1	1	6	3	3	6	36	Tolerável

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA
Luva de procedimento	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Óculos de Segurança incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas em processos de obra	A critério da empresa
Máscara N95/ tripla descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 10 - COMERCIAL	
SETOR: COMERCIAL	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 01	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro do escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial. Exposição aos riscos da obra quando estiver visitando clientes.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Identificar e prospectar clientes, negociar propostas comerciais, gerenciar contratos e fidelizar clientes, garantindo soluções que maximizem os resultados e fortaleçam o relacionamento com clientes-chave.	1423-30. Identificar e prospectar potenciais clientes, por meio de estratégias de vendas diversificadas, com o objetivo de expandir a carteira de clientes e gerar novas oportunidades de negócios. Elaboração e negociação de propostas comerciais, garantindo a satisfação dos clientes por meio de um acompanhamento contínuo e estratégias de fidelização. Gerenciamento de contratos comerciais, análise de mercado, monitoramento de resultados de vendas e na representação da empresa em eventos do setor. Garantir que as soluções oferecidas atendam às necessidades dos clientes, maximizando os resultados para a empresa e mantendo um relacionamento sólido com clientes-chave.	Analista Comercial

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI e nas obras	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Impacto em/por objetos na obra	Bater contra algo ou ser atingido por material em queda (durante deslocamento dentro das obras)	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	****	Eventual	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades do setor no canteiro de obras	Corte ou perfuração	****	Risco de infecções, cortes profundos e superficiais	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	****	Eventual	Corrente	1	2	1	1	5	1	3	4	20	Tolerável
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	****	Eventual	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança	Uso dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 11 - MEDICINA	
SETOR: MEDICINA	Data:20/03/2026
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 07	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Proporcionar cuidados médicos especializados, focando na promoção da saúde, prevenção de doenças e bem-estar dos colaboradores, em colaboração com a equipe de saúde ocupacional.	2252-70. Prestar cuidados médicos especializados em ortopedia, diagnosticando, tratando e reabilitando doenças e lesões do sistema musculoesquelético, visando a melhoria da qualidade de vida e mobilidade dos pacientes.	Médico(a) Ortopedista
	2252-65. Prestar cuidados médicos especializados em oftalmologia, realizando diagnósticos, tratamentos e prevenções de doenças oculares, com foco na preservação da saúde visual dos pacientes.	Medico(a) Oftalmologista
	2251-30. Prestar cuidados médicos abrangentes e contínuos aos pacientes, com foco na prevenção, promoção de saúde e gestão de doenças crônicas, atuando como primeiro ponto de contato para cuidados médicos na comunidade.	Médico(a) Da Família E Comunidade
	2252-85. Prestar cuidados médicos especializados na área de urologia, diagnosticando, tratando e prevenindo doenças relacionadas ao sistema urinário e reprodutor masculino, com foco na promoção da saúde e bem-estar dos pacientes.	Médico(a) Urologista

INVENTÁRIO DE RISCOS

Proporcionar cuidados médicos especializados, focando na promoção da saúde, prevenção de doenças e bem-estar dos colaboradores, em colaboração com a equipe de saúde ocupacional.	2241-50. Garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, realizando atendimentos médicos, prevenindo doenças ocupacionais e promovendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Atuar de forma integrada com as demais áreas de saúde ocupacional, implementando ações preventivas, realizando exames periódicos e fornecendo suporte médico no ambiente corporativo.	Médico(a) Do Trabalho
	Garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, realizando atendimentos médicos, prevenindo doenças ocupacionais e promovendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Atuar de forma integrada com as demais áreas de saúde ocupacional, realizando exames ocupacionais sob a supervisão de um médico do trabalho.	Médico(a) Examinador(a)
	2251-20. Proporcionar cuidados médicos especializados em cardiologia, realizando consultas, diagnósticos e tratamentos relacionados às condições do sistema cardiovascular, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e bem-estar dos colaboradores e associados. Atuar de forma integrada com a equipe de saúde ocupacional, contribuindo para a qualidade de vida no ambiente de trabalho.	Médico(a) Cardiologista

INVENTÁRIO DE RISCOS

Executar exames no CDC com precisão, garantir a organização dos laudos e relatórios de produtividade, assegurando qualidade no serviço e bem-estar dos pacientes.	5151-10. Executar com precisão e cuidado os exames no Centro de Diagnósticos e Cardiologia (CDC), como Eletrocardiograma, Holter, Mapa, e outros procedimentos correlatos, assegurando a qualidade técnica e o bem-estar dos pacientes. Garantir a correta organização e envio dos exames para laudo com os cardiologistas, facilitando a entrega eficiente dos resultados. Realizar o fechamento de relatórios mensais de produtividade, consolidando informações com exatidão para controle e acompanhamento dos processos, contribuindo para a eficiência e qualidade do serviço prestado.	Atendente De Serviço De Saúde
Garantir a reabilitação e recuperação dos pacientes, aplicando técnicas fisioterapêuticas, promovendo saúde, prevenção e acompanhamento de resultados, em conformidade com normas de segurança e medicina do trabalho.	901 . Tem como missão realizar atividades administrativas como alimentação do Sistema SOC e documentos, coleta de dados de clientes, comunicação ativa com pacientes, aplicação de técnicas fisioterapêuticas sob supervisão, avaliação de materiais e testes de equipamentos. Além disso, apoia na elaboração de planilhas, relatórios e laudos, cumpre normas de segurança, participa de ações de promoção à saúde e auxilia em auditorias internas e externas.	Estagiário Fisioterapia

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir a saúde auditiva e vocal dos colaboradores, realizando exames, orientações preventivas e promovendo ações de saúde ocupacional no ambiente de trabalho	2238-10. Garantir a saúde auditiva e a qualidade vocal dos colaboradores, realizando exames especializados, fornecendo orientações preventivas, e promovendo ações de saúde ocupacional e qualidade de vida no ambiente de trabalho, alinhado às normas de segurança e medicina do trabalho.	fonoaudióloga
---	--	---------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	P E	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
BIOLÓGICO	Microorganismos Patógenos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Atendimento de pacientes possivelmente portadores de doenças infectocontagiosas ou durante manuseio de materiais contaminados	Contato com microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	NA	Infecções em geral, risco de acometimento por doenças infecto contagiosas	Qualitativa	Treinamento NR 32,uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)e alcool em gel	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
E	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Máscara N95/descartável tripla	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Avental descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Luva de procedimento	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Touca descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 12 - COORDENAÇÃO DE SAÚDE	
SETOR: COORDENAÇÃO DE SAÚDE	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 03	Descrição do Ambiente: 03 profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Coordenar serviços de saúde ocupacional, gerenciar o PCMSO, supervisionar equipes, implementar estratégias de prevenção e promover melhorias para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.	2251-40. Coordenar e garantir a eficiência dos serviços técnicos na área de saúde, promovendo a saúde ocupacional e o bem-estar dos colaboradores. Gerenciar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), monitorando sua execução e conformidade com as normas regulamentadoras. Supervisionar equipes médicas e de apoio, realizar atendimentos e campanhas de prevenção, implementar estratégias de saúde, monitorar a utilização de recursos e promover melhorias contínuas. Gerir crises de saúde, elaborar relatórios e organizar treinamentos, visando um ambiente de trabalho seguro e saudável.	Coordenador(a) De Saúde
	2251-40. Apoiar a coordenação médica na gestão integrada dos serviços de saúde, assegurando a qualidade, eficiência e conformidade dos atendimentos, realizar atendimento médico ocupacional, promovendo um ambiente de trabalho saudável e alinhado às normas vigentes, além de contribuir para o bem-estar e segurança dos colaboradores.	Subcoordenador(a) de Saúde

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

BIOLOGICO	Microorganismos Patógenos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Atendimento de pacientes possivelmente portadores de doenças infectocontagiosas ou durante manuseio de materiais contaminados	Contato com microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	NA	Infecções em geral, risco de acometimento por doenças infecto contagiosas	Qualitativa	Treinamento NR 32, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo) e álcool em gel	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	3	3	6	36	Tolerável
	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	****	Eventual	Corrente	1	2	1	1	5	3	3	6	30	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO		APLICAÇÃO	CA
Máscara N95/descartável tripla	Uso quando em atendimento		A critério da empresa
Avental descartável	Uso quando em atendimento		A critério da empresa
Luva de procedimento	Uso quando em atendimento		A critério da empresa
Touca descartável	Uso quando em atendimento		A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 13 - SAÚDE	
SETOR: SAÚDE	Data: 20/03/2026
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 14	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro do consultório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial. Eventualmente poderá ir à obra ministrar palestras.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir a reabilitação e recuperação dos pacientes, aplicando técnicas fisioterapêuticas, promovendo saúde, prevenção e acompanhamento de resultados, em conformidade com normas de segurança e medicina do trabalho.	2236-05. Garantir a reabilitação e a recuperação dos pacientes, aplicando técnicas fisioterapêuticas de acordo com os protocolos estabelecidos, promovendo a saúde e o bem-estar dos colaboradores e associados. Desenvolver estratégias de prevenção e reabilitação, com foco em melhorias contínuas, treinamento educativo, e acompanhamento detalhado dos resultados dos atendimentos, sempre assegurando a conformidade com normas de segurança e medicina do trabalho.	Fisioterapeuta
Auxiliar na gestão de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, realizando auditorias, treinamentos e colaborando em ações para garantir conformidade com a legislação.	4153-10. Colaborar na elaboração e edição de documentos relacionados à saúde, solicitando cópias físicas e digitais de programas como PGR, PCMAT, LTCAT e outros ligados à Segurança do Trabalho. Apoiar nas atividades administrativas da área de Saúde e cumprirá as demandas em Medicina Ocupacional, especialmente aquelas relacionadas à NR-7 (PCMSO). Contribuir para a comunicação com as Empresas Seconci Goiás e apoiará ações de promoção e proteção à saúde dos associados, colaboradores e prestadores de serviços. Auxiliar no controle de planilhas, relatórios de indicadores de Saúde e Medicina Ocupacional, e na gestão de saúde corporativa, colaborando na implementação de programas e procedimentos em Assistência de Saúde. Auxiliar nas auditorias, fiscalizações, visitas e eventos do Departamento de Assessoria de Saúde, propondo melhorias.	Assistente de saúde I

INVENTÁRIO DE RISCOS

Auxiliar na gestão de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, realizando auditorias, treinamentos e colaborando em ações para garantir conformidade com a legislação.	4153-10. Colaborar na elaboração e edição de documentos relacionados à saúde, solicitando cópias físicas e digitais de programas como PGR, PCMAT, LTCAT e outros ligados à Segurança do Trabalho. Apoiar nas atividades administrativas da área de Saúde e cumprirá as demandas em Medicina Ocupacional, especialmente aquelas relacionadas à NR-7 (PCMSO). Contribuir para a comunicação com as Empresas Seconci Goiás e apoiará ações de promoção e proteção à saúde dos associados, colaboradores e prestadores de serviços. Auxiliar no controle de planilhas, relatórios de indicadores de Saúde e Medicina Ocupacional, e na gestão de saúde corporativa, colaborando na implementação de programas e procedimentos em Assistência de Saúde. Auxiliar nas auditorias, fiscalizações, visitas e eventos do Departamento de Assessoria de Saúde, propondo melhorias.	Assistente de saúde II
---	---	-------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												

INVENTÁRIO DE RISCOS

FÍSICO	Radiação não ionizante	Exposição a luz solar em atividades e ações externas	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de EPIs ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	****	Normal	Corrente	1	1	1	3	6	1	3	4	24	Tolerável
QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
BIOLÓGICO	Microorganismos Patógenos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Atendimento de pacientes possivelmente portadores de doenças infectocontagiosas ou durante manuseio de materiais contaminados	Contato com microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	NA	Infecções em geral, risco de acometimento por doenças infectocontagiosas	Qualitativa	Treinamento NR 32, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo) e álcool em gel	****	Normal	Corrente	2	2	2	3	9	3	3	6	54	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONÔMICO	Postural	Mobiliário inadequado	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
------------	----------	-----------------------	--	------	--	---	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI e nas obras	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	****	Eventual	Corrente	1	2	1	3	7	3	3	6	42	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Impacto em/por objetos na obra	Bater contra algo ou ser atingido por material em queda (durante deslocamento dentro das obras)	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	****	Eventual	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável
	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades do setor no canteiro de obras	Corte ou perfuração	****	Risco de infecções, cortes profundos e superficiais	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Máscara N95/ tripla descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Luva de procedimento	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Avental descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Touca descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Capacete de Segurança com jugular	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa
Botina de Segurança	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 14 - SERVIÇO SOCIAL		
SETOR: SERVIÇO SOCIAL		Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02		Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes		
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Prestar suporte social estratégico, desenvolvendo programas e parcerias para promover o bem-estar e garantir o cumprimento de direitos e deveres conforme as normas vigentes.	2516-05. Prestar suporte social estratégico, desenvolvendo e implementando programas e parcerias que promovam o bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades atendidas pela entidade, garantindo o cumprimento de direitos e deveres conforme as normas, códigos e legislações vigentes.	Assistente Social

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Radiação não ionizante	Exposição a luz solar em atividades e ações externas	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	NA	Normal	Corrente	1	1	1	3	6	1	3	4	24	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
	Piso com baixo coeficiente de atrito	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI e nas obras	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	Eventual	Corrente	1	2	1	3	7	3	3	6	42	Tolerável
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Impacto em/por objetos na obra	Bater contra algo ou ser atingido por material em queda (durante deslocamento dentro das obras)	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	Eventual	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades do setor no canteiro de obras	Corte ou perfuração	****	Risco de infecções, cortes profundos e superficiais	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	Treinamentos e orientações diversas ao trabalhador	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	1	3	4	24	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

INVENTÁRIO DE RISCOS

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso quando em ações externas	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 15 - SEGURANÇA DO TRABALHO		
SETOR: SEGURANÇA DO TRABALHO	Data: 19/03/2025	
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 06	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho dentro do escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.	
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes		
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Liderar a área de Segurança do Trabalho do Seconci-Goiás, garantindo conformidade normativa, otimizando processos, coordenando equipes e fornecendo consultoria para promover a segurança e saúde ocupacional.	2149-15. Liderar e otimizar a área de Segurança do Trabalho do Seconci - Goiás, garantindo a conformidade com as normas regulamentadoras e legislação vigente. Desenvolver e implementar estratégias e processos eficazes para atender às demandas das empresas associadas, assegurando a excelência nos serviços prestados. Coordenação técnica e a gestão da equipe, a criação de padrões e documentos, e a organização de treinamentos e eventos. Responsável pela gestão de contratos, monitoramento de KPIs e interação com órgãos de fiscalização. Representar tecnicamente a entidade e fornecer consultoria especializada, promovendo a segurança e saúde ocupacional em todas as operações.	Coordenador(a) Segurança Do Trabalho

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir um ambiente seguro e sustentável, implementando políticas eficazes de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, promovendo conformidade normativa e saúde ocupacional.	2149-15. Garantir um ambiente de trabalho seguro e sustentável, por meio de diagnósticos detalhados e implementação de políticas eficazes em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Desenvolver e monitorar programas e documentos técnicos, como PGR, LTCAT e PGRSS, promovendo a conformidade com normas regulamentadoras e legislações vigentes. Realizar treinamentos, investigações de acidentes e campanhas educativas, além de implementar medidas de higiene ocupacional e gerenciar dados de SST no e-Social. Atuar de forma colaborativa e estratégica, assegurando a qualidade de vida, a saúde ocupacional e a preservação ambiental.	Engenheiro(a) De Segurança Do Trabalho
Realizar levantamentos para elaborar o PGR, identificar riscos, gerenciar dados no sistema, implementar políticas de SST, prestar primeiros socorros, investigar acidentes e atuar na gestão da CIPA.	3516-05. Desempenhar atividades de levantamento e registro para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e laudos técnicos, avaliando condições de trabalho para identificar riscos e propor melhorias. Gerenciar e atualizar dados no sistema, incluindo envios para o e-Social. Auxiliar na implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde e políticas de saúde e segurança do trabalho. Realizar diagnósticos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), desenvolvendo ações educativas. Prestar primeiros socorros, investigar acidentes de trabalho, recomendando medidas de prevenção e controle, e preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Cumprir determinações de segurança, utilizar EPIs e atuar na gestão da CIPA conforme normas reguladoras.	Técnico(a) Em Segurança Do Trabalho Senior IV

INVENTÁRIO DE RISCOS

Apoiar na elaboração e monitoramento do PGR, realizar treinamentos, investigar acidentes, propor melhorias nas condições de trabalho e gerenciar EPIs, além de realizar avaliações ambientais e fornecer primeiros socorros.	3516-05. Responsável por apoiar ativamente a elaboração, implementação e monitoramento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e documentos correlatos, com foco na saúde e segurança do trabalho. Deverá contribuir para o cumprimento das normas e regulamentos, com a realização de treinamentos, palestras e ações educativas voltadas para a segurança dos colaboradores, além de diagnosticar e propor melhorias nas condições de trabalho. Também será incumbido de realizar investigações de acidentes, controle de variáveis relacionadas à saúde, meio ambiente e qualidade de vida, e gerenciar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O cargo envolve, ainda, a coleta e análise de dados para o E-Social, a realização de avaliações ambientais, e a assistência em primeiros socorros, quando necessário.	Técnico(a) Em Segurança Do Trabalho junior I
---	---	---

INVENTÁRIO DE RISCOS

Realizar levantamentos e registros para o PGR, identificar riscos, propor melhorias, gerenciar dados no e-Social, implementar políticas de SST, realizar diagnósticos, treinamentos e gerenciar EPIs e a CIPA.	3516-05. Responsável por realizar levantamentos e registros qualitativos e quantitativos para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e outros laudos técnicos, identificando riscos nas condições de trabalho e propondo melhorias. Contribuirá para a elaboração de documentos para empresas filiadas e para a Entidade, além de gerenciar e atualizar dados no sistema e garantir o envio correto para o e-Social. Auxiliará na implementação, controle e treinamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde e implementará políticas de saúde e segurança do trabalho. Realizará diagnósticos sobre a situação de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) na instituição, identificando variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Ministrará treinamentos e ações educativas, realizará avaliações ambientais e gerenciará o uso de EPIs.Abertura de CAT. Gestão da CIPA.	Técnico(a) Em Segurança Do Trabalho junior II
--	--	---

INVENTÁRIO DE RISCOS

Responsável por auxiliar na implementação e monitoramento do Programa de Gerenciamento de Riscos, com foco na segurança e saúde do trabalho, incluindo treinamentos, investigações de acidentes e controle de EPIs	4110-10. Responsável por auxiliar ativamente a elaboração, implementação e monitoramento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e documentos correlatos, com foco na saúde e segurança do trabalho. Deverá contribuir para o cumprimento das normas e regulamentos, com a realização de treinamentos, palestras e ações educativas voltadas para a segurança dos colaboradores, além de diagnosticar e propor melhorias nas condições de trabalho. Também será incumbido de realizar investigações de acidentes, controle de variáveis relacionadas à saúde, meio ambiente e qualidade de vida, e gerenciar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O cargo envolve, ainda, a coleta e análise de dados para o E-Social, a realização de avaliações ambientais, e a assistência em primeiros socorros, quando necessário.	Assistente de Segurança do trabalho
--	--	-------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Responsável por auxiliar na implementação e monitoramento do Programa de Gerenciamento de Riscos, com foco na segurança e saúde do trabalho, incluindo treinamentos, investigações de acidentes e controle de EPIs	2149-35. Responsável por liderar e validação de Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) internos e externos, além de supervisionar e orientar os técnicos de segurança do trabalho. Acompanhar a produtividade do setor, alimentando sistemas e planilhas, e fornecendo feedbacks contínuos à equipe e gestores. Liderança interina do departamento na ausência do gestor, participação ativa em processos seletivos e no agendamento de palestras, acompanhamento da implementação de políticas de saúde e segurança do trabalho. Responsável pela realização de diagnósticos, investigações de acidentes, e pela criação de documentos e laudos para empresas filiadas e para a instituição, sempre com o objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentadoras, promover a segurança e a saúde no ambiente de trabalho e implementar ações preventivas para a melhoria contínua das condições de trabalho e qualidade de vida dos colaboradores.	Tecnólogo(a) Em Segurança Do Trabalho
--	---	---------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Assegurar a excelência técnica e a conformidade legal em Saúde e Segurança do Trabalho (SST) para as empresas clientes, atuando como um parceiro estratégico no desenvolvimento de soluções de engenharia e ações educativas. O foco principal é a antecipação e o controle de riscos através da elaboração de documentos técnicos (PGR, LTCAT), realização de auditorias e suporte à gestão de saúde ocupacional (PCMSO). Busca a fidelização dos clientes por meio de um relacionamento próximo, consultivo e da promoção de uma cultura preventiva sólida, visando a preservação da integridade física dos trabalhadores e a sustentabilidade operacional das organizações.	2149-15. Realizar levantamentos de campo e análise técnica de riscos para subsidiar a elaboração do PGR e fornecer suporte especializado ao LTCAT. Efetuar vistorias e medições de agentes nocivos, aplicando conhecimentos de engenharia para identificar perigos e propor medidas de controle coletivo e individual. Propor soluções técnicas de engenharia e medidas corretivas para mitigação de riscos. Realizar auditorias internas e vistorias de segurança, emitindo relatórios de conformidade. Analisar dados técnicos para orientar a elaboração do PCMSO e garantir o cumprimento das Normas Regulamentadoras. Ministrar treinamentos técnicos de NRs (como NR-10 para elétricos, NR-35 e NR-12) e desenvolver campanhas educativas. Elaborar planos, laudos e documentos técnicos de SST, atuando na fidelização de clientes através do suporte consultivo e da garantia da integridade física dos colaboradores.	Analista de Segurança do Trabalho
---	--	--

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

FÍSICO	Ruído	Inspeção e acompanhamento de serviços no canteiro de obras	Perda auditiva permanente	Será avaliado quando da elaboração do LTCAT	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível.	Anexo 1 da NR 15, dosimetria de ruído com fator de dobra 5 dB (q = 5)	Uso de EPIs ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Eventual	Corrente	1	1	1	1	4	3	3	6	24	Trivial
--------	-------	--	---------------------------	---	--	---	---	--------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

ERGONÔMICO																			
Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável
ACIDENTE																			
Arranjo fisico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação (quando estiver em obras)	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	
Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda (quando em auditorias, visitas e etc... Obras) Queda de altura **** Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados. Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA) Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA **** Normal Corrente 3 2 1 2 8 3 3 6 48 Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de direção defensiva	****	Eventual	Corrente	1	2	1	3	7	3	3	6	42	Tolerável
----------	---	---	----------------------	------	---	--	----------------------------------	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 16 - ODONTOLOGIA 02	
SETOR: ODONTOLOGIA 02	Data: 19/03/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 07	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro do consultório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial. visitas e atendimentos na obra (trailer).
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Garantir a excelência no atendimento odontológico, supervisionando a equipe, implementando treinamentos, protocolos, e planos estratégicos, além de atuar como Responsável Técnico e assegurar conformidade com normas e regulamentos	2232-08. Garantir a excelência técnica e ética no atendimento odontológico ao acompanhar, avaliar e orientar a equipe, promover treinamentos contínuos, planejar e gerenciar a área odontológica, monitorar a manutenção dos equipamentos, produzir relatórios para a Superintendência e Diretoria, realizar atendimentos clínicos, desenvolver materiais educativos, conduzir palestras, supervisionar tomadas radiográficas, implementar protocolos clínicos e administrativos, desenvolver planos estratégicos e atuar como Responsável Técnico (RT), assegurando conformidade com normas e regulamentações.	Coordenador(a) Odontológico(a)

INVENTÁRIO DE RISCOS

Garantir a excelência no atendimento odontológico, organizando materiais, auxiliando o cirurgião, gerenciando insumos, mantendo equipamentos e cumprindo normas de segurança, tanto no Seconci Goiás quanto na Unidade Móvel Odontológica (UMO).	3224-15. Garantir a excelência no atendimento odontológico ao preparar e organizar os instrumentais e materiais, instrumentalizar o cirurgião dentista durante procedimentos clínicos, manipular materiais conforme necessário, participar do gerenciamento de insumos, cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos, realizar a higienização adequada, auxiliar em radiografias, cumprir normas de segurança, e executar outras atividades conforme orientação, tanto no Seconci Goiás quanto na Unidade Móvel Odontológica (UMO).	Auxiliar De Saúde Bucal (20 h)
	3224-15. Garantir a excelência no atendimento odontológico ao preparar e organizar os instrumentais e materiais, instrumentalizar o cirurgião dentista durante procedimentos clínicos, manipular materiais conforme necessário, participar do gerenciamento de insumos, cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos, realizar a higienização adequada, auxiliar em radiografias, cumprir normas de segurança, e executar outras atividades conforme orientação, tanto no Seconci Goiás quanto na Unidade Móvel Odontológica (UMO).	Auxiliar De Saúde Bucal (44 h)

INVENTÁRIO DE RISCOS

Prestar atendimento odontológico integral, realizando ações preventivas, diagnósticas e curativas, com foco na qualidade, segurança e bem-estar dos pacientes.	2232-08. Prestar atendimento odontológico integral aos pacientes, promovendo a saúde bucal por meio de ações preventivas, diagnósticas e curativas. Conduzir consultas detalhadas, realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos dentro do escopo da odontologia geral, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade. Assegurar a correta identificação e tratamento de condições odontológicas, incluindo a solicitação de exames complementares e encaminhamento para especialistas quando necessário. Manter registros clínicos atualizados e coordenar o acompanhamento dos pacientes, garantindo a continuidade do cuidado. Atuar em diferentes unidades, incluindo a Unidade Móvel Odontológica, sempre com foco na segurança, bem-estar e satisfação dos pacientes.	Odontólogo(a) - Clínico Geral
---	---	--------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Conduzir atendimentos odontológicos, realizar tratamentos, cirurgias, exames e prescrições, manter prontuários atualizados e cumprir normas de segurança.	2232-12. Conduzir entrevistas com pacientes para coletar histórico médico e odontológico, identificar sintomas e queixas; realizar radiografias intra; realizar tratamentos endodônticos, remoção de pinos, coroas protéticas, limpezas dentárias, fluoterapia e extrações simples; executar cirurgias orais e restaurações dentárias; solicitar exames complementares, prescrever medicamentos e encaminhar pacientes a especialistas; atender urgências odontológicas; preencher e manter prontuários atualizados; reagendar consultas para acompanhamento; atender na Unidade Móvel Odontológica quando designado; cumprir normas de segurança, utilizando EPIs; realizar outras atividades conforme orientação do superior imediato.	Odontólogo(a) - Endodontista
---	--	------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Realizar atendimentos odontológicos completos, incluindo procedimentos clínicos, cirúrgicos e emergenciais, mantendo registros atualizados e cumprindo normas de segurança.	2232-08. Realizar atendimentos na Unidade Móvel Odontológica e no SECONCI Goiás, conduzir entrevistas detalhadas para coletar histórico médico, executar radiografias e procedimentos endodônticos, realizar limpezas dentárias, extrações, cirurgias orais e restaurações, prescrever medicamentos e solicitar exames, orientar sobre cuidados pós-tratamento, atender urgências odontológicas, manter registros precisos, coordenar reagendamentos de consultas, e cumprir normas de segurança no trabalho, garantindo um atendimento integrado e de alta qualidade aos pacientes.	Odontólogo(a) - Clínico Geral - UMO
---	--	-------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
			Perfil de exposição																	
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Radiação ionizante	Exposição a radiação ionizante ao tirar raio x de pacientes internos e externos (realizado dentro do Seconci)	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	Laudo Radiométrico e previsão no LTCAT	Aumentam os riscos de doenças como neoplasias, anemia aplástica, púrpura, radiodermatite, infertilidade, entre outras	Qualitativa	Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

FÍSICO	Ruído	Exposição ao ruído provocado ao atender paciente e proximidade de equipamentos na obra	Perda auditiva permanente	Será avaliado quando da elaboração do LTCAT	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação,, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

FÍSICO	Vibração localizada s (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos (micromotor, e etc..)	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Será avaliado quando da elaboração do LTCAT	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Anexo 8 da NR 15	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Nível de ação: 2,5 m/s² Limite de tolerância : 5m/s²	Normal	Corrente	2	2	2	2	8	3	3	6	48	Moderado
--------	-------------------------------------	---	--	---	---	------------------	---	---	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------

INVENTÁRIO DE RISCOS

QUÍMICO	Álcool etílico	Em atividades no consultório odontológico - uso diversificado em diversos processos de limpeza	Inalação, dérmica (pele), queimaduras e danos nos olhos e córnea	Será avaliado quando da elaboração do LTCAT	Irritante para a pele. Irritante para os olhos. Prejudicial se ingerido.	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Anexo 11 da NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
Biológico	Microorganismos Patógenos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Atendimento de pacientes possivelmente portadores de doenças infectocontagiosas ou durante manuseio de materiais contaminados	Contato com microorganismos patogênicos (bactérias, vírus, fungos e protozoários)	NA	Infecções em geral, risco de acometimento por doenças infectocontagiosas	Qualitativa	Treinamento NR 32, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo) e álcool em gel	****	Normal	Corrente	2	2	2	3	9	3	3	6	54	Moderado
ERGONÔMICO	Postural	Posturas desconfortáveis durante a atividade	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a autoclave	queimaduras	****	queimaduras, escalduras e ferimentos	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções	****	Normal	Corrente	3	2	1	2	8	3	3	6	48	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERID ADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um periodo de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

INVENTÁRIO DE RISCOS

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Luva contra agentes térmicos e mecânicos	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Capacete de Segurança com jugular	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa
Botina de Segurança	Uso dentro do canteiro de obras/ações externas	A critério da empresa
Jaleco	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Máscara cirúrgica /tripla descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Avental descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Luva de procedimento	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Touca descartável	Uso quando em atendimento	A critério da empresa
Calçado fechado	Uso contínuo dentro da instituição	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso quando em ações externas	A critério da empresa
Bota PVC	Uso em dias chuvosos	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso em dias chuvosos	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamento NR 17 (Ergonomia)	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 17 - ADM SAÚDE	
SETOR: ADM SAÚDE	Data: 20/03/2026
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 06	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Auxiliar na gestão de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, realizando auditorias, treinamentos e colaborando em ações para garantir conformidade com a legislação.	4110-10. Auxiliar na elaboração, análise e controle de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, com foco em auditorias de PGR, LTCAT e PCMSO, contribuindo para a conformidade com a legislação vigente, especialmente NR-7. O assistente também desempenha atividades administrativas, realiza palestras e treinamentos, e colabora com empresas parceiras e a equipe interna na promoção de ações de saúde e segurança. Participa de auditorias internas e externas, elabora relatórios e auxilia no desenvolvimento de programas e procedimentos de saúde corporativa.	Assistente de saúde e segurança do trabalho

INVENTÁRIO DE RISCOS

Auxiliar na gestão de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, realizando auditorias, treinamentos e colaborando em ações para garantir conformidade com a legislação.	3222-35. Cumprir com excelência todas as demais atividades inerentes ao cargo. Executar outras atividades pertinentes ao cargo estabelecidas pelo superior imediato. Reportar à Coordenação e Subcoordenação o andamento de ações, projetos e programas da Saúde, sugerindo melhorias sempre que possível. Apoiar tecnicamente a recepção médica e contribuir para o desenvolvimento de todos os setores de saúde. Apoiar na entrega técnica do PCMSO e do Relatório Analítico do PCMSO na obra. Auxiliar na atualização de documentos internos relacionados à Saúde. Auxiliar na elaboração de materiais informativos. Auxiliar na execução de atividades de saúde ocupacional e assistencial. Auxiliar no controle e na geração de relatórios de indicadores de Saúde, bem como outros relatórios da Medicina Assistencial e Medicina Ocupacional. Controlar os status dos ASOs retidos há mais de 48 horas, mantendo comunicação contínua com os clientes até a resolução das pendências.	Auxiliar de saúde
Garantir a saúde auditiva e vocal dos colaboradores, realizando exames, orientações preventivas e promovendo ações de saúde ocupacional no ambiente de trabalho	2238-10. Garantir a saúde auditiva e a qualidade vocal dos colaboradores, realizando exames especializados, fornecendo orientações preventivas, e promovendo ações de saúde ocupacional e qualidade de vida no ambiente de trabalho, alinhado às normas de segurança e medicina do trabalho.	fonoaudióloga

INVENTÁRIO DE RISCOS

Prestar atendimento odontológico integral, realizando ações preventivas, diagnósticas e curativas, com foco na qualidade, segurança e bem-estar dos pacientes.	2232-08. Prestar atendimento odontológico integral aos pacientes, promovendo a saúde bucal por meio de ações preventivas, diagnósticas e curativas. Conduzir consultas detalhadas, realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos dentro do escopo da odontologia geral, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade. Assegurar a correta identificação e tratamento de condições odontológicas, incluindo a solicitação de exames complementares e encaminhamento para especialistas quando necessário. Manter registros clínicos atualizados e coordenar o acompanhamento dos pacientes, garantindo a continuidade do cuidado. Atuar em diferentes unidades, incluindo a Unidade Móvel Odontológica, sempre com foco na segurança, bem-estar e satisfação dos pacientes.	Odontólogo(a) - Clínico Geral
---	---	--------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Radiação não ionizante	Exposição a luz solar em atividades e ações externas	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	NA	Normal	Corrente	2	1	1	1	5	1	1	2	10	Trivial

INVENTÁRIO DE RISCOS

QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONÔMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Trivial

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso com baixo coeficiente de atrito	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI e nas obras	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Trivial
----------	--------------------------------------	---	----------------------	------	---	--	---	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de condução segura	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 18 - ADM PATRIMONIO	
SETOR: ADM SAÚDE	Data: 20/04/2026
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 06	Descrição do Ambiente: O profissional realiza o trabalho dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente artificial.
Responsável pela empresa: Bruno Alvarenga de Menezes	
Coordenador do PGR: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
PROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
A atuação do cargo está direcionada a atividades administrativas, de controle e acompanhamento, não contemplando execução de atividades operacionais de manutenção.	4110-10. Realizar atividades administrativas de controle patrimonial e apoio à gestão de manutenção predial, por meio do registro, organização e acompanhamento de informações, fornecedores e documentos, sem execução de atividades operacionais de manutenção, sem exposição a agentes químicos, trabalho em altura ou esforço físico intenso, conforme diretrizes de Segurança e Saúde no Trabalho.	Analista Administrativo de Patrimônio

INVENTÁRIO DE RISCOS

[illegible]

INVENTÁRIO DE RISCOS

QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
Biológico	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												NA
ERGONOMÍCO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Trivial

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Piso com baixo coeficiente de atrito	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do SECONCI e nas obras	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza da instituição, uso de calçado fechado. Proteções coletivas tais como: sinalização, identificação. Treinamentos	****	Eventual	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Trivial
----------	--------------------------------------	---	----------------------	------	---	--	---	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
DE	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.

INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
--------------------------------------	-----------	----

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamentos riscos ocupacionais conforme NR 01	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções e bienal
Treinamento de EPIs conforme NR 06	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções
Treinamentos NR 32	Atualizar colaboradores; antes do trabalhador recém contratado iniciar suas funções

Inventário de Produtos Químicos

Empresa SECONCI GOIAS			Obra / Setor SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)		
Data do levantamento 28/03/2025		Responsável pelo levantamento CRISTIANE MIRANDA		Página / Páginas	
Identificação do produto			Informações sobre uso do produto		
Item	Nome comercial do produto	Fabricante	Equipe usuária (Setor)	Função usuária	Local de armazenamento
1	LIM+ (LIMPA ALUMININIO CONCENTRADO)	SEVENGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
2	AUDAX ALL CLEAN ALCOOL GEL 70%	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
3	CLARITY CARE ALCOOL GEL 70%	ADATA INSDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
4	PREMISSE SABONETE ESPUMA MORANGO&CHAMPAGNE	PROLINE INDUSTRIA E COMERCIO	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
5	ASSIM (SABÃO EM PO BICABORNATO)	FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
6	ÁGUA SANITÁRIA (KI-JOIA	N&L INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
7	LAVA-LOUÇAS (KI-JOIA	N&L INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
8	AZULIM (DESINFETANTE PERFUMADO)	LIMA&PERGHER E COMERCIO S.A	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
9	DEO LINE LIMPADOR PERFUMADO)	DEOLIMP INDUSTRIA E COMÉRCIO	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA

10	AUDAX GOLD LIMPADOR GERAL	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
11	LIM PIM LIMPA PORCELANATOS	USELIMP	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
12	CRUZEIRO LIMPA VIDROS	LIMPIS INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
13	START PRO (LIMPA PORCELANATO)	LIMA& PERGHER INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
14	LIMPADOR FLOTADOR MAXIMCOM	LIMA& PERGHER INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
15	TOP GLASS LIMPA VIDROS	VINIX INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
16	ALUMIL (START) BRILHA ALUMINIO	LIMA& PERGHER INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
17	DOWNY AMACIANTE DE ROUPA	PROCTER&GAMBLE INDUSTRIAL	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
18	DETECH LP DETERGENTE DESEGRAXANTE (AD PRO)	ITW FLUIDS & HYGIENE	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
19	ALCOOL J.FERES 70%	FERES&FERES INDUSTRIA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
20	SCOTCH BRITE LIMPADOR INOX		SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	LAVANDEIRIA
22	SOLVENTE (TINNER)	LUZTOL TINTAS	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
24	LUBRIFICANTE STARRETT	STARRETT INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
25	COLA DE CANO - TIGRE	TIGRE MATERIAIS	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO

26	COLA ADESIVA (COLA BONDER)	TEK BOND	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
29	ALCOOL 70% ITAJA	JALLES MACHADO S.A	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
30	ALCOOL 70% J.FERES	FERES&FERES	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
31	ADW ADITIVO - AUTO MOTOR(MOTORMAX)	PROBIL INDUSTRIA	MANUTENÇÃO	ASSISTENTE MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO	ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO - SUBSOLO
37	AUDAX ALL CLEAN ALCOOL GEL 70%	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA	MEDICINA	MÉDICO (A)	CONSULTÓRIO
38	CLARITY CARE ALCOOL GEL 70%	ADATA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MEDICINA	MÉDICO (A)	CONSULTÓRIO
39	VIC PHARMA ALCOOL 70%	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	MEDICINA	MÉDICO (A)	CONSULTÓRIO
40	PERIO PLAK (SOLUÇÃO ANTISSEPTICA	REYMER DO BRASOL INDUSTRIA	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
41	ASFER SODA CLORADA	ASFER INDUSTRIA QUIMICA	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
42	DETERGENTE ENZIMATICO/ZYMEDET GOLD	PROLINK INDUSTIA QUIMI	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
43	AGUA OXIGENDA	RIOQUIMICA S.A	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
44	CLORO RIO 2,5%	RIOQUIMICA S.A	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
45	CHUMBO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
46	ÁCIDO FOSFÓRICO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO

47	ACRÍLICO LÍQUIDO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
48	ÁLCOOL		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
49	BUTANO (SPRAY)		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
50	OLÉO LUBRIFICANTES		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
51	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
52	PERÓXIDO HIDROGÊNIO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
53	PROPILENOGLICOL		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
54	REVELADOR ODONTOLÓGICO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
55	EDTA		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
56	ÁCIDO ETILENODIAMINA TETRACÉTICO		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
57	GBX FIXADOR E REMOVEDOR		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
58	REVELADOR E REFORÇADOR GBX		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
59	detergente enzimático		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
60	fixador		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO

61	fluoretos (sódio, cálcio e potássio)		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
62	formocresol		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
63	fosfato de cálcio		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
64	glutaraldeído		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
65	hemostático		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
66	hipoclorito de sódio		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
67	latex		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
68	metal pesado como prata e mercúrio		ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	ALMOXARIFADO
69	RIOHER GARD 0,12%	RIOQUIMICA S.A	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	CONSULTÓRIO
70	AUDAX ALL CLEAN ALCOOL GEL 70%	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	CONSULTÓRIO
71	CLARITY CARE ALCOOL GEL 70%	ADATA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	CONSULTÓRIO
72	VIC PHARMA ALCOOL 70%	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	ODONTOLOGIA	DENTISTA(CD E ASB)	CONSULTÓRIO

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Chlamydia trachomatis	2	Fonte de exposição e reservatórios	Chlamydia trachomatis é uma bactéria que causa infecções sexualmente transmissíveis, sendo a principal fonte de exposição o contato sexual desprotegido com uma pessoa infectada. A bactéria pode ser transmitida por relações sexuais vaginais, anais e orais. Além disso, C. trachomatis pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto, resultando em infecções oculares ou respiratórias no recém-nascido. Em termos de reservatórios, os humanos são os únicos hospedeiros conhecidos para Chlamydia trachomatis. A infecção é assintomática em muitos casos, o que contribui para a transmissão silenciosa. A prevenção é baseada no uso de preservativos e na realização de testes regulares, especialmente em populações sexualmente ativas.
		Vias de transmissão e de entrada	As vias de transmissão de Chlamydia trachomatis, bactéria causadora de infecções sexualmente transmissíveis, ocorrem principalmente por contato sexual desprotegido (vaginal, anal ou oral) com uma pessoa infectada. A transmissão também pode ocorrer de mãe para filho durante o parto, resultando em infecção ocular ou pulmonar no recém-nascido. As vias de entrada do Chlamydia trachomatis no organismo são através das mucosas do trato genital, uretra, reto, faringe e em alguns casos, os olhos
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	A clamídia é transmitida principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, seja oral, vaginal ou anal. Também pode ser transmitida de uma mulher grávida para o bebê durante o parto. A clamídia pode afetar vários órgãos do corpo, como a uretra, o colo do útero e o reto. Nas mulheres, pode causar cervicite, uretrite e doença inflamatória pélvica. Nos homens, pode causar uretrite e, menos frequentemente, epididimite. Em ambos, pode causar infecção do reto, linfogranuloma venéreo e artrite reativa. A clamídia é uma bactéria muito pequena e não pode ser vista com um microscópio convencional. Na maioria das vezes, a infecção genital não causa sintomas, mas pode levar a sérias consequências a longo prazo.
		Persistência do agente biológico no ambiente	A Chlamydia trachomatis tem baixa persistência no ambiente externo, pois é uma bactéria intracelular obrigatória que precisa de células hospedeiras para sobreviver e se replicar. Fora do corpo humano, ela não sobrevive por longos períodos e rapidamente perde a capacidade de infectar. A principal forma de transmissão é através do contato direto com mucosas, e não pela contaminação ambiental.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Chlamydia trachomatis é uma das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) mais comuns em todo o mundo. Estudos epidemiológicos mostram que as mulheres jovens, especialmente aquelas entre 15 e 24 anos, têm maior risco de infecção. A prevalência global é alta, com milhões de novos casos diagnosticados anualmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 1 em cada 20 mulheres sexualmente ativas jovens seja afetada. A infecção pode ser assintomática, o que dificulta a detecção e aumenta o risco de complicações, como infertilidade.
		Outras informações científicas	Chlamydia trachomatis é uma bactéria que causa infecções sexualmente transmissíveis (IST), sendo a principal causa de uretrite em homens e cervicite em mulheres. Estima-se que 130 milhões de novos casos de clamídia ocorram globalmente a cada ano. Muitas infecções são assintomáticas, o que aumenta o risco de complicações, como infertilidade, doença inflamatória pélvica (DIP) e gravidez ectópica. A infecção pode ser diagnosticada por testes laboratoriais e tratada com antibióticos, sendo a prevenção feita através do uso de preservativos e testes regulares em populações de risco. A clamídia também é uma das principais causas de cegueira em países com pouca infraestrutura de saúde, quando afeta o olho, conhecida como tracoma.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Enterococcus spp	2	Fonte de exposição e reservatórios	Pode ocorrer principalmente por contato com águas contaminadas, alimentos mal processados ou pela manipulação inadequada de produtos contaminados. Os reservatórios naturais desses microrganismos incluem o trato intestinal de humanos e animais, além de ambientes como esgoto e águas poluídas.
		Vias de transmissão e de entrada	Enterococcus spp. são bactérias gram-positivas que podem causar infecções em humanos, especialmente devido à sua resistência a antibióticos. Elas estão presentes no trato intestinal humano e animal, além de ambientes hospitalares. As principais vias de transmissão incluem contato direto com pessoas ou superfícies contaminadas, transmissão fecal-oral por alimentos ou água contaminados, e ambientes hospitalares com dispositivos invasivos. Também podem ser transmitidas por contato com animais ou produtos contaminados. As vias de entrada no corpo humano são principalmente pelo trato gastrointestinal, urinário, respiratório e sanguíneo, frequentemente associadas ao uso de dispositivos invasivos. O controle dessas infecções envolve práticas rigorosas de higiene, controle hospitalar e uso prudente de antibióticos devido à resistência das bactérias.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por contato direto com secreções ou superfícies contaminadas, especialmente em ambientes hospitalares. Pode ser transmitido também por instrumentos médicos contaminados. Causa infecções quando se desloca para áreas fora do trato gastrointestinal, como infecções urinárias, endocardite, septicemia e infecções associadas a dispositivos médicos. Possui virulência moderada. A resistência a antibióticos, como resistência à vancomicina (VRE), aumenta sua virulência, dificultando o tratamento das infecções.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Enterococcus spp. possui boa persistência no ambiente, sendo capaz de sobreviver por longos períodos em superfícies, água e no solo, devido à sua resistência a condições adversas, como mudanças de temperatura e desinfetantes. Essas bactérias podem ser transmitidas por contaminação fecal-oral, tornando a higiene e o saneamento essenciais para prevenir infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Enterococcus spp. é frequentemente identificado em infecções nosocomiais (hospitalares), como infecções do trato urinário e septicemia. Estudos epidemiológicos indicam que Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium são as espécies mais prevalentes. O aumento da resistência a antibióticos, como a vancomicina (VRE), tem sido uma preocupação crescente. Nos Estados Unidos, cerca de 30% das infecções por enterococos hospitalares são causadas por cepas resistentes. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com superfícies ou equipamentos contaminados em ambientes de saúde.
		Outras informações científicas	Enterococcus spp. são bactérias que fazem parte da flora intestinal normal de humanos e animais, mas também podem causar infecções, especialmente em ambientes hospitalares. Elas são responsáveis por infecções do trato urinário, endocardite e infecções em feridas cirúrgicas. Algumas espécies, como Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis, possuem resistência a múltiplos antibióticos, incluindo vancomicina, o que torna seu tratamento mais difícil. Estima-se que enterococos sejam responsáveis por uma parte significativa das infecções nosocomiais, o que destaca a importância do controle de infecção em hospitais. O tratamento geralmente envolve antibióticos específicos, mas a resistência tem aumentado, exigindo vigilância contínua.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Escherichia coli (todas as cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas, enteroinvasivas e detentoras do antígeno K 1)	2	Fonte de exposição e reservatórios	A Escherichia coli (E. coli), incluindo suas cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas, enteroinvasivas e com antígeno K1, tem como fontes de exposição alimentos ou água contaminados, principalmente de origem animal, e contato com superfícies ou ambientes infectados. Os principais reservatórios são os intestinos de humanos e animais, como bovinos, suínos e aves. A transmissão ocorre principalmente por ingestão de alimentos malcozidos ou mal lavados, água contaminada ou através do contato com fezes.
		Vias de transmissão e de entrada	Escherichia coli (E. coli) inclui cepas patogênicas como EPEC, ETEC, EIEC e as com antígeno K1, causadoras de doenças gastrointestinais e complicações graves. Vias de Transmissão: Fecal-oral: A ingestão de alimentos ou água contaminados. Contato direto: Transmissão por contato com pessoas ou superfícies infectadas. Ambientes hospitalares: Algumas cepas, como com antígeno K1, causam meningite neonatal. Produtos contaminados: Alimentos de origem animal, como carne mal cozida e leite não pasteurizado. Vias de Entrada: Trato gastrointestinal: Causa diarreia e cólicas. Trato urinário: Principal causa de infecção urinária, especialmente em mulheres. Sistema nervoso central: Cepas com antígeno K1 podem causar meningite. Outros órgãos: Pode levar a bacteremia e infecções em indivíduos imunocomprometidos. O controle envolve práticas rigorosas de higiene alimentar, cuidados hospitalares e vigilância em alimentos e água.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Escherichia coli (E. coli) inclui diferentes cepas com distintas características patogênicas e formas de transmissão: EPEC (Enteropatogênica): Transmitida via fecal-oral, causando diarreia aquosa, especialmente em crianças. ETEC (Enterotoxigênica): Também transmitida fecal-oral, causa diarreia secretória, frequentemente associada à diarreia do viajante. EIEC (Enteroinvasiva): Transmitida fecal-oral, provoca diarreia invasiva com sangue e muco, semelhante à disenteria. E. coli com antígeno K1: Transmitida verticalmente ou por secreções contaminadas, pode causar meningite neonatal e outras infecções graves. Cada cepa tem mecanismos específicos de virulência, como adesão celular, produção de toxinas ou invasão das células intestinais, com destaque para a E. coli com antígeno K1, que é particularmente virulenta em recém-nascidos.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Escherichia coli (incluindo cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas, enteroinvasivas e com o antígeno K1) pode persistir no ambiente por períodos variáveis, especialmente em superfícies e em água contaminada, devido à sua resistência a condições adversas. A sobrevivência depende de fatores como temperatura e umidade. Essas cepas podem ser transmitidas por meio de água ou alimentos contaminados, sendo a higiene essencial para evitar infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Escherichia coli (E. coli), incluindo cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas, enteroinvasivas e com o antígeno K1, é uma das principais causas de infecções gastrointestinais e outras doenças. Estudo epidemiológicos mostram que E. coli O157:H7, uma cepa enterotoxigênica, está associada a surtos de diarreia hemorrágica e síndrome hemolítico-urêmica. A infecção geralmente ocorre por ingestão de alimentos ou água contaminados. A prevalência é alta em áreas com saneamento precário e em países em desenvolvimento, mas também ocorre em países desenvolvidos devido ao consumo de alimentos contaminados, como carne malcozida.
		Outras informações científicas	Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria normalmente presente no intestino de humanos e animais, mas algumas de suas cepas podem causar infecções graves. As principais cepas enteropatogênicas incluem: Enteropatogênicas (EPEC): Causam diarreia em crianças, com lesões na mucosa intestinal. Enterotoxigênicas (ETEC): Produzem toxinas que provocam diarreia aquosa, frequentemente associada a viagens (diarreia do viajante). Enteroinvasivas (EIEC): Causam disenteria, com inflamação intestinal e secreção de muco e sangue. Enterohemorrágicas (EHEC): Incluem a cepa O157:H7, responsável por diarreia sanguinolenta e síndrome hemolítico-urêmica (SHU), que pode levar à insuficiência renal. A cepa E. coli com antígeno K1 é frequentemente associada a infecções neonatais, podendo causar meningite. Essas infecções podem ser graves, especialmente em crianças, idosos e imunocomprometidos. O controle envolve boas práticas de higiene, controle de água e alimentos, e o uso prudente de antibióticos, dado o aumento da resistência bacteriana.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Helicobacter pylori	2	Fonte de exposição e reservatórios	"A fonte de exposição ao Helicobacter pylori ocorre principalmente por contato direto com saliva, vômito ou fezes de pessoas infectadas, além de ingestão de alimentos ou água contaminados. O H. pylori é transmitido principalmente de pessoa para pessoa, sendo comum em ambientes com condições sanitárias inadequadas. Os principais reservatórios do agente são os seres humanos, especificamente o trato gastrointestinal, onde o microrganismo reside.
		Vias de transmissão e de entrada	Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que coloniza o estômago humano, associada a doenças como gastrite, úlceras e câncer gástrico. Sua transmissão ocorre principalmente de forma fecal-oral, através da ingestão de alimentos ou água contaminados, e oral-oral, por contato com saliva infectada. O risco de transmissão aumenta em ambientes com condições sanitárias precárias. A infecção ocorre quando a bactéria entra no trato gastrointestinal, sobrevivendo no ambiente ácido do estômago e causando inflamação. O controle inclui práticas de higiene adequadas e tratamento antibiótico, especialmente em casos graves.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmissibilidade: Helicobacter pylori é transmitido principalmente por via oral-oral ou fecal-oral, através de alimentos, água ou utensílios contaminados. A transmissão também pode ocorrer por contato direto com saliva ou fezes de uma pessoa infectada. Patogenicidade: O H. pylori é capaz de colonizar a mucosa gástrica, onde produz enzimas e substâncias que danificam a parede do estômago. Isso pode levar a inflamação crônica (gastrite), úlceras gástricas e duodenais, e, em casos graves, câncer gástrico. O agente também é capaz de sobreviver no ambiente ácido do estômago, devido à produção de urease, que neutraliza o ácido. Virulência: A virulência de H. pylori é determinada por vários fatores, incluindo a capacidade de se aderir à mucosa gástrica, a produção de toxinas como a CagA, e a habilidade de escapar da resposta imunológica do hospedeiro. Esses fatores contribuem para a persistência da infecção e o desenvolvimento de doenças gástricas.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Helicobacter pylori tem baixa persistência no ambiente externo, pois é uma bactéria que vive principalmente no trato gastrointestinal humano. Fora do corpo, ela não sobrevive por longos períodos, especialmente em superfícies secas. Sua transmissão ocorre principalmente por via fecal-oral ou oral-oral, tornando práticas de higiene essenciais para prevenção de infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Helicobacter pylori mostram que aproximadamente 50% da população mundial está infectada pela bactéria, com maior prevalência em países em desenvolvimento devido a condições sanitárias inadequadas. A infecção ocorre principalmente na infância, e fatores como baixa higiene, condições de vida e status socioeconômico estão fortemente associados ao risco. A infecção crônica por H. pylori é um fator de risco importante para doenças como úlcera péptica, câncer gástrico e linfoma MALT. A prevalência global varia entre 20% a 80% dependendo da região, com taxas mais altas em países com infraestrutura sanitária deficiente. Em resumo, H. pylori é uma infecção comum com grandes implicações para a saúde gastrointestinal, especialmente em populações com acesso limitado a cuidados de saúde.
		Outras informações científicas	Helicobacter pylori é uma bactéria que coloniza o estômago humano e está fortemente associada a diversas doenças gástricas, incluindo gastrite, úlceras pépticas e câncer gástrico. Estima-se que mais da metade da população mundial esteja infectada, embora muitas pessoas permaneçam assintomáticas. A infecção é geralmente adquirida na infância e pode ser transmitida por água ou alimentos contaminados. O diagnóstico é feito por exames como endoscopia, testes respiratórios ou sorologia. O tratamento envolve antibióticos e medicamentos para reduzir a acidez gástrica. O controle da infecção reduz significativamente o risco de complicações graves, como o câncer gástrico.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Neisseria gonorrhoeae	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição à Neisseria gonorrhoeae ocorre principalmente por contato sexual desprotegido com uma pessoa infectada, incluindo relações vaginais, anais e orais. A bactéria pode ser transmitida também de mãe para filho durante o parto. Os principais reservatórios da Neisseria gonorrhoeae são seres humanos, especificamente as mucosas do trato genital, uretra, garganta e reto."
		Vias de transmissão e de entrada	Neisseria gonorrhoeae é a bactéria responsável pela gonorreia, uma infecção sexualmente transmissível. A principal via de transmissão é por relações sexuais desprotegidas (vaginais, anais ou orais), através de secreções infectadas. A transmissão de mãe para filho também pode ocorrer durante o parto, causando conjuntivite gonocócica. Raramente, pode haver transmissão por contato com secreções em objetos. As vias de entrada da bactéria no corpo incluem as mucosas genitais, boca, ânus e olhos, podendo causar gonorreia genital, faringea, retal e ocular. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmissibilidade: Neisseria gonorrhoeae, a bactéria causadora da gonorreia, é transmitida principalmente por contato sexual desprotegido, incluindo relações vaginais, anais e orais. Também pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto, causando conjuntivite neonatal. Patogenicidade: A N. gonorrhoeae infecta as mucosas do trato urogenital, anal, faríngeo e ocular. Ela pode causar inflamação local, dor ao urinar, secreção purulenta, além de complicações como doença inflamatória pélvica (DIP) em mulheres, que pode levar à infertilidade, e epididimite em homens. Virulência: A virulência de N. gonorrhoeae é atribuída a vários fatores, como a habilidade de aderir às células epiteliais (por meio de fimbrias e outras proteínas de adesão), sua capacidade de evadir o sistema imunológico (por meio de variação antigênica das suas superfícies) e a produção de enzimas como a penicilinase, que confere resistência a antibióticos. Esses fatores permitem que a bactéria cause infecção persistente e complicações a longo prazo.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Neisseria gonorrhoeae tem baixa persistência no ambiente externo, pois é uma bactéria sensível a condições adversas, como temperatura e secura. Ela sobrevive por pouco tempo fora do corpo humano e sua principal forma de transmissão é por contato sexual direto. A higiene adequada e o uso de proteção sexual são essenciais para prevenir infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Neisseria gonorrhoeae, a bactéria causadora da gonorreia, revelam que ela é uma das infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais comuns globalmente. Estima-se que 87 milhões de casos novos de gonorreia ocorram anualmente no mundo. A infecção é mais prevalente em jovens entre 15 e 24 anos, especialmente em áreas com acesso limitado a serviços de saúde. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual desprotegido, e a prevalência é maior em populações com múltiplos parceiros sexuais e em contextos de baixa educação sobre saúde sexual. A gonorreia pode causar complicações graves, como infertilidade, doenças inflamatórias pélvicas (DIP) e infecção neonatal. Além disso, o aumento da resistência antimicrobiana a antibióticos, como a ceftriaxona, tem se tornado um grande desafio no tratamento da doença. Em resumo, Neisseria gonorrhoeae continua a ser uma preocupação significativa de saúde pública, com alta prevalência entre jovens e aumento da resistência ao tratamento.
		Outras informações científicas	Neisseria gonorrhoeae é a bactéria causadora da gonorreia, uma das infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais comuns. Ela afeta principalmente os órgãos genitais, mas também pode causar infecções no reto, garganta e olhos. A infecção é frequentemente assintomática, especialmente nas mulheres, o que aumenta o risco de complicações como doença inflamatória pélvica (DIP) e infertilidade. Estima-se que cerca de 87 milhões de casos novos ocorram anualmente no mundo. O tratamento envolve antibióticos, mas o aumento da resistência, especialmente a ceftriaxona e outras classes, tem se tornado uma preocupação crescente, exigindo vigilância e terapias combinadas. O uso de preservativos é fundamental na prevenção.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Salmonella spp	2	Fonte de exposição e reservatórios	"A fonte de exposição à Salmonella spp. ocorre principalmente por ingestão de alimentos ou água contaminados, especialmente carnes cruas ou mal cozidas (principalmente de frango e ovos), leite não pasteurizado e vegetais contaminados. A contaminação também pode ocorrer por contato com superfícies, utensílios ou pessoas infectadas. Os reservatórios naturais da Salmonella incluem o trato intestinal de animais, especialmente aves, répteis e mamíferos, além de humanos infectados
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Via fecal-oral: Principalmente através do consumo de alimentos ou água contaminados com fezes infectadas. Contato com animais ou seus ambientes: Como aves, répteis e mamíferos, que podem carregar a bactéria e transmiti-la através de contato direto ou indireto. Vias de Entrada: Trato gastrointestinal: A Salmonella entra no corpo principalmente pela ingestão de alimentos ou água contaminados, infectando o intestino.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via fecal-oral, através do consumo de alimentos ou água contaminados com fezes de animais ou pessoas infectadas. Também pode ocorrer por contato direto com animais infectados, especialmente répteis. Causa doenças como salmonelose, que pode se manifestar como gastroenterite (diarreia, dor abdominal e febre) ou formas mais graves como febre tifoide (com sintomas sistêmicos e risco de complicações graves). A virulência de Salmonella é atribuída à sua capacidade de invadir células intestinais, formar biofilmes e produzir toxinas que causam inflamação e danos aos tecidos. Algumas cepas têm resistência a antibióticos, o que aumenta a gravidade das infecções.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Salmonella spp. pode persistir por semanas ou até meses no ambiente, especialmente em superfícies contaminadas com fezes ou alimentos. Ela é resistente a condições adversas, como variações de temperatura, e pode sobreviver em água e solo. A transmissão ocorre principalmente por meio de alimentos ou água contaminados, tornando a higiene e o manejo adequado de alimentos essenciais para prevenir infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Salmonella spp., um grupo de bactérias responsáveis por infecções alimentares, revelam que a salmonelose é uma das principais causas de diarreia bacteriana no mundo. Estima-se que haja 93 milhões de infecções e 155.000 mortes anuais devido a Salmonella globalmente. A transmissão ocorre principalmente por meio do consumo de alimentos contaminados, especialmente ovos, carnes (principalmente aves) e produtos lácteos não pasteurizados. A prevalência é maior em países em desenvolvimento, devido à falta de infraestrutura sanitária e práticas inadequadas de higiene alimentar. Em países desenvolvidos, surtos de Salmonella ainda ocorrem, especialmente associados à alimentação inadequada e ao armazenamento incorreto de alimentos. A maioria dos casos de infecção é autolimitada, mas a bactéria pode causar complicações graves, como sepse e infecções sistêmicas em grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas. Em resumo, Salmonella spp. continua a ser uma causa significativa de doenças alimentares, com grande impacto em saúde pública, especialmente em áreas com condições sanitárias deficientes.
		Outras informações científicas	Salmonella spp. é um grupo de bactérias que causa infecções alimentares, sendo responsáveis por doenças como a salmonelose. As infecções geralmente ocorrem pela ingestão de alimentos ou água contaminados, especialmente carne crua ou mal cozida, ovos e produtos lácteos. Salmonella enterica é a espécie mais comum, com subtipos como S. enterica serotipos Typhimurium e Enteritidis frequentemente envolvidos. A infecção pode causar diarreia, febre, cólicas abdominais e, em casos graves, septicemia. Estima-se que a Salmonella cause milhões de casos anuais de doenças transmitidas por alimentos globalmente. A prevenção envolve práticas adequadas de higiene alimentar, como o cozimento completo dos alimentos e o armazenamento adequado. O tratamento geralmente é sintomático, mas em casos graves pode exigir antibióticos.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Staphylococcus aureus	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Staphylococcus aureus ocorre principalmente por contato direto com feridas infectadas, secreções ou superfícies contaminadas. A bactéria também pode ser transmitida através do consumo de alimentos contaminados, especialmente quando mal armazenados ou manipulados. Os principais reservatórios do Staphylococcus aureus são humanos, principalmente na pele, nas mucosas nasais e na garganta, mas também pode ser encontrado em animais e em ambientes contaminados.
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Contato direto: Através do contato com a pele ou mucosas de uma pessoa infectada. Objetos contaminados: Pode ser transmitido por objetos ou superfícies contaminadas com secreções infectadas. Gotículas respiratórias: Em infecções respiratórias, a transmissão pode ocorrer pelo ar, por tosse ou espirro. Vias de Entrada: Pele e mucosas: A principal via de entrada é através de cortes, feridas, ou membranas mucosas, onde a bactéria pode infectar tecidos.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por contato direto com uma pessoa infectada ou com superfícies contaminadas, incluindo feridas e secreções. Pode também ser transmitido por gotículas respiratórias em infecções respiratórias. pode causar uma ampla gama de infecções, incluindo infecções de pele (furúnculos, abscessos), pneumonia, infecção do trato urinário, endocardite e síndrome do choque tóxico. Algumas cepas podem causar intoxicação alimentar. A virulência de S. aureus é mediada por toxinas (como enterotoxinas, toxinas da síndrome do choque tóxico) e enzimas que facilitam a invasão tecidual. A capacidade de formar biofilmes e a resistência a antibióticos (como na cepa MRSA) aumentam a virulência e dificultam o tratamento.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Staphylococcus aureus pode persistir no ambiente por longos períodos, especialmente em superfícies secas e em objetos contaminados, como toalhas ou utensílios. Ele é resistente a condições adversas, como mudanças de temperatura e desinfetantes, e pode causar infecções por contato direto ou por objetos contaminados. A higiene adequada e a limpeza são essenciais para prevenir sua transmissão.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Staphylococcus aureus mostram que essa bactéria é uma causa comum de infecções hospitalares e comunitárias. A infecção pode causar desde condições leves, como infecções de pele, até doenças graves, como pneumonia, sepsis e infecções ósseas. Em relação à prevalência, S. aureus é encontrado em cerca de 30% da população humana como parte da flora normal da pele e das vias respiratórias superiores. No entanto, ele pode causar infecção quando há condições que permitem sua proliferação, como feridas abertas ou sistemas imunológicos comprometidos. Um problema crescente é a resistência a antibióticos, com a forma methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) sendo uma preocupação significativa. Estima-se que a resistência a antibióticos cause milhares de mortes anuais, com a MRSA sendo responsável por uma parte considerável das infecções resistentes em ambientes hospitalares. Em resumo, Staphylococcus aureus é uma bactéria comum, com grande potencial patogênico, e a resistência antimicrobiana tem agravado seu impacto na saúde pública.
		Outras informações científicas	Staphylococcus aureus é uma bactéria comum que pode causar uma ampla variedade de infecções, desde leves, como furúnculos e impetigo, até graves, como pneumonia, endocardite e infecções da corrente sanguínea. Também é responsável por intoxicações alimentares devido à produção de toxinas. A resistência a antibióticos, especialmente à meticilina (MRSA), tem aumentado significativamente, tornando o tratamento mais desafiador. S. aureus pode ser adquirido em ambientes hospitalares (infecções nosocomiais) ou comunitários. A prevenção inclui boas práticas de higiene, cuidados com feridas e controle rigoroso em ambientes de saúde.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Streptococcus pneumoniae	2	Fonte de exposição e reservatórios	"A fonte de exposição ao Streptococcus pneumoniae ocorre principalmente através da inalação de gotículas respiratórias expelidas por pessoas infectadas, durante tosse, espirros ou fala. O contágio também pode ocorrer por contato direto com secreções nasais ou orais contaminadas. Os principais reservatórios do Streptococcus pneumoniae são os seres humanos, especificamente no trato respiratório superior, como nasofaringe e garganta, onde o microrganismo pode colonizar sem causar sintomas em algumas pessoas."
		Vias de transmissão e de entrada	Gotículas respiratórias: A principal via de transmissão é por meio de tosse, espirros ou fala de uma pessoa infectada. Contato direto ou indireto: Pode ser transmitido pelo contato com superfícies ou objetos contaminados com secreções respiratórias. Vias de Entrada: Trato respiratório: A entrada ocorre principalmente pelas vias aéreas, ao inalar gotículas contaminadas ou por contato direto com as mucosas da garganta e nariz.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por gotículas respiratórias (tosse, espirro) de uma pessoa infectada, e também por contato direto com secreções nasais ou orais. Causa infecções respiratórias, como pneumonia, otite média, sinusite e meningite, podendo ser grave em crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas. A virulência de S. pneumoniae é atribuída à cápsula polissacarídica que impede a fagocitose, além da produção de toxinas (como a pneumolisina) e enzimas que danificam os tecidos e facilitam a disseminação da infecção.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Streptococcus pneumoniae pode persistir por algum tempo no ambiente, especialmente em superfícies úmidas ou em secreções respiratórias. No entanto, sua sobrevivência fora do corpo humano é limitada. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias, e práticas de higiene, como lavar as mãos e cobrir a boca ao tossir, são importantes para prevenir infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Streptococcus pneumoniae indicam que essa bactéria é uma das principais causas de pneumonia, meningite e otite média em crianças e idosos. Estima-se que S. pneumoniae seja responsável por cerca de 1,6 milhão de mortes anuais em todo o mundo, com a maioria dos casos ocorrendo em países de baixa e média renda. A infecção é mais comum em populações vulneráveis, como crianças menores de 5 anos e adultos com mais de 65 anos, além de pessoas com comorbidades como doenças cardíacas ou respiratórias. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias. A introdução de vacinas conjugadas contra S. pneumoniae tem reduzido significativamente a incidência de doenças pneumocócicas, especialmente em crianças. Contudo, o aumento de cepas resistentes a antibióticos continua sendo um desafio importante para o tratamento adequado. Em resumo, Streptococcus pneumoniae é um patógeno significativo responsável por doenças graves e morte, especialmente em populações vulneráveis, com a vacinação sendo uma ferramenta crucial para controle da infecção.
		Outras informações científicas	Streptococcus pneumoniae é uma bactéria responsável por infecções respiratórias e invasivas graves, como pneumonia, meningite, otite média e sinusite. Ela é uma das principais causas de morte por infecções bacterianas em crianças e idosos. A infecção pode ser particularmente grave em pessoas com comorbidades ou sistema imunológico enfraquecido. A bactéria é frequentemente transmitida por via aérea, e a vacinação com a vacina pneumocócica tem sido uma medida eficaz de prevenção. A resistência a antibióticos, especialmente a penicilina, tem aumentado, tornando o tratamento mais complexo. A profilaxia e o tratamento precoce são essenciais para reduzir complicações.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus humanos, gastroenterite de suínos, hepatite murina, Coronavírus bovinos, peritonite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviária	1	Fonte de exposição e reservatórios	A exposição aos diferentes vírus ocorre principalmente por contato com secreções ou excreções de animais infectados, sendo os próprios animais os reservatórios. Vírus humanos: Contato com pessoas infectadas. Gastroenterite de suínos: Contato com fezes ou secreções de suínos. Hepatite murina: Contato com secreções, urina ou fezes de roedores. Coronavírus bovino: Contato com secreções ou fezes de bovinos. Peritonite infecciosa felina: Contato com fezes ou secreções de gatos. Bronquite infecciosa aviária: Contato com secreções ou excreções de aves. Coronavírus de caninos: Contato com fezes ou secreções de cães. Ratos e coelhos: Contato com secreções ou excreções de ratos e coelhos.
		Vias de transmissão e de entrada	Transmissão: Fecal-oral, por alimentos ou água contaminados, ou por contato com superfícies infectadas. Entrada: Principalmente pelo trato gastrointestinal, após ingestão de alimentos ou água contaminados. Gastroenterite de suínos (Vírus da gastroenterite transmissível suína - TGEV): Transmissão: Contato direto com animais infectados ou seus excrementos, por alimentos contaminados. Entrada: Trato gastrointestinal de suínos, após ingestão de alimentos contaminados. Hepatite murina (Vírus da hepatite de camundongos): Transmissão: Contato com secreções corporais, como urina ou fezes, de roedores infectados. Entrada: Via oral ou através de arranhões ou mordidas. Coronavírus bovinos (Vírus da diarreia viral bovina - BVD): Transmissão: Através do contato com secreções respiratórias ou urinárias de animais infectados. Entrada: Trato respiratório ou gastrointestinal dos bovinos. Peritonite infecciosa felina (FIP - Causada pelo coronavírus felino): Transmissão: Fecal-oral, contato com fezes de gatos infectados. Entrada: Trato gastrointestinal, podendo atingir outros órgãos. Bronquite infecciosa aviária (Vírus da bronquite infecciosa das aves): Transmissão: Aérea, através de gotículas respiratórias e contato com secreções de aves infectadas. Entrada: Trato respiratório das aves. Coronavírus canino: Transmissão: Contato direto com fezes ou secreções de cães infectados. Entrada: Trato gastrointestinal, após ingestão de fezes contaminadas. Vírus de ratos e coelhos: Transmissão: Através do contato com fluidos corporais ou fezes de roedores ou coelhos infectados. Entrada: Através da ingestão de alimentos contaminados ou contato direto com secreções. Esses vírus geralmente têm uma transmissão através do contato com secreções, fezes ou gotículas respiratórias de animais infectados, e a entrada ocorre principalmente pelas vias respiratórias ou gastrointestinais.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Os vírus mencionados afetam diferentes espécies animais e têm formas de transmissão e efeitos patológicos diversos: Vírus humanos: Transmitidos por gotículas respiratórias ou contato direto, causam doenças respiratórias e gastrointestinais. Gastroenterite de suínos: Transmitida por contato direto ou alimentos contaminados, causa diarreia e desidratação nos suínos. Hepatite murina: Transmitida por via fecal-oral entre roedores, pode causar inflamação no fígado e morte. Coronavírus bovinos: Transmitidos por gotículas respiratórias ou contato direto, causam diarreia e problemas respiratórios em bezerros. Peritonite infecciosa felina: Transmitida por fezes de gatos infectados, é fatal e afeta o sistema abdominal e nervoso. Bronquite infecciosa aviária: Transmitida por gotículas respiratórias ou secreções, afeta o sistema respiratório e reduz a produção nas aves. Coronavírus de caninos, ratos e coelhos: Transmitidos por contato direto ou gotículas respiratórias, causam doenças respiratórias e gastrointestinais. Os coronavírus têm alta virulência, com rápida propagação e danos aos sistemas respiratório e gastrointestinal. A peritonite infecciosa felina é extremamente virulenta, com taxa de mortalidade quase 100% sem tratamento. A hepatite murina, embora geralmente de baixa virulência, pode ser grave em roedores suscetíveis

aviária,
Coronavirus de caninos,
ratos e coelhos

Persistência do agente biológico no ambiente	Os vírus humanos, como os causadores de gastroenterite, hepatite e doenças respiratórias, assim como os coronavírus de suínos, bovinos, felinos, caninos e outros podem persistir no ambiente por períodos variáveis, dependendo do tipo de vírus e das condições ambientais. Geralmente, eles sobrevivem por mais tempo em superfícies úmidas e podem ser transmitidos por contato direto ou por secreções contaminadas. A higiene adequada e a desinfecção de ambientes são essenciais para prevenir a propagação desses vírus.
Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	O texto aborda diversos vírus que afetam tanto humanos quanto animais. Destaca os vírus responsáveis pela gastroenterite em humanos (norovírus e rotavírus), com 200.000 mortes infantis anuais, embora a vacinação tenha reduzido esses números. Em suínos, os vírus da gastroenterite transmissível (TGEV) e coronavírus suíno afetam leitões, com mortalidade alta, mas a prevalência tem diminuído. A hepatite murina, que afeta roedores, não apresenta risco significativo para humanos. O coronavírus bovino causa diarreia e doenças respiratórias em bezerros, e surtos são mais comuns em sistemas intensivos. A Peritonite Infecciosa Felina (FIP), causada pelo coronavírus felino, afeta gatos e é fatal, com 10-20% dos gatos sendo portadores do vírus. O vírus da bronquite infecciosa aviária afeta galinhas, causando problemas respiratórios e queda na produção de ovos. O coronavírus canino causa gastroenterite leve, com surtos em locais com grande concentração de cães. Ratos e coelhos também são afetados por vírus específicos, como hepatite murina e doença hemorrágica viral, respectivamente. A vacinação e o controle sanitário são essenciais para o controle e redução das infecções.
Outras informações científicas	Os vírus mencionados causam doenças em diferentes espécies animais, com algumas sendo zoonóticas (transmissíveis entre animais e humanos). Aqui está um resumo: Gastroenterite de suínos: Causada por vírus como o rotavírus e coronavírus, provoca diarreia grave em suínos jovens. Hepatite murina: Causada por vírus como o hepatite A e B, afeta ratos, geralmente sem sintomas clínicos graves. Coronavírus bovinos: Afeta o sistema respiratório dos bovinos, causando doenças respiratórias e diarreia em bezerros. Peritonite infecciosa felina (PIF): Causada por um coronavírus felino, leva a uma inflamação grave do abdômen e é fatal em muitos casos. Bronquite infecciosa aviária: Causada por um coronavírus aviário, afeta o sistema respiratório das aves, especialmente frangos. Coronavírus caninos: Causa infecções gastrointestinais em cães, geralmente leves. Ratos e coelhos: Embora menos frequentes, infecções virais podem ocorrer, como em ratos com hepatite viral. Esses vírus não têm, em sua maioria, impacto direto na saúde humana, mas o monitoramento e controle em populações animais são essenciais para prevenir surtos e garantir a saúde pública.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus da Dengue tipos 1-4	2	Fonte de exposição e reservatórios	"A fonte de exposição ao vírus da dengue (tipos 1 a 4) ocorre principalmente por picadas de mosquitos infectados, especialmente o mosquito Aedes aegypti e, em menor grau, Aedes albopictus. Esses mosquitos se infectam ao picar uma pessoa já contaminada pelo vírus. Os principais reservatórios do vírus são os seres humanos, que atuam como hospedeiros, e os mosquitos Aedes que transmitem o vírus."
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Picada do mosquito Aedes aegypti (ou Aedes albopictus), infectado com o vírus. A transmissão ocorre quando o mosquito pica uma pessoa infectada e depois pica outra pessoa. Vias de Entrada: Pele: O vírus entra no corpo humano através da picada do mosquito, transmitindo-se para a corrente sanguínea.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por mosquitos do gênero Aedes, especialmente Aedes aegypti e Aedes albopictus, através da picada de um mosquito infectado. Não é transmitido de pessoa para pessoa diretamente. O vírus causa a dengue, que pode se manifestar como dengue clássica (febre, dor muscular, dor nas articulações, erupções cutâneas) ou dengue hemorrágica (forma mais grave, com sangramentos, choque e risco de morte). A virulência dos tipos 1-4 pode variar, mas todos os tipos têm o potencial de causar formas graves da doença, especialmente em pessoas que já foram infectadas por outro sorotipo. A dengue hemorrágica e o choque da dengue estão associados a uma resposta imunológica exacerbada.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Os vírus da dengue (tipos 1-4) não persistem por longos períodos no ambiente. Eles são transmitidos principalmente por mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, que picam humanos para se infectarem. Fora do corpo humano, o vírus tem baixa sobrevivência, sendo dependente da presença dos mosquitos vetores. A prevenção se dá principalmente pelo controle dos mosquitos e eliminação de criadouros.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	A dengue é uma doença viral causada por quatro sorotipos do vírus (DENV-1 a DENV-4), transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Estima-se que ocorram 400 milhões de infecções anuais, com 100 milhões de casos clínicos diagnosticados, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. O DENV-1 é o mais prevalente, o DENV-2 está associado a surtos graves e dengue hemorrágica, o DENV-3 é comum na América Latina e Sudeste Asiático, e o DENV-4 é menos frequente, mas importante em alguns surtos. A infecção pode variar de leve a grave, com complicações como a dengue hemorrágica e síndrome do choque, especialmente quando uma pessoa é infectada por um sorotipo diferente após uma infecção anterior. A dengue é endêmica em mais de 100 países, com surtos frequentes, agravados pela urbanização e mudanças climáticas. A vacina Dengvaxia é restrita a pessoas previamente infectadas, e o controle da doença depende da eliminação de criadouros do mosquito e campanhas de conscientização.
		Outras informações científicas	O vírus da dengue, transmitido por mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, possui quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). A infecção por qualquer um desses tipos pode causar dengue, com sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares, além de erupção cutânea. A infecção por um sorotipo confere imunidade apenas contra esse tipo, aumentando o risco de formas graves da doença, como a dengue hemorrágica, caso ocorra uma infecção subsequente por outro sorotipo. A transmissão é mais comum em regiões tropicais e subtropicais. A prevenção envolve controle do vetor e, mais recentemente, vacinas para algumas faixas etárias e condições.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus da Hepatite C	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao vírus da Hepatite C ocorre principalmente por contato com sangue contaminado, como no compartilhamento de agulhas e seringas, transfusões de sangue não testado ou procedimentos médicos não seguros. A transmissão também pode ocorrer através de relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada, embora seja menos comum. Os principais reservatórios do vírus da Hepatite C são os seres humanos, especialmente aqueles que já estão infectados
		Vias de transmissão e de entrada	Sangue contaminado: A principal via de transmissão é através do contato com sangue infectado, como em transfusões, compartilhamento de agulhas ou equipamentos de injeção. Transmissão vertical: De mãe para filho durante o parto. Transmissão sexual: Embora menos comum, pode ocorrer através de relações sexuais desprotegidas. Vias de Entrada: Sangue: O vírus entra no corpo humano através de cortes, feridas ou membranas mucosas ao ter contato com sangue infectado.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via sanguínea, através do compartilhamento de agulhas e outros instrumentos contaminados, transfusões de sangue não testado e menos frequentemente, por via sexual ou de mãe para filho durante o parto. O HCV causa hepatite crônica, podendo evoluir para cirrose, câncer de fígado e insuficiência hepática. A infecção pode ser assintomática por muitos anos antes de causar danos significativos ao fígado. A virulência do HCV é associada à sua capacidade de evitar a resposta imunológica, persistindo por longos períodos no organismo. A infecção crônica é mais comum, uma vez que o vírus apresenta uma alta taxa de mutação, dificultando o desenvolvimento de uma resposta imune eficaz.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O vírus da hepatite C pode persistir no ambiente por algumas horas a dias, dependendo das condições, como umidade e temperatura. No entanto, sua sobrevivência fora do corpo humano é limitada. A transmissão ocorre principalmente através do contato com sangue contaminado, sendo importante adotar medidas de prevenção, como evitar o compartilhamento de objetos cortantes e o uso de práticas de segurança em ambientes de saúde.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o vírus da Hepatite C indicam que cerca de 58 milhões de pessoas no mundo vivem com infecção crônica. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com sangue contaminado, como no uso de drogas injetáveis e transfusões não testadas. A infecção pode levar a complicações graves como cirrose e câncer de fígado. A mortalidade relacionada ao HCV é significativa, com cerca de 400.000 mortes anuais globalmente. Tratamentos modernos com antivirais de ação direta têm altas taxas de cura, sendo fundamentais para prevenir progressões graves da doença.
		Outras informações científicas	O vírus da Hepatite C (HCV) é uma infecção viral que afeta o fígado e pode levar a complicações graves como cirrose, câncer de fígado e insuficiência hepática. Estima-se que cerca de 58 milhões de pessoas estejam infectadas globalmente, com a maioria dos casos em regiões da África e Ásia. A transmissão ocorre principalmente por contato com sangue contaminado, como no uso compartilhado de agulhas ou transfusões de sangue não testadas. O tratamento evoluiu significativamente com os antivirais de ação direta (DAAs), que têm altas taxas de cura e menos efeitos colaterais. A detecção precoce e a eliminação do vírus são essenciais para reduzir complicações.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus da hepatite B	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao vírus da Hepatite B ocorre principalmente através do contato com sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. A transmissão pode acontecer por meio de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas e seringas, transfusões de sangue contaminado ou de mãe para filho durante o parto. Os principais reservatórios do vírus da Hepatite B são os seres humanos, especialmente aqueles com infecção crônica.
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Sangue contaminado: Principalmente através do compartilhamento de agulhas, transfusões de sangue ou equipamentos de injeção. Transmissão sexual: Através de relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada. Transmissão vertical: De mãe para filho durante o parto. Vias de Entrada: Sangue e fluidos corporais: O vírus entra no corpo por meio de feridas, mucosas ou contato direto com sangue ou fluidos corporais infectados.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via sanguínea, através de agulhas contaminadas, transfusões de sangue não testado, vias sexuais (especialmente sem proteção) e de mãe para filho durante o parto. O HBV causa hepatite aguda (com sintomas como febre, dor abdominal e icterícia) e pode evoluir para hepatite crônica, cirrose e câncer de fígado. O HBV tem alta virulência devido à sua capacidade de persistir no organismo como infecção crônica, especialmente em indivíduos não tratados ou não vacinados. Sua cápsula e antígenos ajudam na evasão do sistema imunológico, facilitando a cronicidade e aumentando o risco de complicações hepáticas.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O vírus da hepatite B pode persistir no ambiente por várias horas a dias, especialmente em superfícies contaminadas com sangue. Ele é resistente a condições adversas e pode sobreviver em temperaturas baixas. A transmissão ocorre principalmente através do contato com sangue ou fluidos corporais infectados, tornando essencial o uso de precauções de segurança e higiene para evitar a contaminação.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	O vírus da hepatite B (HBV) causa infecção hepática significativa, podendo levar a doenças crônicas como cirrose e câncer de fígado. Estima-se que 296 milhões de pessoas vivam com infecção crônica, resultando em cerca de 820.000 mortes anuais. A transmissão ocorre principalmente por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas e de mãe para filho. A hepatite B é endêmica em regiões como África Subsaariana e Ásia Oriental, com alta prevalência, enquanto em países de alta renda é menor, mas ainda significativa em populações de risco. A vacinação, iniciada na década de 1990, tem sido eficaz na redução da prevalência, especialmente em crianças, com taxas superiores a 80%. A infecção pode se tornar crônica, especialmente em crianças, com 90% dos casos em crianças infectadas precocemente tornando-se crônicos. O controle da hepatite B depende de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado.
		Outras informações científicas	O vírus da hepatite B (HBV) é um agente infeccioso que afeta o fígado, podendo causar desde infecções leves até doenças graves, como cirrose e câncer de fígado. A transmissão ocorre principalmente por contato com sangue ou fluidos corporais infectados, através de práticas sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas ou transfusões de sangue não testadas. Estima-se que cerca de 296 milhões de pessoas vivem com infecção crônica pelo HBV no mundo. A infecção pode ser prevenido com a vacina contra hepatite B, que é altamente eficaz. O tratamento inclui antivirais que controlam a replicação viral, mas não curam a infecção. A detecção precoce é essencial para evitar complicações graves.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Citomegalovírus	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Citomegalovírus (CMV) ocorre principalmente por contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada, como saliva, urina, sangue, sêmen e secreções vaginais. A transmissão pode acontecer por contato direto, transfusões de sangue, transplantes de órgãos ou de mãe para filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Os principais reservatórios do CMV são os seres humanos, especialmente aqueles infectados de forma assintomática ou com infecção ativa."
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Contato direto com fluidos corporais: Como saliva, urina, sangue, sêmen, secreções cervicais e leite materno. Transmissão sexual: Através de relações sexuais desprotegidas. Transmissão vertical: De mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Transfusão de sangue ou transplante de órgãos: Pode ocorrer através de órgãos ou sangue contaminados. Vias de Entrada: Mucosas: O vírus entra no corpo principalmente pelas mucosas da boca, trato genital, trato urinário ou respiratório.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por contato com secreções corporais, como saliva, urina, sêmen, sangue e leite materno. Também pode ser transmitido de mãe para filho durante a gestação (transmissão vertical), parto ou amamentação. O CMV pode causar infecção assintomática em pessoas saudáveis, mas em imunocomprometidos (como transplantados, pacientes com HIV/AIDS), pode levar a pneumonia, retinite, hepatite e infecções generalizadas. A infecção congênita pode resultar em deficiências auditivas, problemas de visão e atrasos no desenvolvimento. O CMV tem alta capacidade de persistir no organismo e pode causar infecções crônicas. Ele possui uma habilidade significativa de evadir o sistema imunológico, resultando em infecções latentes que podem reativar em condições de imunossupressão.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O citomegalovírus (CMV) pode persistir no ambiente por períodos curtos, especialmente em superfícies contaminadas com fluidos corporais como saliva, urina e sangue. No entanto, fora do corpo humano, sua sobrevivência é limitada. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com fluidos infectados, e medidas de higiene e precauções são importantes para evitar a disseminação do vírus.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	O citomegalovírus (CMV) é um vírus comum da família Herpesviridae, afetando 60% a 90% da população mundial ao longo da vida, geralmente de forma assintomática. A prevalência é maior em países em desenvolvimento. O CMV é uma das principais causas de infecções congênitas, afetando de 0,2% a 2% dos nascimentos, podendo causar surdez e deficiências no desenvolvimento. O vírus é transmitido por fluidos corporais e pode ser transmitido de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Em pessoas imunocomprometidas, o CMV pode causar infecções graves. Não há vacina, mas a prevenção envolve medidas como lavagem das mãos, e o tratamento antiviral é usado para controlar infecções graves. Em resumo, o CMV é geralmente assintomático, mas pode causar complicações sérias em recém-nascidos e imunocomprometidos.
		Outras informações científicas	O citomegalovírus (CMV) é um vírus da família herpesvírus, comum e muitas vezes assintomático em pessoas saudáveis. No entanto, pode causar infecções graves em indivíduos imunocomprometidos, como pacientes com HIV ou em tratamento imunossupressor, e em recém-nascidos, levando a complicações como surdez, deficiência mental e problemas de visão. O CMV é transmitido por contato com fluidos corporais, como saliva, urina e sangue. A infecção é tratada com antivirais, especialmente em casos graves. A maioria das pessoas adquire o CMV na infância ou na juventude e permanece com o vírus latente no corpo por toda a vida, com possível reativação em situações de imunossupressão.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Herpes simplex vírus tipos 1 e 2	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao vírus Herpes simplex tipos 1 e 2 ocorre principalmente por contato direto com lesões, secreções ou mucosas de uma pessoa infectada. O vírus tipo 1 (HSV-1) é geralmente transmitido através do contato com secreções orais, como beijos ou compartilhamento de utensílios, enquanto o tipo 2 (HSV-2) é comumente transmitido por contato sexual desprotegido. Os principais reservatórios dos dois tipos de herpes são os seres humanos, especialmente aqueles com infecções ativas ou assintomáticas.
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: HSV-1: Geralmente transmitido pelo contato direto com secreções orais infectadas, como beijos, ou através do compartilhamento de utensílios pessoais (ex: toalhas, copos). HSV-2: Transmitido principalmente por contato sexual desprotegido com uma pessoa infectada. Vias de Entrada: Pele e mucosas: O vírus entra no corpo através de pequenas lesões na pele ou mucosas, como as da boca, genitais ou áreas próximas.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	HSV-1: Transmitido principalmente por contato direto com lesões, secreções salivares ou superfícies contaminadas (ex.: beijos, uso compartilhado de objetos). HSV-2: Transmitido principalmente por via sexual (contato com lesões ou secreções genitais infectadas) e pode ser transmitido de mãe para filho durante o parto. HSV-1 causa herpes labial (lesões nos lábios e face) e, ocasionalmente, herpes ocular e encefalite. HSV-2 causa herpes genital, com lesões dolorosas na região genital, podendo também levar a complicações neurológicas (como meningite) e transmitir ao bebê durante o parto, causando herpes neonatal. Ambos os tipos têm alta virulência, pois são capazes de se tornar latentes nos nervos sensoriais e se reativar periodicamente, causando surtos recorrentes. A habilidade de evadir o sistema imunológico e de se esconder no sistema nervoso contribui para a persistência da infecção.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Os vírus Herpes simplex tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2) têm baixa persistência no ambiente, especialmente em superfícies secas. No entanto, podem sobreviver por curtos períodos em secreções corporais, como saliva ou fluidos genitais. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com lesões ou secreções infectadas, e a higiene adequada ajuda a prevenir a disseminação do vírus.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Os vírus Herpes simplex tipos 1 (HSV-1) e 2 (HSV-2) são comuns e afetam uma grande parte da população mundial. O HSV-1 é responsável principalmente por infecções orais, como herpes labial, e é frequentemente transmitido por contato direto com lesões ou saliva. Estima-se que cerca de 67% da população mundial com menos de 50 anos seja infectada pelo HSV-1. Já o HSV-2 é a principal causa de herpes genital e é transmitido principalmente por contato sexual. Aproximadamente 13% da população mundial de 15 a 49 anos é infectada pelo HSV-2. Ambos os vírus podem permanecer latentes no organismo e reativar-se em situações de estresse ou imunossupressão, causando surtos recorrentes. A prevalência é global, com o HSV-1 sendo mais comum em países em desenvolvimento e o HSV-2 em áreas com maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis.
		Outras informações científicas	O Herpes simplex vírus (HSV) possui dois tipos: HSV-1 e HSV-2. O HSV-1 é mais comumente associado a infecções orais, como o herpes labial, mas também pode causar herpes genital. Já o HSV-2 é predominantemente responsável por infecções genitais, sendo transmitido principalmente por contato sexual. Ambos os tipos podem causar infecções recorrentes, pois o vírus permanece latente no corpo e pode se reativar. Além disso, o HSV pode causar complicações graves em recém-nascidos e em pessoas imunocomprometidas. Não há cura, mas antivirais podem reduzir a gravidade e a frequência das crises.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Herpesvirus varicellazoster	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Herpesvirus varicella-zoster (o vírus que causa varicela e herpes-zóster) ocorre principalmente por contato direto com as lesões da pele de uma pessoa infectada ou pela inalação de gotículas respiratórias expelidas durante a tosse ou espirro. A transmissão também pode ocorrer através do contato com secreções respiratórias de indivíduos infectados com varicela ou herpes-zóster. O principal reservatório do Herpesvirus varicella-zoster são os seres humanos, especialmente aqueles com infecção ativa, seja por varicela (catapora) ou herpes-zóster (cobreiro).
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Gotículas respiratórias: A transmissão ocorre principalmente pelo ar, através de gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Contato direto: Pode ser transmitido através do contato com lesões de pele infectadas (no caso de herpes-zóster). Vias de Entrada: Trato respiratório: O vírus entra no corpo principalmente pelas vias respiratórias, ao inalar gotículas contaminadas. Também pode entrar por lesões na pele em contato com lesões de uma pessoa infectada.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por gotículas respiratórias (tosse, espirro) ou pelo contato direto com as lesões da pele (geralmente durante a fase ativa da varicela ou zoster). Varicela (catapora) causa erupção cutânea com vesículas e febre, afetando principalmente crianças. Herpes zoster (cobreiro) ocorre quando o vírus reativa, causando erupções dolorosas e inflamação nos nervos em adultos, principalmente em pessoas mais velhas ou imunocomprometidas. O VZV tem a capacidade de persistir no organismo após a infecção primária, ficando latente nos gânglios nervosos. Quando reativado, causa herpes zoster, geralmente em áreas localizadas. A capacidade de evadir o sistema imunológico e se manter latente é uma característica importante da virulência do VZV.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O Herpesvírus varicela-zóster (causador de varicela e herpes zóster) tem baixa persistência no ambiente, sobrevivendo por pouco tempo em superfícies ou no ar. Ele é transmitido principalmente por gotículas respiratórias ou pelo contato com lesões infectadas. O vírus não sobrevive bem fora do corpo humano, sendo essencial a higiene e o uso de precauções para evitar a transmissão.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o Herpesvirus varicellazoster, causador da varicela (catapora) e do herpes-zóster (cobreiro), mostram que a infecção primária (varicela) é comum na infância, com alta taxa de infecção global. Após a varicela, o vírus pode permanecer latente e reativar mais tarde, causando herpes-zóster, especialmente em adultos mais velhos ou imunocomprometidos. Estima-se que cerca de 1 em cada 3 pessoas desenvolverá herpes-zóster ao longo da vida. A vacinação contra varicela e herpes-zóster tem sido eficaz na redução da incidência e complicações associadas a essas doenças.
		Outras informações científicas	O Herpesvirus varicellazoster (VZV) é o vírus causador da varicela (catapora) e do herpes-zóster (cobreiro). Após a infecção primária (varicela), o vírus permanece latente nos nervos e pode se reativar anos depois, causando herpes-zóster, especialmente em adultos mais velhos ou imunocomprometidos. A varicela é altamente contagiosa e causa erupções cutâneas, febre e mal-estar, enquanto o herpes-zóster é caracterizado por erupções dolorosas em um padrão segmentar da pele. A vacinação contra a varicela e o herpes-zóster tem sido eficaz na prevenção dessas doenças, especialmente em crianças e idosos.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus da Influenza tipos A, B e C	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao vírus da Influenza tipos A, B e C ocorre principalmente por meio da inalação de gotículas respiratórias expelidas por uma pessoa infectada ao tossir, espirrar ou falar. A transmissão também pode acontecer pelo contato direto com superfícies ou objetos contaminados, seguidos de toque na boca, nariz ou olhos. Os principais reservatórios dos vírus da Influenza são os seres humanos, além de alguns animais, como aves e suínos, especialmente para o tipo A, que pode ser transmitido entre diferentes espécies
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Gotículas respiratórias: Transmitido principalmente por tosse, espirro ou fala de uma pessoa infectada. Contato direto: Através do contato com superfícies ou objetos contaminados, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Vias de Entrada: Trato respiratório: O vírus entra no corpo pelas vias respiratórias superiores (boca, nariz), ao inalar gotículas contaminadas ou pelo contato com superfícies infectadas.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Os tipos A, B e C de influenza têm formas diferentes de transmissão e gravidade: Tipo A: Transmitido por gotículas respiratórias e de animais para humanos, pode causar gripe grave, com risco de complicações como pneumonia. Tem alta mutabilidade, podendo gerar pandemias. Tipo B: Transmitido de forma semelhante ao tipo A, causa gripe mais leve, com possíveis complicações em populações vulneráveis, e gera surtos sazonais. Tipo C: Causa infecções respiratórias leves, geralmente assintomáticas, com baixa virulência e raramente causa surtos.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Os vírus da Influenza (tipos A, B e C) podem persistir no ambiente por várias horas a dias, especialmente em superfícies contaminadas com secreções respiratórias. A sobrevivência é maior em ambientes frios e úmidos. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias, e medidas de higiene, como lavar as mãos e cobrir a boca ao tossir, são essenciais para prevenir a infecção.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o vírus da Influenza (gripe) mostram que os tipos A e B causam as epidemias sazonais, enquanto o tipo C causa infecções mais brandas. O tipo A é o mais comum e pode causar pandemias, enquanto o tipo B está associado a surtos regionais. O tipo C é menos prevalente e geralmente não causa surtos significativos. A cada ano, a influenza afeta milhões de pessoas globalmente, com um grande número de hospitalizações e mortes, especialmente entre idosos e grupos vulneráveis. A vacinação anual é a principal medida de prevenção.
		Outras informações científicas	O vírus da influenza é classificado em três tipos principais: A, B e C. Influenza A: O tipo mais comum e responsável por pandemias, causa surtos sazonais e pode infectar humanos, aves e outros animais. Possui subtipos com base em proteínas de superfície (hemaglutinina e neuraminidase). Influenza B: Menos variável que o tipo A, geralmente causa surtos sazonais em humanos, mas não gera pandemias. Pode levar a doenças graves, especialmente em idosos e crianças. Influenza C: Causa infecções respiratórias mais leves e é menos comum. Não está associado a surtos ou epidemias. A vacina contra a influenza, atualizada anualmente para cobrir os tipos e subtipos circulantes, é a principal forma de prevenção. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias, e a doença pode ser tratada com antivirais quando detectada precocemente.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Rotavírus humanos	2	Fonte de exposição e reservatórios	Fonte de Exposição: Água e alimentos contaminados: A exposição ocorre principalmente pela ingestão de ovos de Ascaris lumbricoides presentes em alimentos ou água contaminados com fezes de uma pessoa infectada. Reservatórios: Humanos: O único reservatório conhecido de Ascaris lumbricoides são os seres humanos, onde os vermes adultos vivem no intestino e liberam ovos nas fezes.
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Via fecal-oral: A principal forma de transmissão é através da ingestão de alimentos, água ou objetos contaminados com fezes de uma pessoa infectada. Vias de Entrada: Trato gastrointestinal: O vírus entra no corpo principalmente pela ingestão de alimentos ou água contaminados, afetando o sistema digestivo.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via fecal-oral, através do consumo de água ou alimentos contaminados ou pelo contato direto com superfícies ou objetos infectados. Causa gastroenterite grave, caracterizada por diarreia aquosa, vômitos, febre e desidratação, especialmente em crianças pequenas. Pode levar a complicações de desidratação e hospitalização. A virulência do rotavírus está relacionada à sua capacidade de invadir as células intestinais, causando inflamação e danificando o revestimento do intestino, o que leva à perda de líquidos e nutrientes. Além disso, sua resistência a condições ambientais facilita a transmissão.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O rotavírus humano pode persistir no ambiente por vários dias a semanas, especialmente em superfícies contaminadas com fezes. Ele é resistente a condições adversas e pode ser transmitido por via fecal-oral. A higiene rigorosa, como lavar as mãos e desinfetar superfícies, é crucial para prevenir a infecção.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o rotavírus humano indicam que é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos, especialmente em países em desenvolvimento. Antes da introdução da vacina, o rotavírus causava milhões de casos de hospitalização e cerca de 200.000 mortes anuais globalmente. Com a vacinação, as taxas de infecção e hospitalização reduziram significativamente. O rotavírus é transmitido por via fecal-oral e afeta principalmente crianças, mas também pode causar infecção em adultos.
		Outras informações científicas	O rotavírus humano é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos, especialmente em países em desenvolvimento. A infecção pode levar a desidratação severa, que é a principal causa de morte associada ao rotavírus. Estima-se que cerca de 200.000 mortes ocorram anualmente em todo o mundo devido a infecções por rotavírus. A transmissão é fecal-oral, por contato com superfícies ou alimentos contaminados. A introdução de vacinas contra o rotavírus tem reduzido significativamente a incidência e a mortalidade associada à doença. O tratamento é geralmente focado na reidratação e, em casos graves, em cuidados médicos intensivos.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana	3	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) ocorre principalmente por contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada, como sangue, sêmen, fluidos vaginais, secreções anais e leite materno. A transmissão pode ocorrer por meio de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas e seringas, transfusões de sangue contaminado, transplantes de órgãos e de mãe para filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Os principais reservatórios do HIV são os seres humanos, especificamente aqueles com infecção ativa
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Contato sexual desprotegido: Através de relações sexuais com uma pessoa infectada, sem o uso de preservativo. Transmissão vertical: De mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Sangue contaminado: Através do compartilhamento de agulhas ou transfusão de sangue contaminado. Vias de Entrada: Mucosas: O HIV entra no corpo através das mucosas genitais, retal, oral ou por contato com feridas abertas ou lesões na pele, bem como através do sangue.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via sanguínea (compartilhamento de agulhas, transfusões de sangue não testado), via sexual (sexo desprotegido) e de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. O HIV ataca e destrói as células CD4+ do sistema imunológico, levando à imunossupressão. Isso torna o organismo vulnerável a infecções oportunistas e ao desenvolvimento de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), caracterizada por infecções graves e cânceres relacionados à imunossupressão. A virulência do HIV é associada à sua capacidade de mutar rapidamente, evadir o sistema imunológico e se integrar ao DNA das células hospedeiras. A infecção crônica e a perda gradual da função imunológica são características que tornam o HIV altamente virulento e difícil de tratar sem medicamentos antivirais contínuos.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O HIV tem baixa persistência no ambiente, pois é sensível a fatores externos como temperatura, umidade e luz. Fora do corpo humano, ele sobrevive por pouco tempo em superfícies ou no ar. A transmissão ocorre principalmente por contato direto com sangue ou fluidos corporais infectados. A prevenção é baseada no uso de precauções em ambientes de saúde e práticas seguras.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o HIV indicam que cerca de 38 milhões de pessoas vivem com o vírus no mundo, com a maioria dos casos em países da África Subsaariana. O HIV é transmitido principalmente por contato sexual desprotegido, transfusões de sangue e compartilhamento de agulhas. Sem tratamento, pode evoluir para AIDS, enfraquecendo o sistema imunológico. A prevalência de HIV tem diminuído em algumas regiões devido a programas de prevenção e tratamento antirretroviral, que aumentam a expectativa de vida e reduzem a transmissão do vírus. Estima-se que 1,7 milhão de pessoas se infectem anualmente, com 600.000 mortes relacionadas à AIDS.
		Outras informações científicas	O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, enfraquecendo as defesas do corpo e tornando-o mais vulnerável a infecções e doenças. Ele é transmitido principalmente por contato sexual desprotegido, transfusões de sangue e compartilhamento de agulhas. Sem tratamento, o HIV pode evoluir para AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), uma condição onde o sistema imunológico está severamente comprometido. O tratamento com antirretrovirais (TAR) tem sido altamente eficaz, permitindo que as pessoas com HIV vivam por muitos anos com qualidade de vida. Estima-se que 38 milhões de pessoas vivam com HIV no mundo, com mais de 1,7 milhão de novas infecções anuais. Prevenção inclui uso de preservativos, testes regulares e o uso de profilaxia pré-exposição (PrEP).

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Vírus Chikungunya	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao vírus Chikungunya ocorre principalmente pela picada de mosquitos infectados, especialmente o <i>Aedes aegypti</i> e <i>Aedes albopictus</i> . Esses mosquitos se infectam ao picar uma pessoa já infectada pelo vírus. Os principais reservatórios do vírus Chikungunya são os seres humanos, que atuam como hospedeiros, e os mosquitos <i>Aedes</i> , que transmitem o vírus para outras pessoas."
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Picada de mosquitos: Principalmente pelo mosquito <i>Aedes aegypti</i> ou <i>Aedes albopictus</i>, infectados com o vírus. Vias de Entrada: Pele: O vírus entra no corpo através da picada do mosquito, transmitindo-se para a corrente sanguínea.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por mosquitos do gênero <i>Aedes</i> , especialmente <i>Aedes aegypti</i> e <i>Aedes albopictus</i> , por meio da picada de um mosquito infectado. Não é transmitido de pessoa para pessoa diretamente. O vírus causa febre alta, dor nas articulações, erupções cutâneas e, em alguns casos, dor muscular e fadiga. A dor nas articulações pode persistir por semanas ou meses, causando limitação funcional significativa. O vírus Chikungunya tem alta capacidade de se espalhar rapidamente em áreas endêmicas devido à sua transmissão por mosquitos. A dor nas articulações e as complicações podem ser debilitantes, mas o vírus geralmente não causa morte. A virulência está associada à intensa resposta inflamatória e ao impacto nas articulações.
		Persistência do agente biológico no ambiente	O vírus Chikungunya não persiste por longos períodos no ambiente, pois depende da presença de mosquitos <i>Aedes aegypti</i> e <i>Aedes albopictus</i> para transmissão. Fora do corpo humano, sua sobrevivência é limitada. A principal forma de prevenção é o controle dos mosquitos e a eliminação de criadouros.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre o vírus Chikungunya indicam que ele é transmitido por mosquitos <i>Aedes aegypti</i> e <i>Aedes albopictus</i> , e causa febre alta e dores articulares intensas. A doença foi identificada pela primeira vez na África, mas se espalhou para as Américas desde 2013, com surtos significativos na América Latina e no Caribe. Estima-se que milhões de casos tenham ocorrido globalmente, com muitos casos não notificados. A doença é geralmente autolimitada, mas pode causar sequelas articulares em alguns casos. O controle da transmissão depende da eliminação de criadouros de mosquitos.
		Outras informações científicas	O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e o vírus Chikungunya são agentes patogênicos distintos. O HIV afeta o sistema imunológico humano e pode levar à AIDS, enquanto o Chikungunya é um vírus transmitido por mosquitos, causando febre e dores articulares intensas. Embora ambos afetem a saúde humana, eles têm modos de transmissão e impactos diferentes. O HIV é transmitido por fluidos corporais, como sangue e sêmen, enquanto o Chikungunya é transmitido por picadas de mosquitos <i>Aedes aegypti</i> e <i>Aedes albopictus</i> . O tratamento para o HIV envolve terapia antirretroviral, enquanto a infecção por Chikungunya é tratada principalmente com alívio dos sintomas. Ambos representam preocupações significativas para a saúde pública, mas com abordagens distintas para controle e prevenção.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Ancylostoma duodenale	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Ancylostoma duodenale ocorre principalmente pela penetração das larvas presentes no solo contaminado pela pele humana, geralmente pelos pés descalços, ao caminhar em áreas com fezes infectadas. A transmissão também pode ocorrer por ingestão acidental de ovos contaminados. Os principais reservatórios do Ancylostoma duodenale são os seres humanos, que são hospedeiros definitivos do parasita
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Contato com solo contaminado: A principal forma de transmissão ocorre quando as larvas presentes no solo infectado entram em contato com a pele, geralmente pelos pés desprotegidos. Vias de Entrada: Pele: As larvas penetram na pele, principalmente pelos pés, e seguem para o sistema circulatório, chegando aos pulmões e ao trato gastrointestinal.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por meio da larva infectante que penetra na pele humana, geralmente através do contato com solo contaminado, como em áreas com saneamento inadequado. Ancylostoma duodenale causa ancilostomose, uma infecção intestinal que pode levar a anemia devido à perda de sangue, dor abdominal, diarreia e fadiga. A infecção também pode causar lesões na pele (larva migrans cutânea) e problemas respiratórios em casos graves. A virulência é atribuída à capacidade das larvas de invadir a pele, migrar pelos pulmões e se alojar no intestino, onde se fixam à mucosa intestinal e se alimentam de sangue. Isso pode resultar em anemia severa, especialmente em indivíduos com infecção crônica.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Ancylostoma duodenale, um tipo de verme parasita, pode persistir no ambiente por semanas ou meses, especialmente em solo úmido e quente, onde seus ovos e larvas podem se manter viáveis. A infecção ocorre principalmente por contato com solo contaminado. A higiene adequada e o uso de calçados ajudam a prevenir a contaminação.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Ancylostoma duodenale, um tipo de ancilóstomo causador de ancilostomíase, indicam que a infecção é comum em áreas tropicais e subtropicais, especialmente em regiões com condições sanitárias precárias. Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas sejam infectadas globalmente. A transmissão ocorre pela penetração das larvas no pé humano, geralmente em solo contaminado. A infecção pode causar anemia, fadiga e problemas intestinais. O controle é feito através de medidas de saneamento básico, uso de calçados e tratamento com antiparasitários.
		Outras informações científicas	Ancylostoma duodenale é um parasita intestinal que causa a ancilostomíase, uma infecção comum em áreas tropicais e subtropicais. A infecção ocorre quando larvas do parasita penetram na pele, geralmente através do contato com solo contaminado. A ancilostomíase pode causar anemia, fadiga, dor abdominal e crescimento prejudicado em crianças. Estima-se que milhões de pessoas sejam afetadas globalmente, especialmente em regiões com condições sanitárias precárias. O tratamento é feito com antiparasitários, e a prevenção envolve práticas de higiene, como evitar andar descalço e melhorar o saneamento básico.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Ascaris lumbricoides	2	Fonte de exposição e reservatórios	fonte de exposição aoAscaris lumbricoides ocorre principalmente pelo contato com solo contaminado com fezes humanas que contêm ovos do parasita. As larvas do Ascaris lumbricoides podem penetrar na pele humana, geralmente pelos pés descalços, causando infecção. A transmissão também pode ocorrer pela ingestão acidental de ovos presentes no ambiente. Os principais reservatórios do Ascaris lumbricoides são os seres humanos, que são os hospedeiros definitivos do parasita.
		Vias de transmissão e de entrada	
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por via fecal-oral, quando ovos do parasita presentes em fezes contaminam alimentos, água ou superfícies. A ingestão dos ovos infectados leva à infecção. Causa ascaridíase, uma infecção intestinal que pode resultar em sintomas como dor abdominal, náusea, diarreia e tosse (durante a migração larval pelos pulmões). Em casos graves, pode ocorrer obstrução intestinal ou complicações respiratórias. A virulência está relacionada à capacidade das larvas de migrarem pelo corpo, invadindo os pulmões e intestinos, onde amadurecem. A intensa carga parasitária pode levar a complicações, como desnutrição e danos nos órgãos afetados.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Ascaris lumbricoides, um verme parasita, pode persistir no ambiente por meses, especialmente em solo úmido e quente, onde seus ovos permanecem viáveis. A infecção ocorre principalmente pelo contato com solo ou alimentos contaminados. A higiene adequada e o manejo adequado de resíduos ajudam a prevenir a infecção.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Ascaris lumbricoides, o vermes causador da ascaridíase, indicam que cerca de 1 bilhão de pessoas estão infectadas globalmente, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, devido a condições de saneamento inadequadas. A infecção ocorre pela ingestão de ovos do parasita presentes em alimentos ou água contaminados. A maioria dos casos é assintomática, mas infecções pesadas podem causar obstrução intestinal e problemas de crescimento. O controle envolve melhorias no saneamento e tratamento com antiparasitários.
		Outras informações científicas	Ascaris lumbricoides é um verme parasitário responsável pela ascaridíase, uma das infecções intestinais mais comuns em todo o mundo, especialmente em áreas com saneamento básico inadequado. A infecção ocorre pela ingestão de ovos do parasita, presentes em alimentos ou água contaminados. A maioria das infecções é assintomática, mas infecções graves podem causar obstrução intestinal, desnutrição e problemas respiratórios devido à migração das larvas. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas. O tratamento é realizado com antiparasitários, e a prevenção inclui práticas de higiene e melhorias no saneamento.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Giardia lamblia (também conhecida como Giardia intestinalis) ocorre principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita, geralmente provenientes de fontes de água não tratada ou mal filtrada. A transmissão também pode ocorrer por contato direto com fezes de pessoas ou animais infectados. Os principais reservatórios do Giardia lamblia são os seres humanos e animais, como cães, gatos e roedores, que podem servir como fontes de contaminação."
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Via fecal-oral: A principal forma de transmissão ocorre pela ingestão de cistos presentes em alimentos ou água contaminados com fezes de uma pessoa ou animal infectado. Vias de Entrada: Trato gastrointestinal: Os cistos ingeridos liberam trofozoítos no intestino, onde causam a infecção.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por via fecal-oral, principalmente pela ingestão de cistos presentes em água ou alimentos contaminados, ou pelo contato com superfícies contaminadas. A transmissão também pode ocorrer por contato direto com uma pessoa infectada. Causa giardíase, que pode levar a sintomas como diarreia, dor abdominal, náusea, gases e fadiga. A infecção pode ser assintomática ou causar problemas gastrointestinais graves, especialmente em crianças e imunocomprometidos. A virulência de Giardia lamblia está relacionada à sua capacidade de se adere às células intestinais, interferindo na absorção de nutrientes e causando inflamação local. Os cistos resistentes permitem que o parasita sobreviva em ambientes externos e sejam facilmente transmitidos.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Giardia lamblia (ou Giardia intestinalis) pode persistir no ambiente por semanas a meses, especialmente em água contaminada e superfícies úmidas. Seus cistos são bastante resistentes a condições adversas, como cloro e temperaturas baixas. A transmissão ocorre principalmente por ingestão de água ou alimentos contaminados, sendo essencial a higienização e a filtração de água para prevenção.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Giardia lamblia (ou Giardia intestinalis) indicam que é uma das principais causas de diarreia parasitária em todo o mundo, afetando cerca de 200 milhões de pessoas anualmente. A infecção é comum em áreas com saneamento precário, sendo transmitida por ingestão de cistos presentes em água ou alimentos contaminados. A giardíase pode causar diarreia, cólicas abdominais e distúrbios gástricos. O controle depende de acesso a água potável e tratamentos com medicamentos antiparasitários.
		Outras informações científicas	Giardia lamblia (ou Giardia intestinalis) é um protozoário responsável pela giardíase, uma infecção intestinal comum, transmitida principalmente por água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. A infecção pode causar diarreia, cólicas abdominais, náuseas e, em alguns casos, mal-estar geral. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas sejam infectadas anualmente, sendo mais prevalente em regiões com saneamento inadequado. O diagnóstico é feito por exames de fezes e o tratamento é realizado com antiparasitários como metronidazol ou tinidazol. A prevenção envolve melhorias no saneamento, filtragem e desinfecção da água.

Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Trypanosoma cruzi	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas, ocorre principalmente por meio da picada de insetos triatomíneos (conhecidos como 'barbeiros') infectados, que transmitem o parasita através de suas fezes. A transmissão também pode ocorrer por transfusão de sangue contaminado, transplante de órgãos, transmissão de mãe para filho durante a gestação ou o parto, e pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminadas. Os principais reservatórios do Trypanosoma cruzi são os seres humanos e vários mamíferos silvestres e domésticos, como cães, gatos, roedores e outros animais
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Picada do inseto vetor: Transmitido principalmente pela picada de barbeiros infectados, que depositam fezes contaminadas com o parasita na pele do hospedeiro. Transmissão vertical: De mãe para filho durante a gravidez. Transfusão de sangue ou transplante de órgãos: Através de sangue ou órgãos contaminados. Contato com alimentos contaminados: Quando alimentos entram em contato com fezes infectadas de barbeiro. Vias de Entrada: Pele ou mucosas: O parasita entra no corpo principalmente através de feridas na pele ou mucosas, causadas pela picada do inseto vetor ou pelo contato com fezes infectadas.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido principalmente por insetos triatomíneos (barbeiros), que picam uma pessoa infectada e depois transmitem o parasita através de suas fezes, que entram na corrente sanguínea do hospedeiro. Também pode ser transmitido por transfusão de sangue, transplante de órgãos, de mãe para filho (transmissão vertical) e acidentalmente em laboratórios. Causa a doença de Chagas, que pode ter duas fases: Fase aguda: Com sintomas como febre, inchaço nos locais da picada e dor. Fase crônica: Pode causar complicações graves como cardiomiopatia, arritmias cardíacas, megaesôfago e megacólon, resultando em sérias disfunções no sistema digestivo e cardíaco. A virulência do Trypanosoma cruzi está associada à sua capacidade de invadir e se multiplicar em várias células do corpo humano, incluindo células do coração e do sistema digestivo. Sua habilidade de modificar sua forma e evadir o sistema imunológico torna o tratamento e a erradicação mais desafiadores.
		Persistência do agente biológico no ambiente	A persistência do Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas, no ambiente depende principalmente do vetor, o inseto barbeiro (Triatoma spp.), que é responsável pela transmissão. O parasita não sobrevive bem no ambiente externo sem o vetor, pois não é resistente a condições adversas como temperatura extrema ou seca. No entanto, T. cruzi pode ser encontrado em fezes de barbeiros infectados, que contaminam o ambiente e podem infectar seres humanos ou outros animais quando entram em contato com mucosas ou feridas abertas. Além disso, o parasita pode ser transmitido por transfusão de sangue, transplante de órgãos e de mãe para filho. A desinfecção e o controle do vetor são essenciais para reduzir a persistência do Trypanosoma cruzi no ambiente e prevenir a doença.

	Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas, revelam que a infecção afeta aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas, principalmente na América Latina. A transmissão ocorre principalmente pelo vetor triatomíneo (barbeiro), mas também pode acontecer por transfusão de sangue, transplantes de órgãos, ou de mãe para filho. A prevalência é maior em áreas rurais com condições sanitárias precárias, embora o crescimento da urbanização e o aumento da mobilidade humana tenham ampliado a distribuição geográfica da doença. Além disso, mais de 70% das infecções permanecem assintomáticas ou com sintomas leves, o que contribui para a subnotificação e diagnóstico tardio. A fase crônica da doença afeta principalmente o sistema cardiovascular e digestivo, levando a complicações graves em 20-30% dos casos. A introdução de medidas de controle do vetor e programas de triagem neonatal tem contribuído para a redução de casos novos, mas ainda existem desafios em áreas com infraestrutura inadequada.
	Outras informações científicas	Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas, transmitida principalmente pelo inseto barbeiro. A infecção pode ocorrer também por transfusão de sangue, transplante de órgãos ou de mãe para filho. Inicialmente assintomática ou com sintomas leves, a doença pode evoluir para uma fase crônica, afetando o coração (cardiomegalia), o esôfago (megaesôfago) e o cólon (megacólon), podendo levar a complicações graves. A doença de Chagas afeta milhões de pessoas, principalmente na América Latina. O tratamento precoce com antiparasitários como benzonidazol e nifurtimox é eficaz, mas a fase crônica tem opções limitadas. A prevenção envolve controle do vetor e medidas de vigilância em bancos de sangue e transplantes.

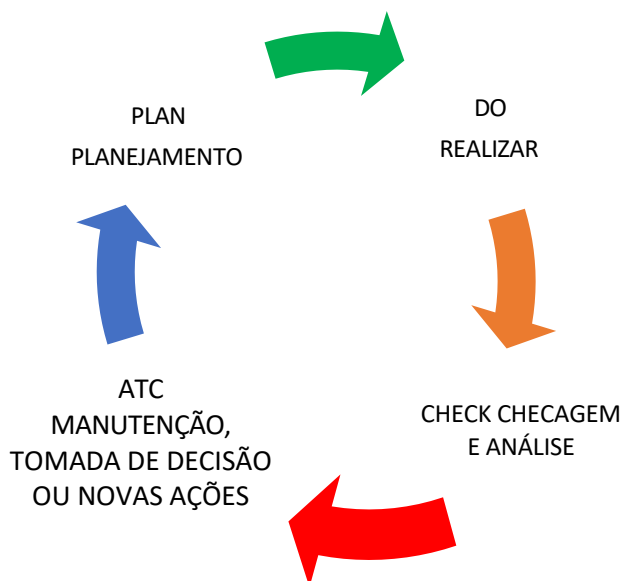
Agente / Patógeno	Classe de Risco (NR 32)	Análise do agente biológico	
Candida albicans	2	Fonte de exposição e reservatórios	A fonte de exposição ao Candida albicans, um fungo que pode causar infecções, ocorre principalmente por contato direto com superfícies contaminadas ou com secreções corporais de uma pessoa infectada, como saliva, secreções vaginais ou fezes. A transmissão também pode acontecer por meio de dispositivos médicos contaminados, como cateteres. Os principais reservatórios do Candida albicans são os seres humanos, onde o fungo pode colonizar mucosas, como a boca, trato gastrointestinal, e órgãos genitais, sem causar sintomas em algumas pessoas, mas podendo se tornar patogênico em condições favoráveis, como imunossupressão ou desequilíbrios na microbiota."
		Vias de transmissão e de entrada	Vias de Transmissão: Contato direto: Transmitido principalmente por contato direto com uma pessoa infectada, especialmente durante relações sexuais. Disseminação endógena: Pode proliferar em áreas do próprio corpo, como na mucosa oral, vaginal ou intestinal, quando o sistema imunológico está comprometido. Vias de Entrada: Mucosas: O fungo entra através das mucosas da boca, genitais ou trato gastrointestinal, geralmente em condições que favorecem seu crescimento, como desequilíbrio da microbiota ou sistema imunológico enfraquecido.
		Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente	Transmitido por contato direto com superfícies ou secreções corporais infectadas, como saliva, urina, fezes ou secreções vaginais. A transmissão também pode ocorrer por uso de dispositivos médicos invasivos, como cateteres, ou por transmissão vertical (de mãe para filho durante o parto). Candida albicans é um fungo oportunista que pode causar candidíase, uma infecção que afeta a boca (candidíase oral), vagina (candidíase vaginal) e a pele. Pode também invadir órgãos internos, como os rins, coração e fígado, em casos de candidíase sistêmica, especialmente em indivíduos com sistema imunológico comprometido. A virulência de Candida albicans é atribuída à sua capacidade de mudar de forma (de levedura para hifa), o que facilita a invasão dos tecidos. Além disso, possui proteínas de adesão que permitem aderir às superfícies celulares e formar biofilmes, dificultando a erradicação.
		Persistência do agente biológico no ambiente	Candida albicans pode persistir no ambiente por períodos variados, especialmente em superfícies úmidas e em materiais orgânicos, como tecidos e roupas. Ela é resistente e pode sobreviver em condições adversas. A transmissão ocorre principalmente por contato direto ou por superfícies contaminadas, sendo a higiene importante para prevenir infecções.
		Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos	Estudos epidemiológicos sobre Candida albicans, um fungo responsável por infecções como candidíase, indicam que ele é um patógeno comum em humanos, afetando especialmente mulheres, com 75% das mulheres apresentando candidíase vaginal em algum momento da vida. Além disso, C. albicans pode causar infecções sistêmicas em pessoas imunocomprometidas, como pacientes com HIV ou em tratamento imunossupressor. Estima-se que as infecções por Candida sejam responsáveis por uma significativa proporção de infecções nosocomiais. O tratamento é realizado com antifúngicos, e a prevenção inclui cuidados com a higiene e controle de fatores de risco.
		Outras informações científicas	Candida albicans é um fungo comensal encontrado naturalmente na flora humana, especialmente na pele, boca, trato gastrointestinal e vaginal. Embora geralmente seja inofensivo, pode causar infecções quando há desequilíbrio no sistema imunológico ou na microbiota, como na candidíase oral, vaginal e sistêmica. Infecções graves podem ocorrer em pessoas imunocomprometidas, como pacientes com HIV ou em tratamento imunossupressor. O tratamento geralmente envolve antifúngicos, como fluconazol. A prevenção inclui boas práticas de higiene e controle de fatores de risco, como diabetes e uso excessivo de antibióticos.

PLANO DE AÇÃO - PDCA

Manual de utilização do plano de ação

5. Com a recente atualização da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) passou a ocupar uma posição estratégica na estrutura de Saúde e Segurança do Trabalho, ele consolida os resultados de todo o processo de identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, estruturando-se com base no ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir) — referência consagrada em sistemas de gestão, tanto obrigatórios quanto voluntários.

Nesse contexto, o Plano de Ações representa um instrumento essencial para o planejamento, execução e monitoramento das medidas de prevenção. Seu objetivo é garantir a eliminação, a redução ou o controle efetivo dos riscos identificados, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. A execução e o acompanhamento das ações serão conduzidos por profissional designado pela empresa, conforme registro detalhado em planilha específica e atualizada periodicamente.



PLANO DE AÇÃO - PDCA

Instruções para Utilização da Planilha de Controle do Plano de Ação

A planilha abaixo foi elaborada para registrar, acompanhar e evidenciar as ações voltadas à atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), conforme estabelece a NR-01. Seu uso está alinhado à metodologia PDCA (Planejar, Executar, Verificar, Agir), permitindo o controle sistemático das ações preventivas adotadas na obra.

A seguir, orientações sobre o preenchimento de cada campo da planilha:

1. Plano de Ação | Prioridade:

Descreva brevemente a ação que será realizada (ex: atualização do PGR para nova fase da obra) e defina a prioridade da atividade (Alta, Média ou Baixa), conforme o nível de urgência e impacto.

2. Plan (Planejar):

Informe quais medidas serão planejadas, quem deverá ser envolvido, quais recursos serão necessários e quais etapas precisam ser organizadas para iniciar a ação.

3. Do (Executar):

Descreva o que será feito na prática para executar o plano, incluindo envio de documentos, comunicações com a equipe técnica, treinamentos ou implementações necessárias.

4. Check (Verificar):

Registre como será feita a verificação da execução da ação. Isso pode incluir o recebimento de documentos, registros de inspeções, reuniões de validação ou qualquer outro método de acompanhamento.

5. Act (Agir/Manter):

Indique como será feita a manutenção contínua da ação, se haverá necessidade de ajustes, revisões periódicas ou implementação de novas medidas com base nos resultados obtidos.

6. Data Prevista:

Informe a data estimada para a conclusão da ação.

7. Data de Início:

Registre a data em que a ação foi efetivamente iniciada.

8. Data de Conclusão:

Preencha com a data real de finalização da ação, quando concluída.

9. Responsável pela Ação:

Especifique o nome completo da pessoa encarregada pela execução e acompanhamento da ação registrada.

10. Observações:

Use este campo para anotar quaisquer informações adicionais que complementem o entendimento da ação, como particularidades da obra, pendências, alertas ou histórico de decisões.

11. Evidência da Ação:

Anexe ou descreva os documentos ou registros que comprovem que a ação foi realizada. Exemplos: Versão do PGR atualizado, protocolos de envio, fotos, Link's de atas de reuniões, e-mails, listas de presença, entre outros.

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ATUALIZAÇÃO DO PGR & GRO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Alinhar com engenheiro e sesmt responsavel pela obra a atualização e novas avaliações para atualização do programa para as novas etapas / fases da obra		
Do (Realizar): Enviar ao engenheiro e cordenadores do documento e gestores de segurança responsaveis	Check (Checagem e Análises): Recebimento do programa digital e fisico	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novas funções sem GHE´s trabalhadores neste.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ELABORAÇÃO DO PCMSO & RENOVAÇÃO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Alinhar com o elaborador do Programa de Gerencimaneto de Riscos PGR o fornecimento do documento base para elaboração do Programa Médico de Saúde Ocupacional		
Do (Realizar): Enviar ao médico coordenador		Check (Checagem e Análises): Verificar o documento e exames
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novos colaboradores		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

REFEITÓRIO (Dimensionamento para o efetivo) de acordo NR-18 e 24		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Realizar projeto e executar prevendo o refeitório coberto, dimensionado com área compatível com o nº de trabalhadores, mesas com tampo lisos, cadeiras/bancos suficiente. Lavatório, sabão, papel toalha, lixeira com tampa separado por classe de resíduos. Fazer as instalações em conformidade com projeto e com a NR-18 e NR-24		
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual		Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Início: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ÁGUA POTÁVEL			Plano de Ação Prioridade: alta		
Plan (Planejar): Planejar a estrutura e prover de bebedouro tipo freezer nas dependências ou proximidades do refeitório, e um tipo jato inclinado na frente de serviço. Bebedouro tipo jato, 1 para cada grupo de 25 trabalhadores ou a cada 5 pavimentos de acordo a NR-18 e NR-24					
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual			Check (Checagem e Análises): Inspeccionar periodicamente		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar aos locais se necessário e manter sempre atualizado					
Data Prevista: ____/ ____/ ____		Data de Início: ____/ ____/ ____		Data de Conclusão: ____/ ____/ ____	
Responsável pela Ação:					
Observações:					
Evidencia da Ação:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

CONTRATAÇÃO E REGISTRO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Verificar aplicabilidade do SESMT – NR 04		
Do (Realizar): Prover de tecnico de segurança para o empreendimento. Exigir registro no sesmt	Check (Checagem e Análises): Inspeccionar periodicamente	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Dar baixa quando desligado do empreendimento e refazer registro do novo profissional		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe no ato da admissão/indicação em cada GHE.		
Do (Realizar): Realizar capacitações conforme citado		Do (Realizar): Realizar capacitações conforme citado
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO SPCQ/SPIQ (VERIFICAR APLICABILIDADE NR 18/35)		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe no ato da admissãoverificando aplicabilidade e projetos		
Do (Realizar): Realizar treinamento com todas uma vez que a empresa não possui equipe especifica	Do (Realizar): Realizar treinamento com todas uma vez que a empresa não possui equipe especifica	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaborares não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

CAPACITAÇÃO – NORMA REGULAMENTADORA 10, CURRÍCULO BÁSICO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar o treinamento para equipe de eletricistas, funções expostas ao ponto energizado ou zona de risco e envolvidos		
Do (Realizar): Realizar treinamento		Do (Realizar): Realizar treinamento
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Reciclagem a cada 2 anos ou de acordo demais itens normativos e de acordo a necessidade. Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Início: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

TREINAMENTO DE DIREÇÃO DEFENSIVA		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe que se desloca da obra. (mesmo que eventual)		
Do (Realizar): Realizar treinamento		Do (Realizar): Realizar treinamento
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar diariamente a estocagem dos materiais e separação dos mesmos.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS			Plano de Ação Prioridade: alta		
Plan (Planejar): Implantar eTreinar gestores das equipes para aplicar com suas equipes na prevenção dos acidentes e demais envolvidos					
Do (Realizar): Semanal (sugestão), por tipo de atividade e risco ou conforme			Do (Realizar): Semanal (sugestão), por tipo de atividade e risco ou conforme		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Sempre que iniciar a semana ou uma nova atividade					
Data Prevista: ____/ ____/ ____		Data de Inicio: ____/ ____/ ____		Data de Conclusão: ____/ ____/ ____	
Responsável pela Ação:					
Observações:					
Evidencia da Ação:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

PT – PERMISSÃO PARA O TRABALHO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Para toda atividade de risco NÃO ROTINEIRA		
Do (Realizar): Concretagens, montagem e desmontagem de bandejas e outras.	Do (Realizar): Concretagens, montagem e desmontagem de bandejas e outras.	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais, recapacitar os colaboradores se necessário e manter sempre atualizados		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ANÁLISE, ESCOLHA E VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA O SISTEMA DE ANCORAGEM PARA SPCQ E SPIQ <i>Plano de Ação Prioridade: alta</i>		
Plan (Planejar): Projetar de forma a atender todas as atividade ou situações com risco de queda de altura.		
Do (Realizar): Instalação por equipe treinada e capacitada	Do (Realizar): Instalação por equipe treinada e capacitada	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar projetos, estruturas e locais se necessário e manter sempre atualizado		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Instalação de extintor ABC nas proximidades das instalações sanitarias (banheiro, vestiário, sanitários), no refeitório, próximo as salas administrativas, nos setores das máquinas e equipamentos e para acompanhar as concretagens devidamente sinalizado e identificado. Verificar aplicabilidades no PRE.			
Do (Realizar): Realizar para cada setor		Do (Realizar): Realizar para cada setor	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado			
Data Prevista: ____/____/____	Data de Início: ____/____/____		Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:			
Observações:			
Evidencia da Ação:			

PLANO DE AÇÃO - PDCA

PIE – PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ LAUDOS DE ATERRAMENTO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROVISÓRIAS <i>Plano de Ação Prioridade: alta</i>		
Plan (Planejar): Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos antes do início das atividades.		
Do (Realizar): Realizar conforme normas e leis vigentes		Do (Realizar): Realizar conforme normas e leis vigentes
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais se necessário e manter sempre atualizado		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO - AET <i>Plano de Ação</i> <i>Prioridade: alta</i>		
Plan (Planejar): Cotar por etapa, levantamento em campo e planejamento das diretrizes da NR 17.		
Do (Realizar): Executar o documento e planos ação	Do (Realizar): Executar o documento e planos ação	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Analisar efetividade anualmente na revisão do documento.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

REALIZAR O PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS/ RESPOSTA A EMERGÊNCIAS PRE		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Cotar o plano para a etapa atual – simulados e práticas com acidentes mais comuns nessa etapa.		
Do (Realizar): Realizar plano e capacitação		Do (Realizar): Realizar plano e capacitação
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter equipe de resposta conforme margeado pela obra em número suficiente conforme NT 17 e plano atualizado.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABAHO - LTCAT			Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar as avaliações quantitativas para os agentes físicos e químicos.			
Do (Realizar): por grupo homoganeo		Do (Realizar): por grupo homoganeo	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Revisar de acordo com novos GHE´s ou estratégia do elaborador.			
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____	
Responsável pela Ação:			
Observações:			
Evidencia da Ação:			

PLANO DE AÇÃO - PDCA

SINALIZAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta		
Plan (Planejar): Sinalização de conscientização a saúde e higiene pessoal, limpeza, organização, alerta aos riscos biológicos, prevenção de acidentes com as instalações sanitárias, piso escorregadio, choques elétricos, setores e demais departamentos de acordo com a NR18.					
Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual			Do (Realizar): Realizar margeando pico máximo na etapa atual		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar aos locais se necessário e manter sempre atualizado					
Data Prevista: ____/____/____		Data de Início: ____/____/____		Data de Conclusão: ____/____/____	
Responsável pela Ação:					
Observações:					
Evidência da Ação:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

PROTEÇÃO SOLAR Plano de Ação Prioridade: alta		
Plan (Planejar): Fornecer protetor solar e camisa de uniforme com manga longa		
Do (Realizar): Protetor solar manter disponível nas frentes de serviços.		Do (Realizar): Protetor solar manter disponível nas frentes de serviços.
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Repor, trocar, substituir sempre que necessario		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ORGANIZAR E DISPOR DE FORMA IDENTIFICAVEL OS MATERIAIS DO ALMOXARIFADO		Plano de Ação / Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar organizaçãoe identificação dos materiais do almoxarifado.		
Do (Realizar): Manter os materiais separados e identificados	Do (Realizar): Manter os materiais separados e identificados	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar a disposição com frequência determinada pela gestão da obra.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ORGANIZAR E DISPOR DE FORMA IDENTIFICAVEL OS MATERIAIS DO ALMOXARIFADO		Plano de Ação / Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar organizaçãoe identificação dos materiais do almoxarifado.		
Do (Realizar): Manter os materiais separados e identificados		Do (Realizar): Manter os materiais separados e identificados
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Verificar a disposição com frequência determinada pela gestão da obra.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ORGANIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção para cobrar a organização		
Do (Realizar): Manter os locais de acesso desobstruído		Do (Realizar): Manter os locais de acesso desobstruído
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Aplicar medidas administrativas caso não evidencie a limpeza do mesmo (recomendação)		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Início: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ORDEM DE SERVIÇO		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Verificar funções e antecipar a elaboração de ordem de serviços conforme PGR e NR 01.		
Do (Realizar): Montar e manter arquivadas		Check (Checagem e Análises): Validar as informações contidas
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Início: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

CONSULTAR OS TRABALHADORES SOB PERCEPÇÃO DE RISCO (CIPA E AFINS) – NR 01		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Verificar formulário e realizar de forma individual ou traçar espaço amostral		
Do (Realizar): Fornecer e realizar a consulta com o formulário Ver NR 01 item 1.5.3.3 Ver na 1ª contratação	Do (Realizar): Fornecer e realizar a consulta com o formulário Ver NR 01 item 1.5.3.3 Ver na 1ª contratação	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

OBRAR USO DE EPI DE TRABALHADORES PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção sobre o uso.		
Do (Realizar): Entregar e cobrar o uso do EPI		Do (Realizar): Entregar e cobrar o uso do EPI
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Aplicar advertência verbal ou medidas disciplinares caso não evidenciado o uso.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

ADEQUAR MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO CONFORME NR 17 / VERIFICAR APLICABILIDADE DA AET		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Cotar e realizar análise ergonomica do trabaho AET.		
Do (Realizar): Seguir o que está previsto na AET		Do (Realizar): Seguir o que está previsto na AET
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se inadequada, ajustar mobiliário		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Verificar indicação e manter caixa de primeiros socorros em conformidade mínima com PCMSO e Plano de Ação Emergencial.		
Do (Realizar): Realizar aquisição e posicionar de forma estratégica		Do (Realizar): Realizar aquisição e posicionar de forma estratégica
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA TRABALHO EM ALTURA		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Cotar, manter ou atualizar (caso a empresa já possua)		
Do (Realizar): Validar, anexar a este e treinar equipe.		Do (Realizar): Validar, anexar a este e treinar equipe.
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Embargar as atividades em caso de risco grave e eminente e manter frequência diária de inspeção.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12/ 18 e anexada a este ou em pasta específica. Realizar checagem e procedimentos de segurança antes da atividades com as eletroportáteis.		
Do (Realizar): Montar e manter em conformidade conforme normas citadas acima.	Do (Realizar): Montar e manter em conformidade conforme normas citadas acima.	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova avaliação, manutenção e/ou em caso de mudança de layout/localização, adequação.		
Data Prevista: ____/ ____/ ____	Data de Inicio: ____/ ____/ ____	Data de Conclusão: ____/ ____/ ____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

PLANO DE AÇÃO - PDCA

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		Plano de Ação Prioridade: alta
Plan (Planejar): Analisar GHE's e necessidades específicas das avaliações		
Do (Realizar): Realizar (podendo ser utilizadas do LTCAT)		Do (Realizar): Realizar (podendo ser utilizadas do LTCAT)
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.		
Data Prevista: ____/____/____	Data de Inicio: ____/____/____	Data de Conclusão: ____/____/____
Responsável pela Ação:		
Observações:		
Evidencia da Ação:		

ANEXO 1

LISTAGEM DE EPIs

A descrição apresentada dos EPIs é genérica, sendo uma lista não taxativa para as empresas clientes, as imagens usadas são apenas ilustrativas e também não será discriminado os CAs, ficando a cargo das empresas clientes todo o processo de EPIs: seleção, compra, treinamento, dispensação e controle.

- MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA

Descrição: Confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltblown fitesa, filtragem de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias, pregueada, com clips nasal e tiras hipoalérgica garantindo boa ventilação.



- BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR

Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com biqueira de polipropileno para conformação e com absorção de energia no calcanhar.



- LUVA DE PROCEDIMENTO

Desenvolvida com látex de borracha 100% natural, a Luva de Procedimento de Látex com Pó Medix.



- BOTINA PVC CANO MÉDIO OU LONGO

Descrição: Bota Profissional em PVC na cor branca, cano médio, sem forro e sem biqueira.



- CAPA DE CHUVA

Descrição: Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC forrado, com mangas, capuz fixo, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica.



- CAPACETE

Descrição: Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através de ajuste simple ou catraca. Pode possuir tira de absorção de suor fixada à carneira.



- TOUCA DE PROCEDIMENTO

A Touca Sanfonada Descartável confeccionada feita em TNT(Tecido Não Texturizado) 100% polipropileno (microfibras desorientadas), fitas elásticas (30% látex vegetal e 70% poliéster sintético ou 60% elastodieno e 40% poliéster) e/ou filamentos de poliéster texturizados. Dessa forma sendo impermeável e resistente à umidade, abrasão e à ação de fungos e bactérias..



- CINTO TIPO PARAQUEDISTA

Descrição: Cinturão de segurança, tipo paraquedista, fabricado em tira de poliéster, com duas alças reforçadas do mesmo material na altura do peito para ancoragem e duas alças nas laterais do cinturão para apoio de ferramentas. Fivelas duplas fabricadas em aço, formato retangular de engate rápido para ajuste, localizadas na tira das pernas, nas tiras do suspensório e na tira da cintura. Meia argola localizada na parte dorsal do cinturão fabricada em aço forjado e passador dorsal fabricado em plástico. Tira de ajuste peitoral fabricada em material sintético preto, com fechamento através de fecho plástico de engate rápido ou fechamento através de argolas metálicas.



- TALABARTE EM Y

Descrições: Fita de poliéster, dois conectores classe “A” em alumínio com abertura de 110 mm, um conector classe “B” em aço, com abertura de 20 mm, ambos conectores com dupla trava de segurança, absorvedor de energia e comprimento 1,35 m



- COLETE REFLETIVO

Descrição: Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.



- LUVA ANTI VIBRAÇÃO

Descrição: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overlock.



- LUVA DE RASPA CANO LONGO

- LUVA DE VAQUETA

Descrição: : Luva de segurança com o dorso confeccionado em couro bovino tipo raspa e palma confeccionada em couro tipo vaqueta, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre dedos anelares, acabamento com viés, costura com linha de nylon.



- LUVA MULTITATO

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas



- LUVA LÁTEX RANHURADA

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhuras no punho.



- LUVA NITRÍLICA

Descrição: Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.



- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, Classe "S" PFF2, confeccionada de TNT, com ou sem válvula de exalação, formato dobrável.



- ÓCULOS DE SEGURANÇA

Descrição: Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos.



- PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA

Descrição: Protetor Auditivo do tipo concha, constituído por dois abafadores, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui duas hastes em plástico que se encaixam no arco e na concha.



- PROTETOR AURICULAR MUFFLER Acoplável ao Capacete

Descrição: Protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico rígido, preenchidas com espuma de poliuretano e com bordas revestidas e almofadas de material plástico, preenchidas com espuma; as conchas são fixadas à duas hastes plásticas móveis (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco do capacete.



- PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG

Descrição: Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em copolímero. Atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.



FORMULÁRIO 01 - EMPRESA TERCIEIRIZADA - DOCUMENTAÇÃO INICIAL

Dados cadastrais do terceirizada	
----------------------------------	--

Pag. de

Empresa Terceirizada:

CNPJ	
------	--

Data de início dos trabalhos

Endereço

Nome do responsável pela empresa terceirizada

Telephone

E-mail

Controle da documentação inicial PGR; PCMSO; LTCAT; LIP	
--	--

Descrição do		Data de			
--------------	--	---------	--	--	--

Descrição do documento	Versão	Data de validade	Nome do RT e Registro	Responsável pelo recebimento	Data recebimento
PGR					
PCMSO					
LTCAT					
LIP					

Controle da documentação de rotina (Admissão) ASOs admissionais; Ficha inicial de EPIs	
---	--

Documento	Nome do trabalhador	Responsável pelo recebimento	Data recebimento
-----------	---------------------	------------------------------	------------------

[illegible]

FORMULÁRIO 02 - EMPRESA TERCIEIRIZADA - DOCUMENTAÇÃO MENSAL

Dados cadastrais do terceirizada	
Nome	____
CPF	____
RG	____
Endereço	____
Cidade	____
Estado	____
CEP	____
Telefone	____
E-mail	____
Assinatura	____

Pag. de

Empresa Terceirizada:

Endereço

CNPJ	
------	--

Data de início dos trabalhos

E-mail

Controle da documentação mensal	
ASOs; Atestados médicos; Fichas de EPLs atualizadas; Eventos 2210 enviados (CAT)	

Documento	Nome do trabalhador	Responsável pelo recebimento	Data recebimento
-----------	---------------------	------------------------------	------------------

[illegible]

FORMULÁRIO 03 - EMPRESA TERCEIRIZADA - EVIDÊNCIAS

Dados cadastrais do terceirizada

Pag. de

Empresa Terceirizada:

Endereço

CNPJ

Data de início dos trabalhos

Nome do responsável pela empresa terceirizada

Telefone

E-mail

Evidências objetivas da integração da gestão de SST dos terceiros

Listas de presenças em treinamentos e DDSs; Fotos de ações de SST; advertências de não uso de EPIs ou desobediência de procedimentos de segurança

[illegible]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250271948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA

RNP: **1016723644**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Registro: **1016723644D-GO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás**

CPF/CNPJ: **36.863.637/0001-59**

Rua C136, Nº 681

Bairro: Jardim América

CEP: 74275-050

Quadra: 307 Lote: 20 e 21

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail: coord.seguranca@seconcigoias.com.br

Fone: (62)3250-7544

Contrato: 01

Celebrado em: 09/09/2025

Valor Obra/Serviço R\$: 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua C136, Nº 681

Bairro: Jardim América

CEP: 74275-050

Quadra: 307 Lote: 20 e 21

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

Data de Início: 09/09/2025

Previsão término: 09/09/2027

Coordenadas Geográficas: -16.7116458,-49.2813694

Finalidade: **Comercial**

Proprietário(a): **Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás**

CPF/CNPJ: **36.863.637/0001-59**

E-Mail: coord.seguranca@seconcigoias.com.br

Fone: (62) 3250-7544

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

LAUDO TECNICO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

Quantidade

Unidade

LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

1,00

UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de ____ de ____
Local Data

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás -
CPF/CNPJ: 36.863.637/0001-59

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 103,03	Registrada em 19/09/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125264831	Situação Registrada/OK		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------	-------------------